



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN MEI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 4

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 10

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 10

3.3.2 Rawat Inap 12

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 18

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 19

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 21

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 22

3.4.1 Instalasi Farmasi 22

3.4.2 Laboratorium 25

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 27

3.4.4 Radiologi 29

3.4.5 Gizi 32

3.4.6 CSSD - Laundry 34

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan 36

3.5.1 SDM 36

3.5.2 MFK dan K3RS 44

3.5.3 Security 48

3.5.4 Parkir 50

3.5.5 Humas Marketing 50

3.5.6 Penjaminan 53

3.5.7 PIPP – MOD - MPP 54

3.5.8 *Cleaning Service* 60

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 60

3.6 Komite dan Tim 62

3.6.1 Komite Mutu 62

3.6.2 Komite PPI 92

3.6.3 Tim PKRS 101

3.6.4 Tim Prognas 104

3.6.5 Tim PPRA 142

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 146

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 147

3.8 Profil SDM 153

Bab IV Kesimpulan dan Saran 156

Bab V Penutup 157

LAMPIRAN 158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Mei Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



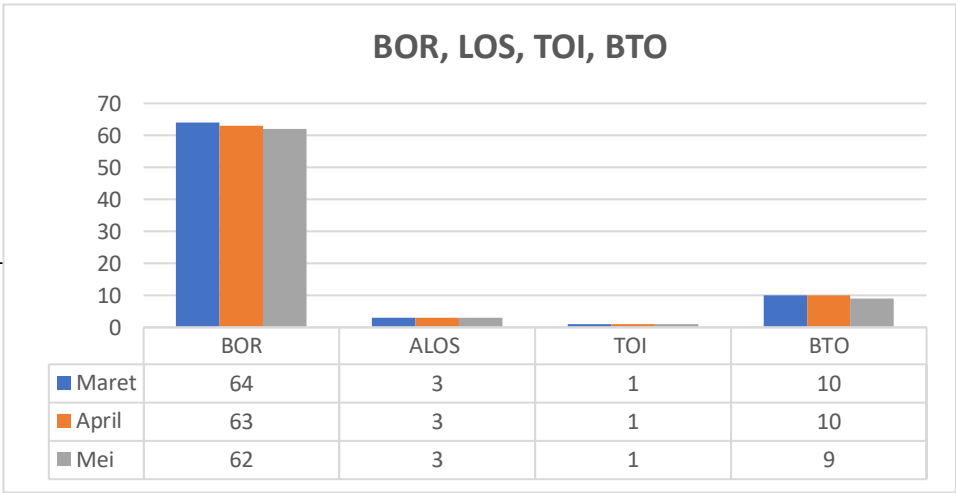
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

NO	INDIKATOR	MARET	APRIL	MEI
1	BOR	64	63	62
2	ALOS	3	3	3
3	TOI	1	1	1
4	BTO	10	10	9

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

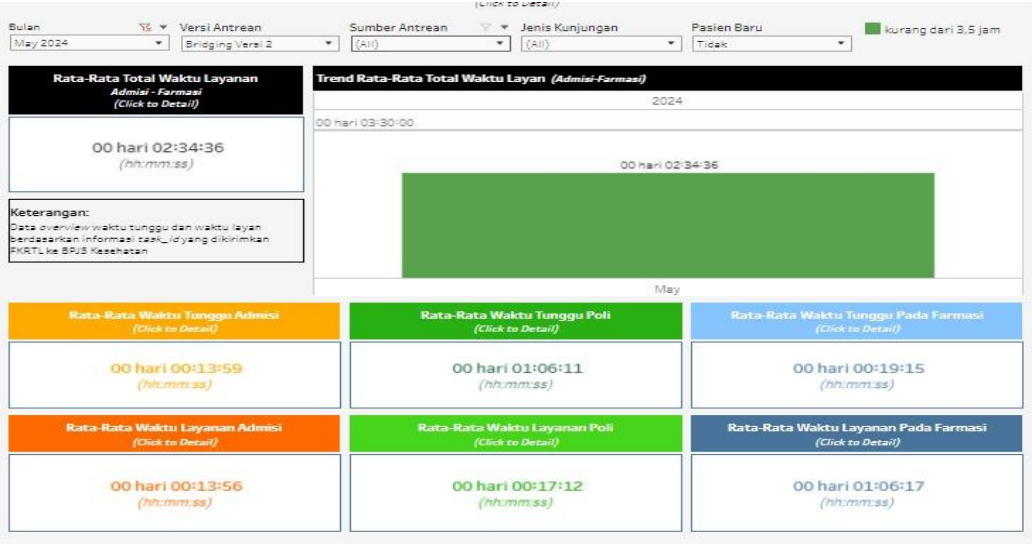


3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

Nilai BOR bulan Mei 2024 sudah mencapai nilai ideal (>60%) namun terdapat penurunan dibanding 2 bulan sebelumnya, sebesar 1,5%. Namun penurunan ini tidak signifikan karena terjadi peningkatan jumlah rawat inap dari IGD dibanding bulan sebelumnya. Penurunan ini dapat dikarenakan karena jumlah hari di bulan Mei lebih banyak sehingga pembagi lebih besar.

Nilai ALOS masih belum memenuhi standar (6-9 hari), masih tetap pada 3 hari, hal ini dikarenakan pasien di RS Prima Husada malang mayoritas dengan jaminan BPJS Kesehatan, dimana diperlukan suatu kendali mutu kendali biaya agar plafon tercukupi, sehingga jika pasien sudah stabil pasien dapat segera dipulangkan. Nilai TOI sudah mencapai nilai ideal sedangkan nilai BTO mengalami penurunan.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN			
	Waktu Rata-Rata	Feb 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1	Total Waktu Layanan	02.16.59	02.25.23	02.25.44	02.34.36
2	Waktu Tunggu Admisi	00.14.35	00.23.18	00.13.51	00.13.59
3	Waktu Layanan Admisi	00.05.38	00.13.19	00.12.01	00.13.56
4	Waktu Tunggu Poli	01.03.08	00.54.20	00.59.19	01.06.11
5	Waktu Layanan Poli	00.14.49	00.15.46	00.15.57	00.17.12
6	Waktu Tunggu Farmasi	00.15.24	00.21.43	00.20.10	00.19.15
7	Waktu Layanan Farmasi	00.52.15	01.02.57	01.00.20	01.06.17

Analisis :

Pada Bulan Mei 2024, total waktu layanan meningkat dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Peningkatan ada di waktu tunggu dan layanan poli dan waktu layanan farmasi.

Peningkatan waktu layanan farmasi disebabkan oleh penumpukan jumlah resep dari poli, dimana beberapa resep masuk dalam satu waktu di Poli yang sama, sehingga penyiapan obat menumpuk.

Setelah obat selesai disiapkan tidak ada pos pengecekan obat selesai sehingga obat langsung diserahkan terimakan ke petugas konseling, dimana petugas memanggil pasien sekalian melakukan cek kesesuaian obat dengan inputan resep/apotek online, jika sesuai dan diterima oleh pasien, petugas klik obat diterima dan pasien melakukan tanda-tangan sebagai bukti verifikasi

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke unit
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan faktor yang mempengaruhi.
Study	Data rekap lima bulan yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi ka unit 2. Monitoring evaluasi 3. Supervisi kabit

NO	JENIS	TARGET	FEB '24	MAR 24	APR 24
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	36.34%	34.86%	37.2%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	96.21%	94.57%	96.2%

Analisis :

Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan

Plan	Mempertahankan hasil bulan April dan meningkatkan untuk kinerja
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki mulai diperbaiki.

Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit
---------------	---

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 1 minggu 3x. Sudah ada SOP	Kendala pengembangan ini jika di ruangan crowded tidak ada yang menemani pendampingan doa
2	IRNA	Senam hamil dan hypnobirthing	Untuk senam hamil sudah berjalan tetapi untuk hynobithing belum berjalan	Hypnobirthing belum berjalan karena terkendala jumlah SDM yang kurang
3	IRNA	Foto bayi	Sudah berjalan dengan baik, respon keluarga pasien juga baik	-
4	IRJA	Poli Eksekutif	Progress 95%. DPJP sudah ready	Menunggu beberapa sarana-prasana yang belum datang. Akan dibuka di Minggu kedua Juni 2024.
5	IGD	Pemutaran Edukasi Triage di IGD	Sudah diputar secara berkala	20% pasien masih ada yang belum paham mengenai sistem triage, hal ini dapat disebabkan karena pasien tidak focus mendengarkan edukasi tentang triag e tersebut
BIDANG UMUM DAN KEUANGAN				
1	Humas & Marketing	1. MCU	Bertahap dalam setiap bulan mengunjungi perusahaan untuk deal	1. Belum memiliki kontak seluruh perusahaan 2. Kunjungan belum rutin 3. Tarif MCU masih tinggi

				dibanding kompetitor
		2. Digital Marketing	Upgrading jenis konten setiap bulan	Belum ada skill khusus tentang digital marketing
2	SDM	1. Konseling	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Waktu pelaksanaan masih bertabrakan dengan pekerjaan lain
		2. Supervisi	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Belum dijadwalkan rutin
		3. Penegakan Tata Tertib	Sudah dilakukan namun belum rutin sesuai target	Waktu pelaksanaan masih bertabrakan dengan pekerjaan lain (penyesuaian SDM baru)
3	CS	1. Penambahan trolley kerja Cleaning Service	Belum terealisasi	Di pengadaan
		2. Pengajuan ruang penyimpanan matras tiap area	Belum terealisasi	Untuk tempat belum di tentukan
		3. Pengajuan bursak matras yang tidak layak dan potong menjadi 1 ukuran	Belum terealisasi	Sudah di sampaikan tapi tidak segera di TL oleh pengadaan
		4. Pengajuan ruang penyimpanan inventaris hall (kursi,meja,taplak,sarung kursi)	Belum terealisasi	Masih di tentukan untuk tempat
		5. Pengajuan alat pembersih kaca magnet	Belum terealisasi	Masih di ajukan
		6. Penambahan tong sampah non medis	Belum terealisasi	Masih di ajukan untuk penambahan
4	Security	1. Penertiban Jam Berkunjung Pasien	Terealisasi dengan adanya tambahan personel memudahkan untuk patrol dan adanya pengumuman dengan rekaman suara	Anak-anak dibawah usia 12 tahun masih ada yang masuk ke ruang irna karena alasan tertentu
		2. Kartu Tanda Penunggu Pasien	Sudah diajukan	Dalam proses. Tidak ada kendala
5	IT SIMRS	1. Peremajaan Komputer di Unit	Sudah dilakukan bertahap	Tidak ada kendala. Menunggu

				instruksi pengadaan
		2. Instalasi ruang server baru dan server backup	Sudah dilakukan bertahap	Tidak ada kendala
BIDANG PENUNJANG				
1	Depo Farmasi	1. Website Primantara	Proses penyelesaian oleh Programmer PT	Dalam proses
		2. Open Recruitmen Admin Primantara	ABK sudah diajukan ke HRD Rumah Sakit.	Dalam proses
		3. TTD elektronik semua pasien rawat jalan, baik pasien IGD maupun rawat inap	Follow up programmer	Menunggu programmer
		4. Fitur Iterisasi pada SIMRS	Fitur sudah tersedia di SIMRS, SPO sudah ACC Direktur RS.	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi.
		5. Pendistribusian obat ke ruangan.	Masih menggunakan system UDD dengan penyiapan obat di malam hari.	Monitoring dan Evaluasi selama seminggu.
2	Gudang Farmasi	Repack sediaan farmasi sharing dose	1. Sudah pengajuan barang penunjang yang dibutuhkan 2. Proses pengajuan Lemari Asam 3. Proses pengajuan tarif repack sesuai list	Belum dijalankan Menunggu barang penunjang datang seluruhnya
3	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA)	Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses memasukan form kedalam aplikasi	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis.

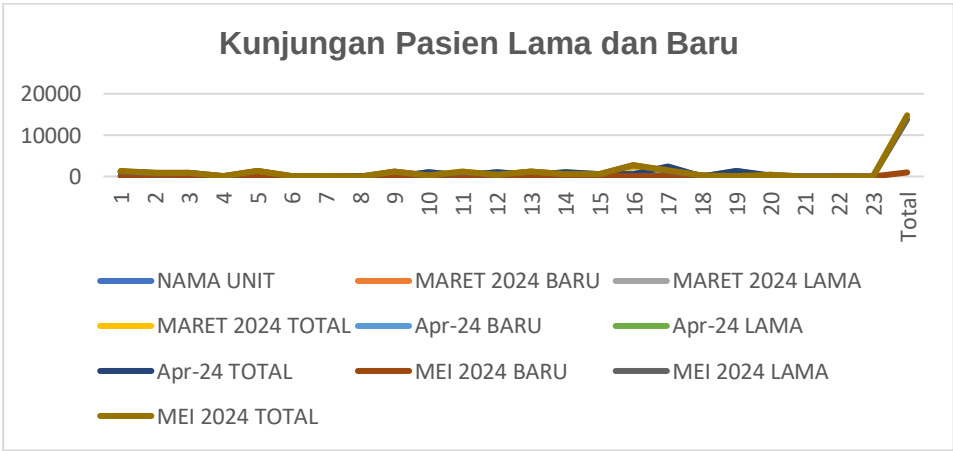
			SIMRS.	
		2. Serah terima DRM menggunakan system digital.	Serah terima menggunakan spreadsheet.	Monitoring dan Evaluasi
		3. Permintaan form menggunakan sistem digital.	Permintaan form dari unit menggunakan google form.	Berjalan mulai Bulan Juni 2024.
4	Radiologi	Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil radiograf dapat diakses	Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer
5	Laboratorium	1. Pengadaan LIS	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam proses
		2. Pengadaan BDRS	Masuk kedalam proker	Follow up Direksi PT
6	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilitator (steam plasma)	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf dan mata
		2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form.	Belum terealisasi	Proses dibuatkan alur dan digital form, target Juni berjalan.
7	Laundry	Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg	Belum terealisasi	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	MARET 2024			APRIL 2024			MEI 2024		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	204	999	1203	76	1095	1171	92	1214	1306
2	IGD	269	588	857	317	599	916	246	645	891
3	Klinik Bedah	132	652	784	48	786	834	54	823	877
4	Klinik Bedah Plastik	8	5	13	1	20	21	4	31	35
5	Klinik Fisioterapi	88	1191	1279	4	1027	1031	3	1273	1276
6	Klinik Gigi Periodonti	19	20	39	3	16	19	8	39	47
7	Klinik Gigi Spesialis	2	1	3	8	13	21	7	22	29
8	Klinik Ibu dan Anak	13	1	14	0	0	0	0	14	14
9	Klinik Jantung	64	954	1018	1	13	14	22	1145	1167
10	Klinik Jiwa	16	204	220	15	1074	1089	10	310	320
11	Klinik Kandungan	202	999	1201	7	261	268	146	1091	1237
12	Klinik Kulit dan Kelamin	120	316	436	104	965	1069	56	382	438
13	Klinik Mata	146	1080	1226	37	306	343	82	1132	1214
14	Klinik Orthopedi	95	411	506	48	1010	1058	16	541	557
15	Klinik Paru	49	380	429	15	505	520	23	504	527
16	Klinik Penyakit Dalam	234	2191	2425	14	481	495	58	2663	2721
17	Klinik Syaraf	154	1284	1438	48	2369	2417	38	1409	1447
18	Klinik THT	92	126	218	0	0	0	51	183	234
19	Klinik Umum	16	2	18	32	1315	1347	25	12	37
20	Klinik Urologi	81	280	361	55	158	213	35	381	416
21	Klinik gigi anak	-	-	-	-	-	-	1	0	1
22	Gizi	6	-	6	5	-	5	8	-	8
23	Bedah Saraf	-	-	-	-	-	-	0	8	8
Total		14287	4334	11954	900	12358	13258	977	13822	14799



Analisis :

- 1. Kunjungan di Bulan Mei naik dari bulan-bulan sebelumnya, sebanyak 10,4% dari bulan April. Baik dari kunjungan pasien baru maupun kunjungan pasien lama.
- 2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2721 pasien. Kunjungan tersebut naik dari bulan sebelumnya sebanyak 2425 pasien, karena dokter penyakit dalam tidak ada libur atau cuti

- Kunjungan terendah adalah klinik gigi anak. Karena di klinik gigi anak masih belum di lakukan kredensialing sehingga tidak dapat melayani pasien BPJS dan hanya melayani pasien umum dan asuransi saja.
- Kunjungan rawat jalan IGD relative masih terlalu tinggi meskipun menurun dari bulan sebelumnya.

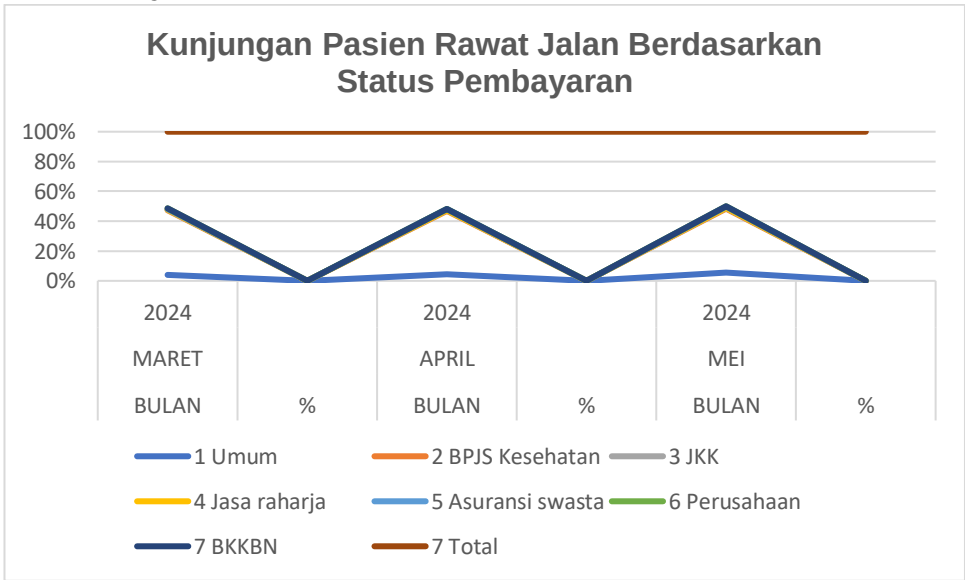
Rencana Tindak Lanjut :

- Terus meningkatkan jumlah kunjungan poli rawat jalan dengan meningkatkan pelayanan dan kepuasan pasien serta
- Terus melakukan promosi melewati humas marketing untuk ke perusahaan dan asuransi di lihat dengan meningkatnya yang mencapai 100% di status pembayaran asuransi dan JKK
- Koordinasi dengan FKTP terkait kriteria kegawat daruratan pasien yang harus di rujuk sehingga dapat di layani untuk rawat inap.
- Rencana di ajukan pembukaan poli umum untuk pasien- pasien umum atau asuransi yang membutuhkan pelayanan dokter umum akan tetapi tidak emergency

4.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN MARET 2024	%	BULAN APRIL 2024	%	BULAN MEI 2024	%
1	Umum	1109	7,4%	1098	8,1%	1640	11,08%
2	BPJS Kesehatan	12556	84,59%	10970	82,47%	12689	85,73%
3	JKK	95	0,64%	95	0,7%	147	0,99%
4	Jasa raharja	16	0,01%	17	0,01%	10	0,07%
5	Asuransi swasta	178	1,19%	136	1,02%	264	1,78%
6	Perusahaan	28	0,18%	34	0,20%	49	0,33%
7	BKKBN	-	-	-	-	2	0,01%
	Total	14843	100%	13266	100%	14799	100%

4.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :

Kunjungan pasien bulan Mei 2024 berdasarkan cara pembayaran meningkat dari bulan April sebesar 10,4%. Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 85,73%. Kunjungan terendah adalah Pasien BKKBN sebesar 0,01%. Adanya peningkatan kunjungan dengan cara bayar asuransi swasta sebanyak 94%, JKK sebanyak 54% dan pasien umum sebanyak 41% mengindikasikan Rumah Sakit masih dapat meningkatkan pasar di cara bayar tersebut

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Untuk meningkatkan kunjungan pasien BKKBN dan jasa raharja, koordinasi dengan humas dan marketing untuk Kerjasama dengan pihak jasa marga dan polisi, sehingga jika ada KLL, RS rujukan pertama adalah RS Prima Husada
- 2. Meningkatkan pemasaran dan promosi melalui social media yang di miliki rumah sakit prima husada malang
- 3. Melakukan kunjungan ke perusahaan oleh humas marketing, dan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan asuransi yang belum di miliki oleh RS prima husada seperti PLN, Prudential, BNI dll
- 4. Membuka layanan telemedicine, home care serta home visite serta bekerja sama dengan perusahaan dan perhotelan sekitar terkait adanya layanan tersebut
- 5. Segera membuka layanan poliklinik umum sakura.

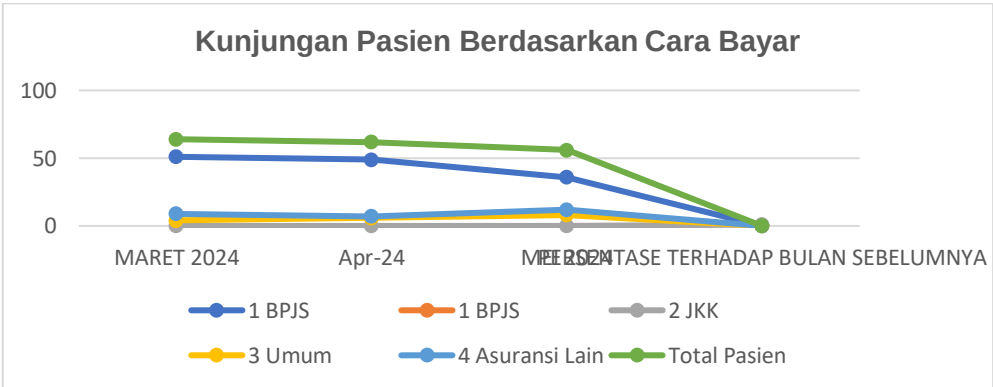
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.3.2.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret – Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	51	49	36	↓26,5%
2	JKK	0	0	0	100%
3	Umum	4	6	8	↑33,33%
4	Asuransi Lain	9	7	12	↑71,42%
Total Pasien		64	62	56	↓9,67%

3.3.2.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

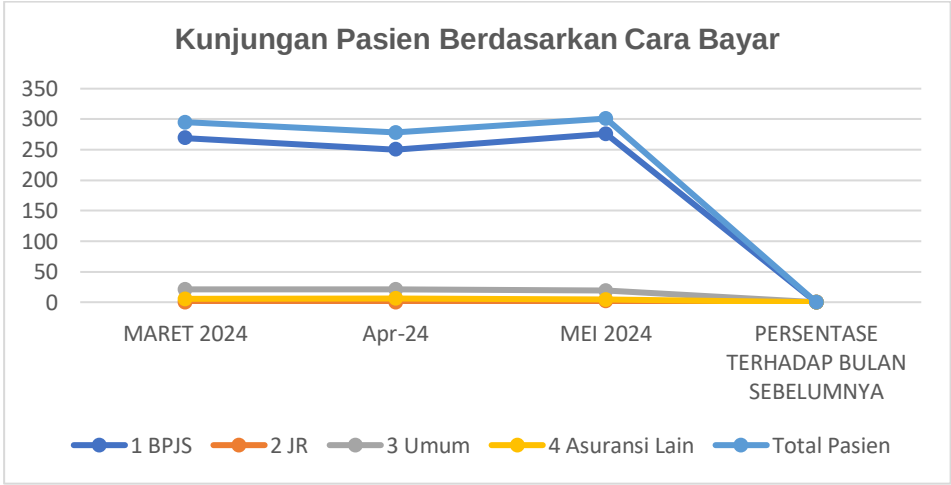
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	MEI 2024	36	8	0	12	56
	Analisa	Pasien BPJS dalam bulan mei menurun 13 pasien 26,5%	Pasien umum mengalami peningkatan meskipun sedikit 2 pasien 33,3 %	Pasien JKK kosong dibulan Mei	Untuk pasien asuransi mengalami kenaikan yang segnifikan di bulan Mei 5 pasien 71,42 %	Total pasien bulan Mei mengalami penurunan dari bulan April
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.3.2.2 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.3.2.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	269	250	276	↑9,4%
2	JR	0	0	2	↑100%
3	Umum	21	21	19	10,5%
4	Asuransi Lain	5	6	4	33,3%
Total Pasien		295	278	301	↑7,6%

3.3.2.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS mengalami peningkatan 9,4% di bulan Mei, dikarenakan DPJP sudah mulai mehami alur yng berlaku dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu banyak anak2 sakit serta banyak penderita DBD	Untuk pasien Umum di bulan Mei mengalami penurunan 10,5 % di karenakan kunjungan iGD hanya pasien BPJS	Untuk pasien JKK ada 2 ini meningkat dari 2 bulan sebelumnya	Untuk pasien Asuransi lain menurun dari 2 bulan sebelumnya	Total keseluruhan an ada 301 pasien
	RTL	Total pasien sudah meningkat dari 2 bulan sebelumnya sehingga bulan juni target jumlah rawat inap anak harus dinaikan dari bulan mei sehingga setiap bulan unit 3c selalu mempunyai target yang berlebih				

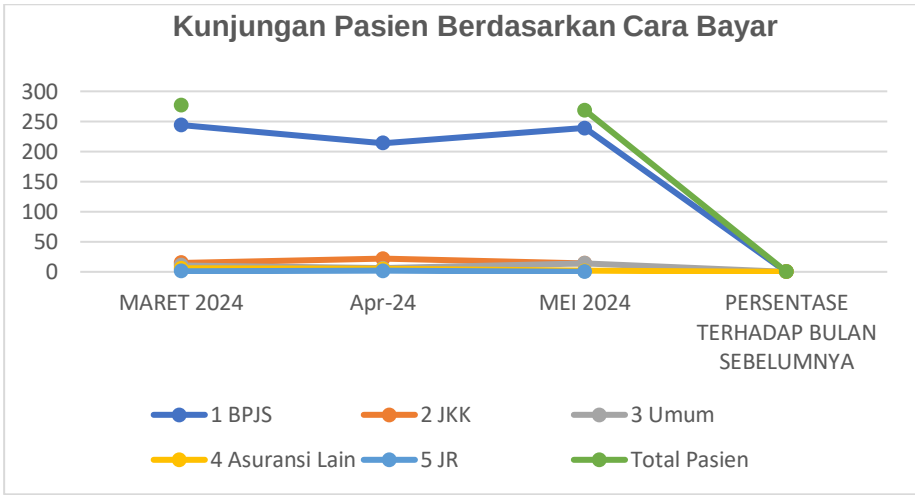
3.3.2.3 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.3.2.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	244	214	239	↑11,6%
2	JKK	15	22	14	↓ 36,3%

3	Umum	11	6	14	↑57,14%
4	Asuransi Lain	6	5	2	↓ 100%
5	JR	1	2	0	↓ 100%
Total Pasien		277	249	269	↑8,03%

3.3.2.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2024)



3.3.2.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

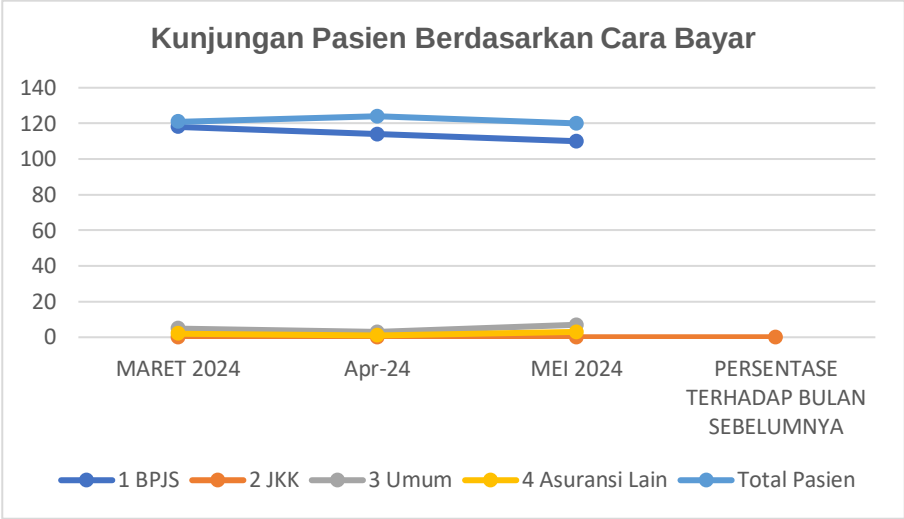
NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Mei 2024	Pasien BPJS mengalami kenaikan di bulan mei 11,6%	Pasien Umum mengalami kenaikan bulan mei 8 pasien 57,14%	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan Mei 2024 yaitu sebanyak 8 pasien 36,6%	Pasien Asuransi mengalami Penurunan pada bulan Mei 100%	Peningkatan jumlah pasien pada bulan mei 2024 8,03%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.4 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.3.2.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	118	114	110	↓ 3,5%
2	JKK	0	0	0	0
3	Umum	5	3	7	↑ 75%
4	Asuransi Lain	2	1	3	↑ 66,6%
Total Pasien		121	118	120	↑ 1,69%

3.3.2.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

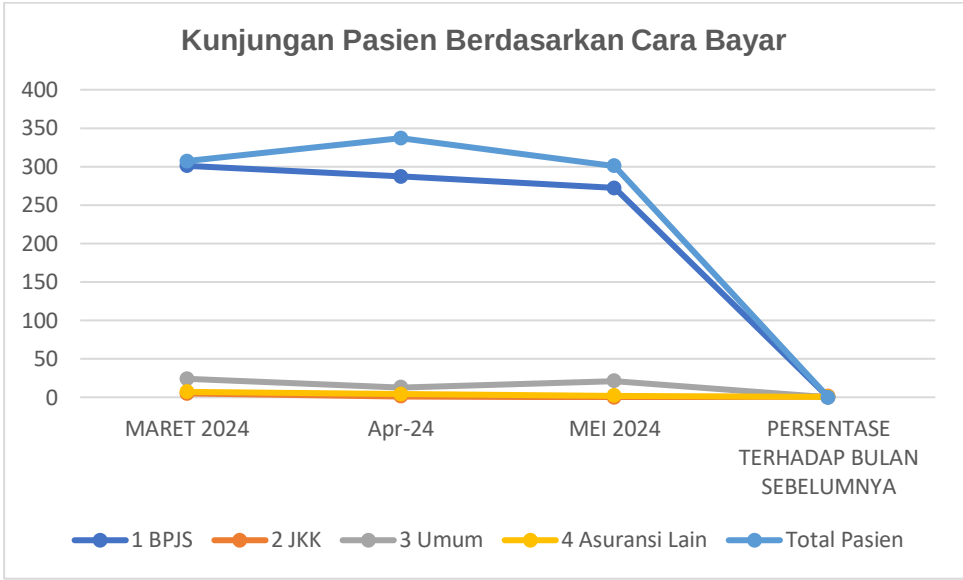
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Mei	Pasien BPJS mengalami penurunan sebanyak 3,5% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum mengalami kenaikan sebanyak 75 % dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK pada bulan April	Pasien Asuransi / JR mengalami kenaikan sebanyak 66,6% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Mei untuk kunjungan pasien mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 1,6
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.5 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.3.2.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret – Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	301	287	272	↓5,2%
2	JKK	5	1	0	↓100%
3	Umum	24	13	21	↑45%
4	Asuransi Lain	7	4	2	↓50%
Total Pasien		307	337	301	↓1,31%

3.3.2.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

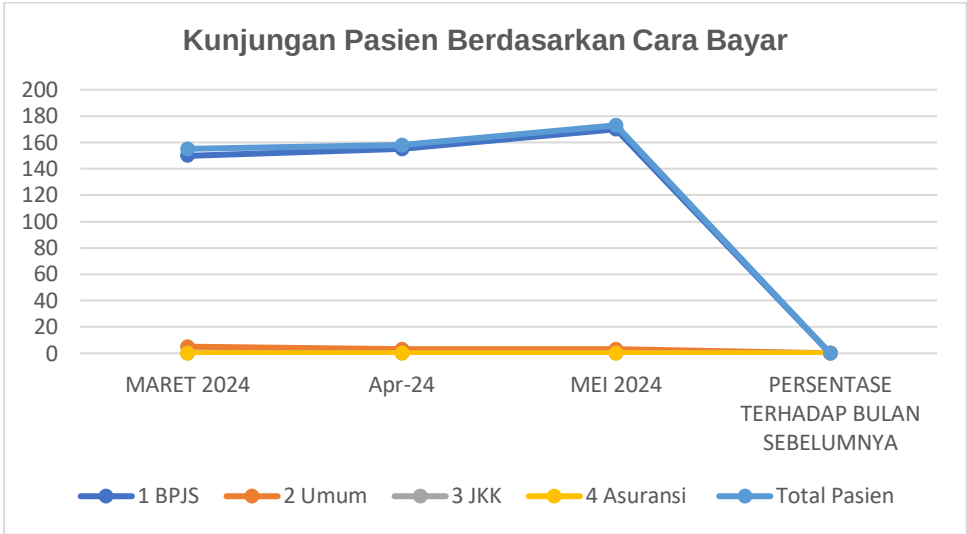
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 301 pasien	Pasien Umum mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 24 pasien	Pasien JKK mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 5 pasien	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan terbanyak selama 3 bulan terakhir pada bulan Maret 2024 yaitu sebanyak 7 pasien	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak terjadi di bulan Maret 2024 dengan jumlah pasien sebanyak 337 pasien.
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.3.2.6 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.3.2.6.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	150	155	170	↑ 8,8%
2	Umum	5	3	3	0%
3	JKK	0	0	0	0%
4	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		155	158	173	↑ 8,6%

3.3.2.6.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.6.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

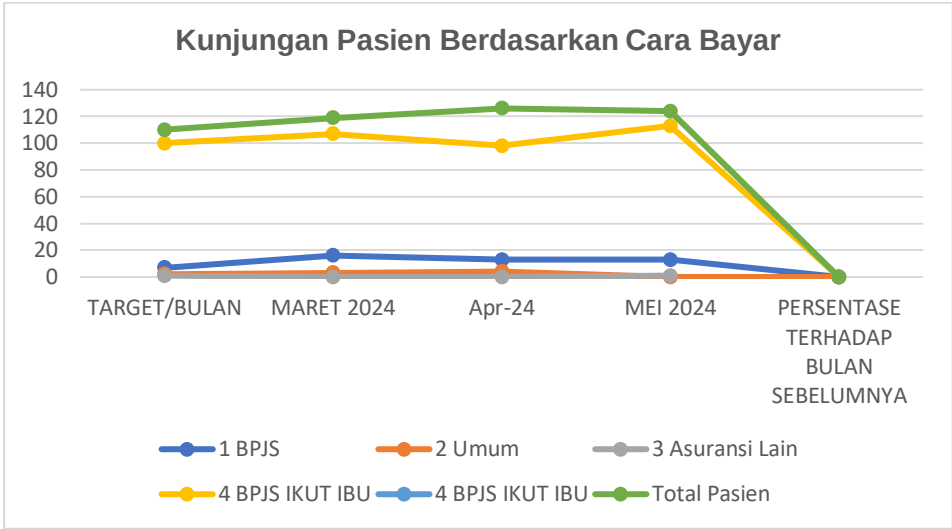
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Maret-Mei	Pasien BPJS pada bulan maret sampai mei selalu meningkat sampai dengan 8,8% di bulan mei	Pasien umum pada bulan maret-mei mengalami penurunan 66%	Tidak ada pasien JKK Mei	Tidak ada pasien asuransi di bulan Mei	Kunjungan mengalami peningkatan di bulan mei ini 8,6%
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.3.2.7 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	TARGET/BULAN	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	16	13	13	0%
2	Umum	2	3	4	0	↓100%
3	Asuransi Lain	1	0	0	1	↑ 100%
4	BPJS IKUT IBU	100	107	98	113	↑13,2%
Total Pasien		110	119	126	124	↑7,2%

3.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

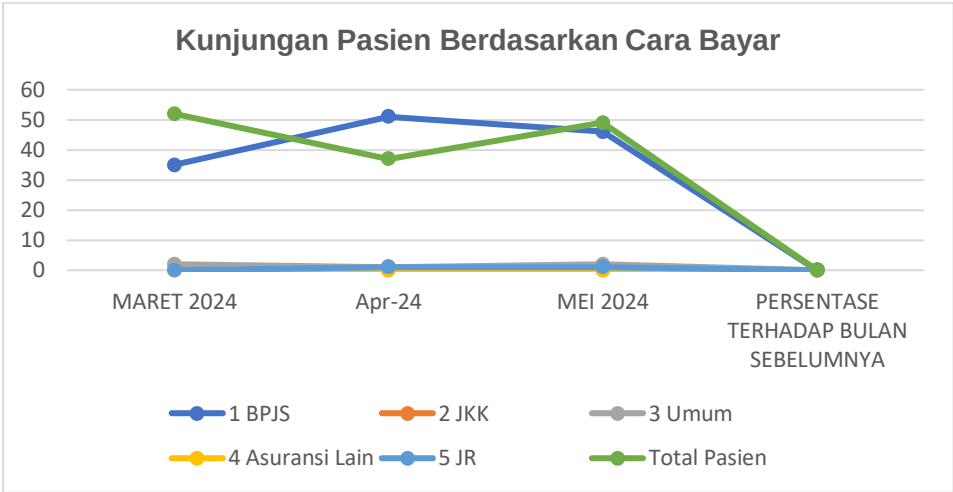
NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Mei 2024	13	0	1	113	124
	Analisa	Pasien BPJS mengalami stagnan dengan bulan sebelumnya sebanyak 13 tetap	Untuk pasien Umum penurunan dalam 3 bulan terakhir	Dalam 3 bulan terakhir tepatnya di bulan mei ada kenaikan 1 pasien	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan 7,2%	Dalam 3 bulan terakhir pasien masih belum stabil masih naik turun
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasama dengan marketing

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU)

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	35	51	46	↓10%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	2	1	2	↑50%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	1	1	0%
Total Pasien		52	37	49	↓8%

3.3.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)



3.3.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

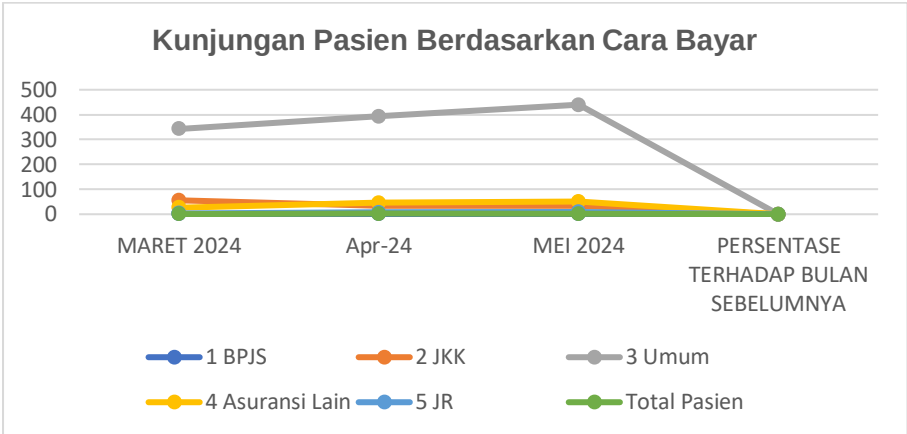
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis Mei	Pasien BPJS pada bulan April 2024 mengalami penurunan sebanyak 10%	Untuk bulan April 2024 pasien umum mengalami Kenaikan 50%	Tidak ada pasien JKK di bulan Mei 2024	ada pasien pada 1 pasien di bulan Mei 2024	Pada bulan Mei untuk pasien BPJS, Umum dan asuransi lain mengalami Penurunan sebesar 8%
2	RTL	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	Selalu memberikan pelayan yang terbaik baik pasien bpjs,umum dan asuransi lain dan harus mempunyai target setiap bulanya	

3.3.4 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.3.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	1.404	1.383	1.301	↓6,3%
2	JKK	56	34	35	↑2,8%
3	Umum	343	393	440	↑10,6%
4	Asuransi Lain	27	46	51	↑9,8%
5	JR	4	7	9	↑22,2%
Total Pasien		1.465	1.834	1.861	↑1,45%

3.3.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2024)



Analisis :
Berdasarkan grafik diatas, terdapat peningkatan jumlah kunjungan IGD sebanyak 1,45% dari bulan sebelumnya. Dari peningkatan jumlah kunjungan IGD terdapat penurunan jumlah kunjungan pasien dengan jaminan BPJS menurun 82 (↓6,3%), jaminan JKK mengalami peningkatan sebanyak 1 (↑2,8%), jaminan UMUM meningkat 47 (↑10,6%), Asuransi lain mengalami peningkatan 5 (↑9,8%) , secara total terdapat peningkatan 27 (↑1,45%).

Rencana Tindak Lanjut :
Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan yang prima dan maksimal, serta bekerjasama dengan pihak marketing untuk memperluas kerjasama dengan faskes 1 dan beberapa perusahaan serta asuransi swasta terutama yang di area Kabupaten Malang

3.3.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

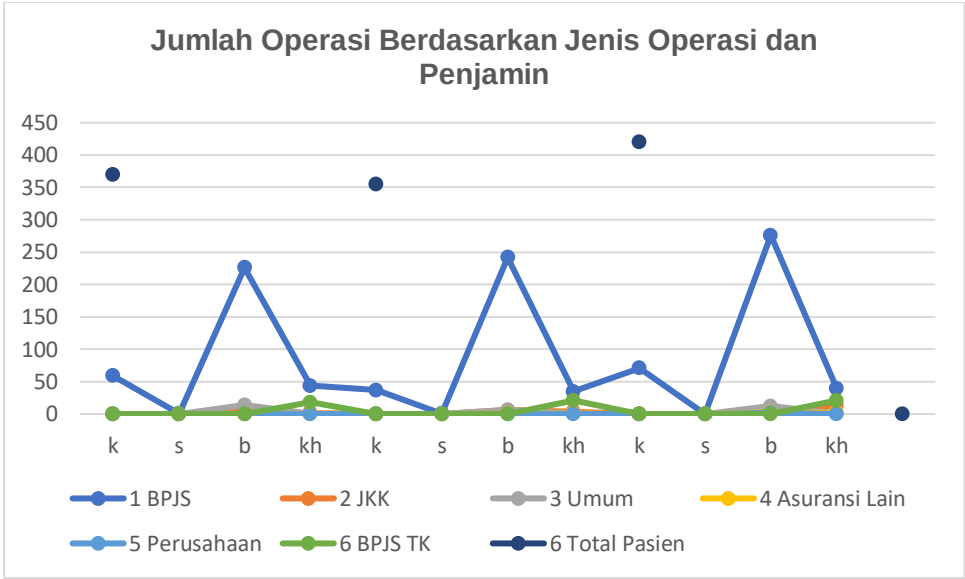
NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari bulan April ke Mei mengalami penurunan 82 (↓6,3%)	Kunjungan pasien UMUM dari bulan April ke Mei Mengalami peningkatan 47 (↑10,6%)	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari bulan Maret ke April mengalami peningkatan 1 (↑2,8%)	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain dari bulan April ke Mei mengalami peningkatan 7 (↑22,2%)	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan dari bulan April ke Mei meningkat 27 (↑1,45%)
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.3.5 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.3.5.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret - Mei 2024)

NO	HAL	MARET 2024				APRIL 2024				MEI 2024				PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
		K	S	B	KH	K	S	B	KH	K	S	B	KH	
1	BPJS	59	1	226	44	37	1	242	35	71	0	276	40	
2	JKK	0	0	4	2	0	0	6	4	0	0	1	13	
3	Umum	0	0	14	1	0	0	6	1	0	0	12	1	
4	Asuransi Lain	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
6	BPJS TK	0	0	0	18	0	0	0	21	0	0	0	21	
	Total Pasien	370				355				420				↑15,47%

3.3.5.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret – Mei 2024)



3.3.5.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan mei 2024 18,60% 72 pasien	Pasien BPJS TK mengalami kenaikan dari maret sampai mei 3 pasien	Pasien Umum naik dari bulan april ke mei 7 pasien 53,84%	Pasien JKK masih belum stabil dan tetapi setiap bulan naik,untuk bulan mei 2024 naik 4pasien ,28,57 %	Pasien Asuransi / JR mengalami belum stabil selama 3 bulan mengalami kenaikan 60% ,untuk pasien 3 pasien	Selama 3 bulan jumlah operasi yang ada di IKO belum stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkolaborasi dengan IKO					

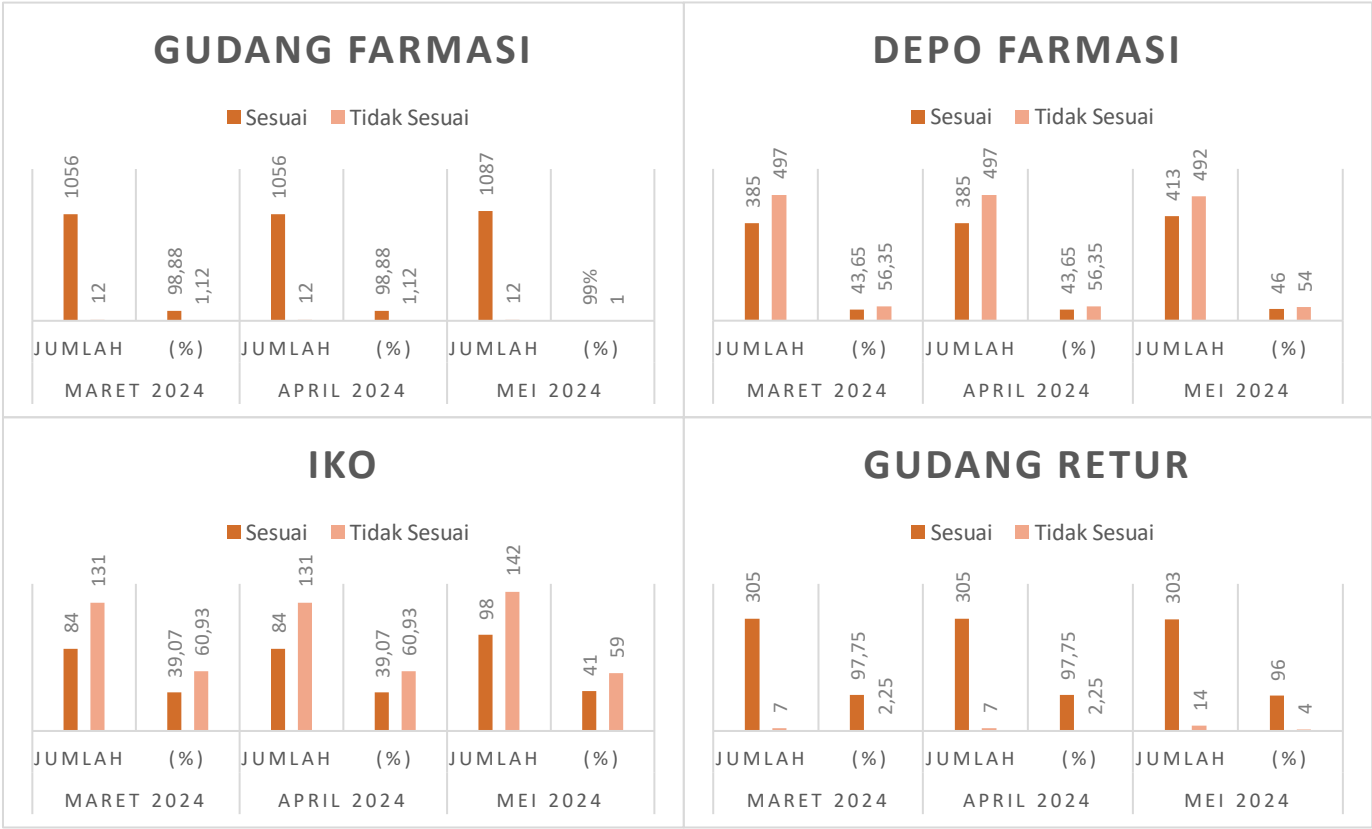
3.4 Kinerja Bidang Penunjang

3.4.1 Instalasi Farmasi

3.4.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Maret – Mei 2024

UNIT	STOCK	JUMLAH STOK					
		MARET 2024		APRIL 2024		MEI 2024	
GUDANG	Sesuai	1056	98,88%	1056	98,88%	1087	99%
	Tidak Sesuai	12	1,12%	12	1,12%	12	1%
	Total	1068	100%	1068	100%	1099	100%
DEPO FARMASI	Sesuai	385	43,65%	385	43,65%	413	46%
	Tidak Sesuai	497	56,35%	497	56,35%	492	54%
	Total	882	100%	882	100%	905	100%
IKO	Sesuai	84	39,07%	84	39,07%	98	41%
	Tidak Sesuai	131	60,93%	131	60,93%	142	59%
	Total	215	100%	215	100%	240	100%
GUDANG RETUR	Sesuai	305	97,75%	305	97,75%	303	96%
	Tidak Sesuai	7	2,25%	7	2,25%	14	4%
	Total	312	100%	312	100%	317	100%

3.4.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan Maret – Mei 2024



3.4.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

NO.	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terdapat obat tidak diambil pasien yang baru diproses retur sedangkan master sudah nonaktif sehingga menyebabkan munculnya stok sistem pada master yang nonaktif yaitu : 1. F00338 Clopidrogel Tab 75 mg - HJ - Hexpharm	Koordinasi dengan programmer untuk memberi barrier/ warning di SIMRS terhadap stok masuk melalui retur pada master non aktif.

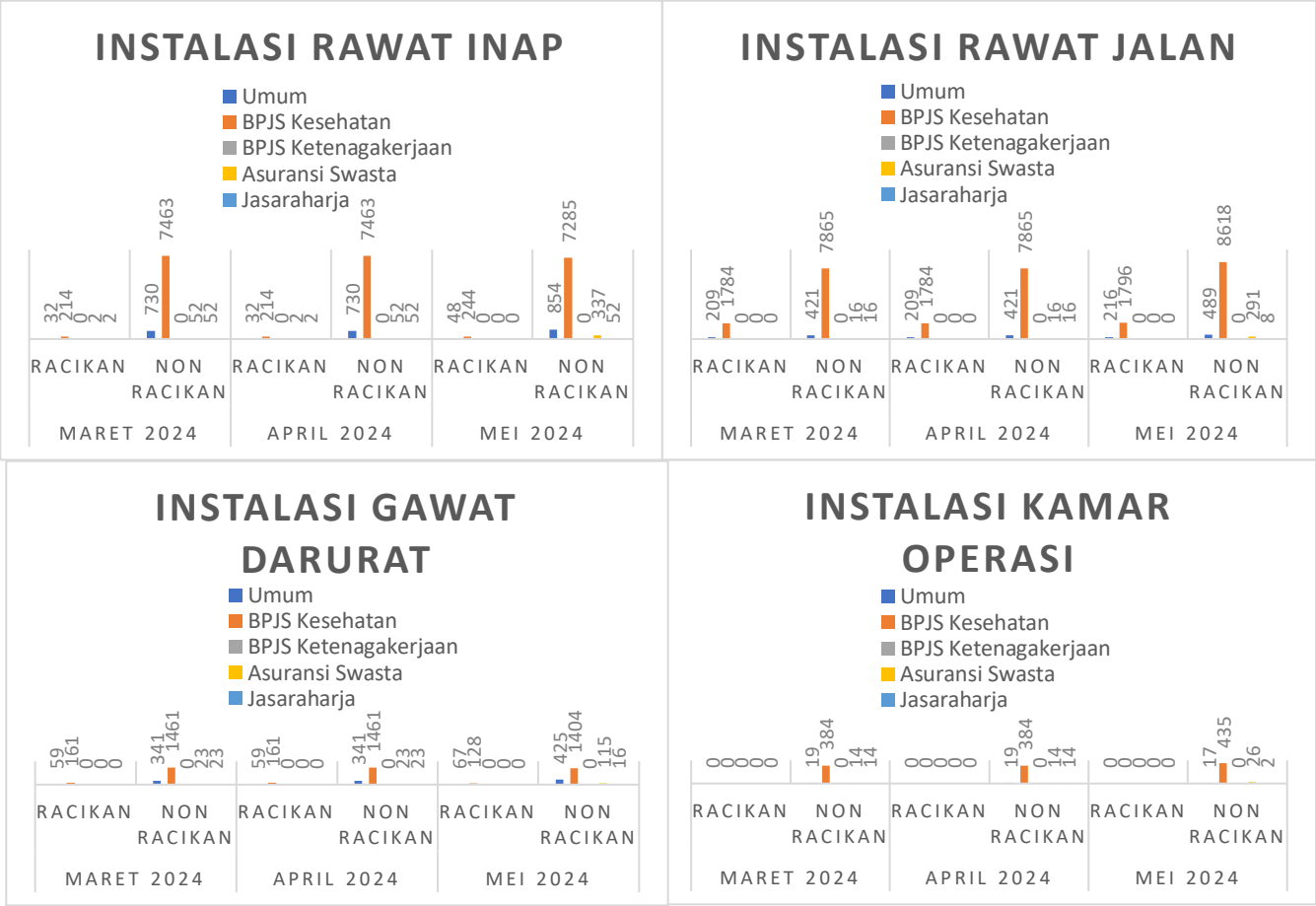
	2. F03716 Ursodeoxycholic Tablet - OGB Dexa 3. F00395 Furosemide Tab 40 mg - FM F03397 Omeperazole Tab 20 mg – IFARS.	
2	Barang F03795 Velpraz Tab 250 mg - Novell dan F03647 Gabapentin tab 300 mg - HJ - Hexpharm terbaca penerimaan retur di monitoring stock 2 kali. Sebelumnya dilakukan retur obat tertinggal pasien an. Nanang Fatur Rochman, no retur : TBR/2405/082 namun terdapat kesalahan penginputan jumlah sehingga Gudang menghapus inputan tersebut dan melakukan penginputan ulang di nomor TBR/2405/085.	Koordinasi dengan progamer mengenai fitur yang ada di SIMRS dan bagaimana solusi jika terdapat kesalahan input jumlah dan sudah di simpan.
3	Kartu stock sudah berjalan, tetapi masih terjadi ketidakteelitian dalam pencatatan di Gudang farmasi.	Penertiban pencatatan kartu stock.
4	Terdapat kesalahan F0859 Maxiflow Dewasa satuan obat pada SP (seharusnya pcs tetapi box) dan tidak dicek waktu penerimaan sehingga membuat selisih stock. Hasil telusur petugas Gudang tidak melihat satuan box di SP namun total harga di faktur sesuai dengan harga terkecil atau harga yang tertera di SP	Penertiban SOP penerimaan barang dari distributor oleh gudang farmasi. Tegaskan aturan pada staff terkait. Petugas wajib mengecek kesesuaian antara SP, faktur dan jumlah sediaan. Perbaiki harga master F0859 Maxiflow Dewasa oleh pengadaan.
5	Ditemukan barang near ED di lemari elektrolit pekat karena merupakan barang slow moving F00901 Meylon 8,4% 25 ml – Otsuka.	Tingkatkan supervisi terhadap obat near ed. Koordinasi dengan pengadaan untuk retur meylon 8,4% 25 ml – Otsuka ke Distributor.
6	F03767 Telmisartan 80 mg - OGB Novell selisih lebih di Gudang Farmasi 100 tab dan terdapat selisih kurang 100 tab di depo farmasi mengindikasikan terdapat serah terima yang tidak sesuai SOP. F03791 Fenofibrat 300 mg – Hexpharm selisih kurang di Gudang Farmasi 300 kaps dan terdapat selisih lebih di Depo Farmasi 300 kaps mengindikasikan terdapat serah terima yang tidak sesuai SOP.	Review alur dan SOP distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP depo farmasi dan gudang farmasi. Petugas depo wajib melakukan double croscek barang yang sudah disiapkan dan jumlah release disistem oleh gudang. Tegaskan aturan pada staff terkait.
7	Penataan dan pelabelan barang masih belum sesuai dengan raknya di depo farmasi. Sebagian tidak dikelompokkan sesuai dengan golongannya.	Lakukan perbaikan penataan dan pelabelan rak.
8	Ketidapkahaman staff mengenai lokasi penempatan barang menyebabkan potensi kesalahan perhitungan fisik barang dan pencatatan pada kartu stok dan akan berpengaruh data mutase barang selanjutnya	Perjelas tugas dan wewenang masing-masing staff. Perbaiki daftar total box emergency dan paket-paket.
9	Terdapat F00830 LMA NO. 4 yang merupakan barang BMHP, seharusnya tidak berada di Depo Farmasi. Hasil telusur LMA No. 4 retur dari IKO yang seharusnya masuk ke Gudang farmasi namun masuk ke depo farmasi.	Retur ke Gudang farmasi sesuai alur dan SPO yang berlaku.
10	Ditemukan barang lama yang tidak memiliki master. Delta Dry 5, Delta Dry 7.5, ETT Non King 2.0, ETT Non King 2.5. (Hasil telusur ETT Non King 2.0, ETT Non King 2.5 kesalahan petugas farmasi dalam	Koordinasi dengan pengadaan pembuatan master barang Delta Dry 5, Delta Dry 7.5 kemudian membuat berita acara.

	menghitung stok dan meletakkan dikeranjang ett non king sehingga petugas salah memberi nama di lembar kerja SO. Seharusnya dituliskan dan dihitung masuk stok ETT Cuff 2.0 dan ETT Cuff 2.5).	Membuat BA penyesuaian ETT Cuff 2.0 dan ETT Cuff 2.5 dan meningkatkan ketelitian petugas dalam menghitung alkes dan perbaikan penataan alkes.
11	Ramozia inj dan Implan susuk KB II salah input SO di jumlah fisik rusak sehingga selisih stok fisik dan SIMRS.	Menegur petugas agar lebih hati-hati dalam input stok opname dan membuat berita acara.
12	Penggunaan Spuit masih selisih banyak, apakah ada indikasi pemakaian spuit berulang di IKO.	Dilakukan telusur koordinasi dengan kains IKO dan penambahan TTK di IKO.
13	F01427 Vasodrin Injeksi – Mahakam terdapat jumlah yang lebih dari kesepakatan jumlah floorstock.	Dilakukan retur vasodrin inj ke Gudang farmasi yang tidak sesuai jumlah FS.

3.4.1.4 Tabel Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Maret – Mei 2024

NO	UNIT	PENJAMIN	BULAN/JENIS RESEP					
			MARET 2024		APRIL 2024		MEI 2024	
			RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
1.	IRNA	Umum	32	730	32	730	48	854
		BPJS Kesehatan	214	7463	214	7463	244	7285
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	2	52	2	52	0	337
		Jasaraharja	2	52	2	52	0	52
Total			250	8297	250	8297	292	8820
2.	IRJA	Umum	209	421	209	421	216	489
		BPJS Kesehatan	1784	7865	1784	7865	1796	8618
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	16	0	16	0	291
		Jasaraharja	0	16	0	16	0	8
Total			1993	8318	1993	8318	2012	9406
3.	IGD	Umum	59	341	59	341	67	425
		BPJS Kesehatan	161	1461	161	1461	128	1404
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	23	0	23	0	115
		Jasaraharja	0	23	0	23	0	16
Total			220	1848	220	1848	195	1960
4.	IKO	Umum	0	19	0	19	0	17
		BPJS Kesehatan	0	384	0	384	0	435
		BPJS Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	14	0	14	0	26
		Jasaraharja	0	14	0	14	0	2
Total			0	410	0	431	0	480
Total Resep			2463	18894	2463	18894	2499	20666

3.1.1.1 Grafik Jumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran Maret – Mei 2024



- Analisis :**
- 1. Total Resep tidak ada perubahan yang signifikan, pelayanan resep di IGD, IRNA, IRJA dan IKO meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien di IGD dan jumlah pasien operasi juga meningkat.
 - 2. Tarikan data pasien BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi satu dengan Asuransi Swasta dan Jasaraharja (jika menjadi penjamin pertama), dibuktikan dengan jumlah pasien operasi di IKO sebanyak 21 sedangkan pelayanan resep di IKO tidak ada atau 0.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan Programmer untuk memisahkan data pasien BPJS Ketenagakerjaan dari data pasien Asuransi Swasta supaya mendapatkan data yang valid.

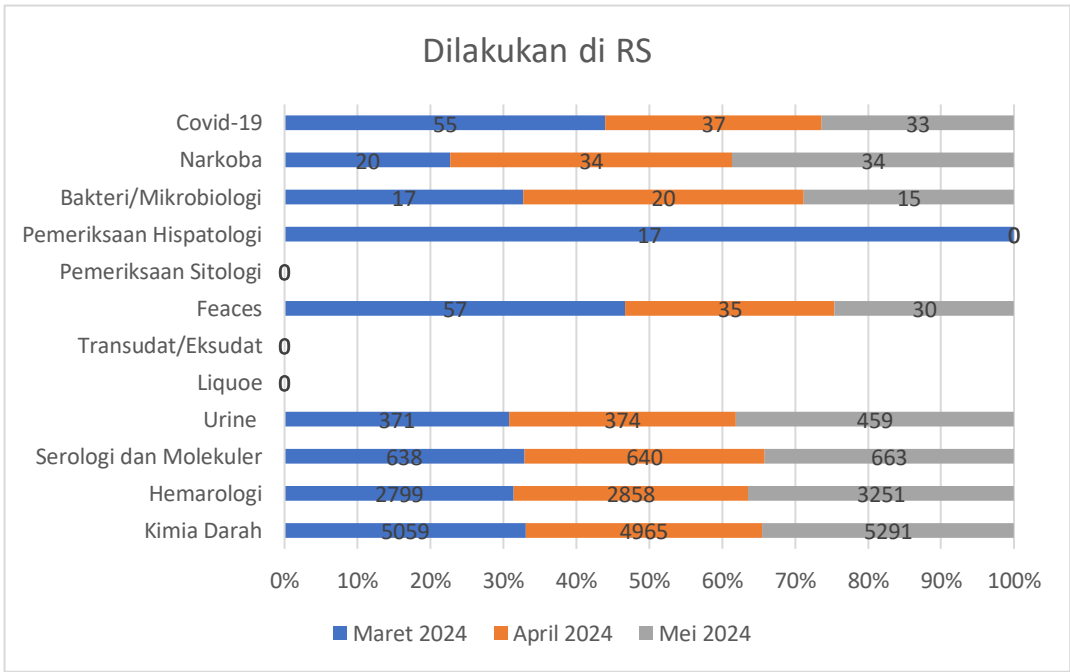
3.1.2 Laboratorium

3.1.2.1 Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Maret - Mei 2024

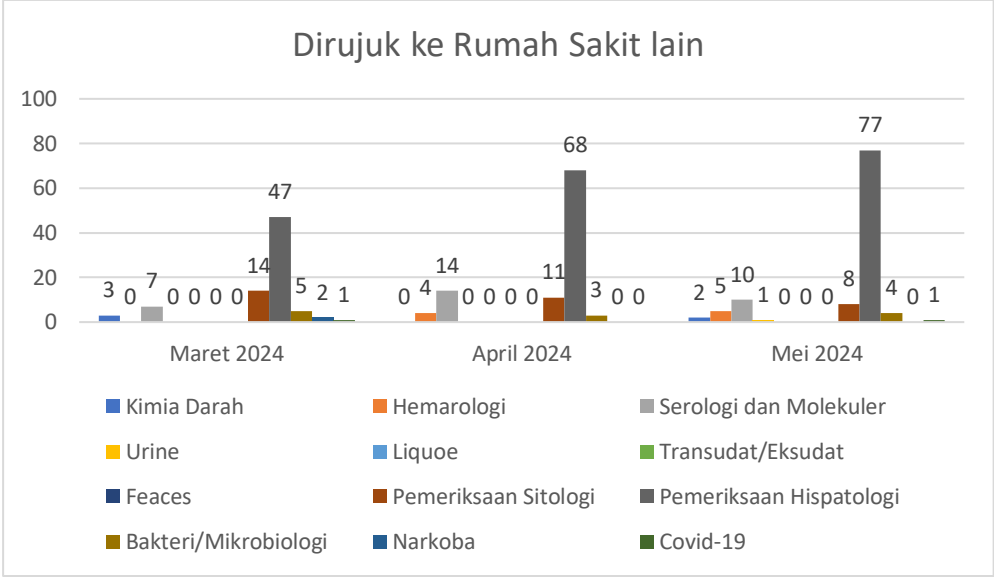
NO	JENIS PEMERIKSAAN	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
Dilakukan di RS				
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	5059	4965	5291
	Hematologi	2799	2858	3251
	Serologi dan Molekuler	638	640	663

	Urine	371	374	459
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	57	35	30
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	17	0	0
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	17	20	15
4	Narkoba	20	34	34
5	Covid-19	55	37	33
Dirujuk				
1	Patologi Klinik			
	Kimia darah	3	0	2
	Hematologi	0	4	5
	Serologi dan Molekuler	7	14	10
	Urine	0	0	1
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Liquor	-	-	-
	Feses	0	0	0
2	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	14	11	8
	Pemeriksaan Histopatologi	47	68	77
3	Bakteriologi/Mikrobiologi	5	3	4
4	PCR	2	0	0
5	Tumor Marker	1	0	1

3.1.2.2 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit



3.1.2.3 Grafik Pemeriksaan Diluar Rumah Sakit



Analisis :

- 1. Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terkahir, yaitu :
 - a) Patologi Anatomi : 85 sampel
 - b) Patalogi Klinik : 18 sampel
 - c) Bakteri/Mikrobiologi : 4 sampel
 - d) Lain-lain (Tumor Marker) : 1 sampel

Rencana Tindak Lanjut

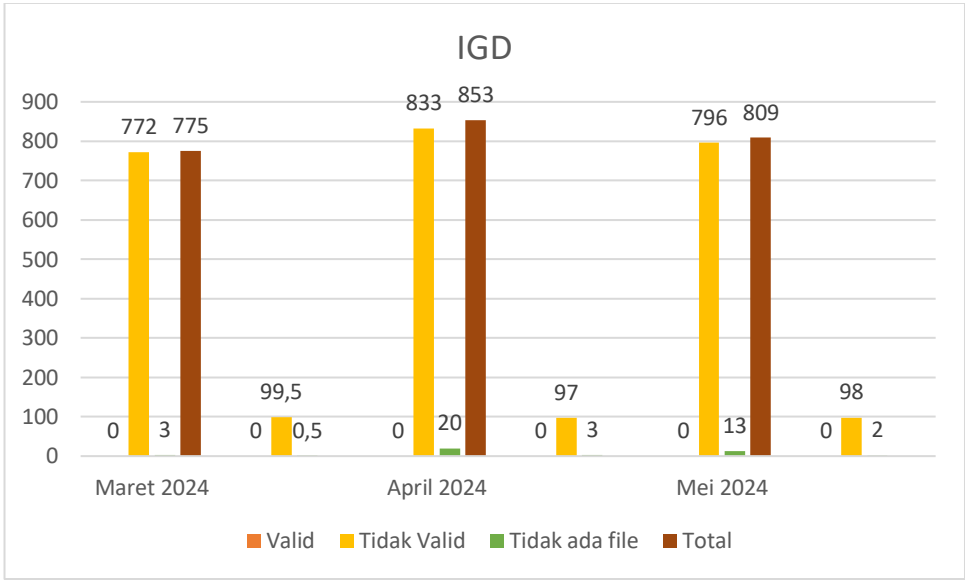
- 1. Perencanaan Tahun 2024 laboratorium mengadakan pengembangan pelayanan dengan mendirikan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang, untuk mengurangi jumlah rujukan dan meningkatkan pendapatan.
- 2. Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- 3. Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan sistem digital.

3.1.3 Rekam Medis – Pendaftaran

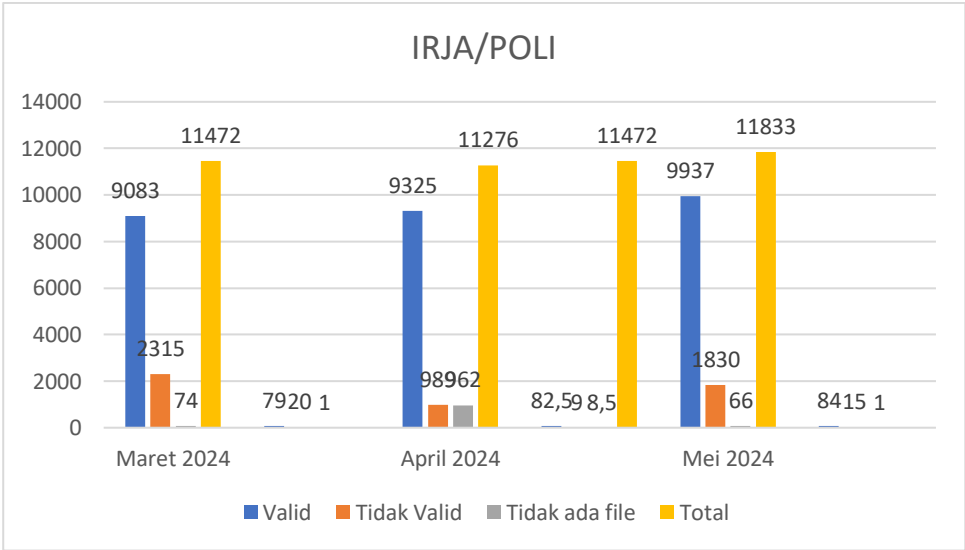
3.1.3.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Maret - Mei 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			MARET 2024		APRIL 2024		MEI 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	IGD	Valid	0	0	0	0	0	0
		Tidak Valid	772	99,5	833	97	796	98
		Tidak ada file	3	0,5	20	3	13	2
Total			775		853		809	
2	IRJA/POLI	Valid	9083	79	9325	82,5	9937	84
		Tidak Valid	2315	20	989	9	1830	15
		Tidak ada file	74	1	962	8,5	66	1
Total			11472		11276	11472	11833	

3.1.3.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Maret - Mei 2024



3.1.3.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Maret - Mei 2024



Analisis :

1. Masih ditemukan pengisian form erm yang tidak lengkap.
2. Masih ditemukan form rawat jalan dan rekam medis yang belum sinkron.
3. Keterangan TF (tidak ada file), dikarenakan :
 - a. Terdapat masalah pada system programmer.
4. Yang tidak masuk ERM :
 - a. Pasien UMUM (MCU)
 - b. Fisioterapi
 - c. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), salah satunya tindakan tindik pada bayi baru lahir.

Masalah :

1. Riwayat alergi kosong
2. Riwayat penyakit kosong
3. Keperawatan kosong
4. Tolak ukur kosong

- Keadaan umum kosong
- Skrining nyeri kosong
- Pengkajian nyeri kosong
- Resiko dekubitus jika dia tidak ada resiko harusnya “tidak” tetapi kosong

Rencana Tindak Lanjut :

- Mendata temuan masalah penggunaan ERM dan disampaikan ke Programmer untuk dilakukan tindaklanjut.

Berikut link permasalahan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

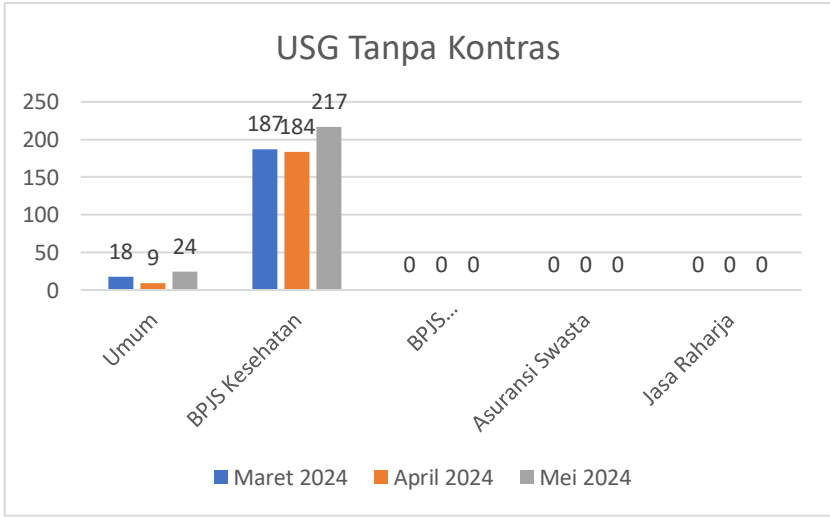
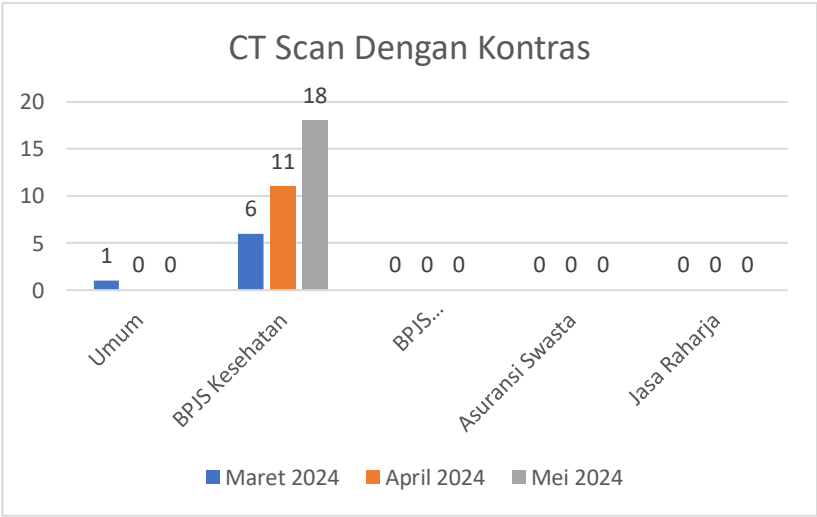
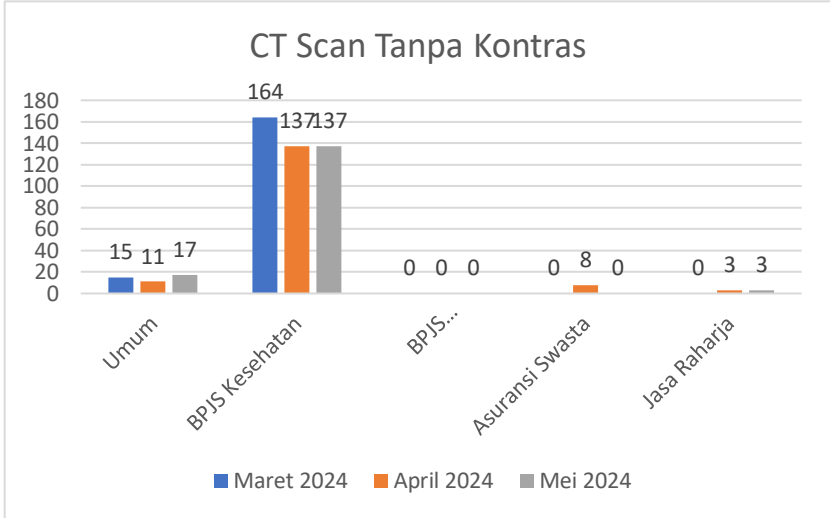
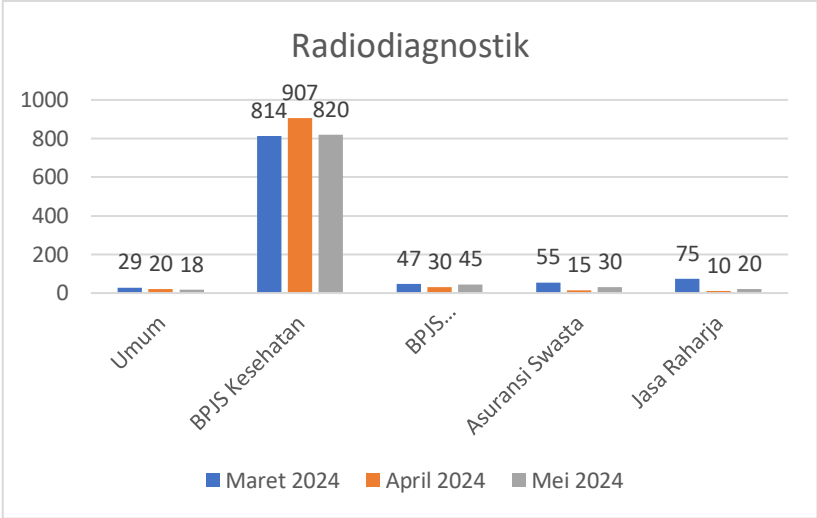
3.1.4 Radiologi

3.1.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret - Mei 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JENIS PEMBAYARAN	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1.	Radiodiagnostik	Umum	29	20	18
		BPJS Kesehatan	814	907	820
		BPJS TK	47	30	45
		Asuransi Swasta	55	15	30
		Jasaraharja	75	10	20
	Total		1020	982	938
2.	Foto Tanpa Bahan Kontras	Umum	29	20	18
		BPJS Kesehatan	814	907	820
		BPJS TK	47	30	45
		Asuransi Swasta	55	15	30
		Jasaraharja	75	10	20
	Total		1020	982	938
3.	Foto Dengan Rol Film	Umum	29	20	18
		BPJS Kesehatan	814	907	820
		BPJS TK	47	30	45
		Asuransi Swasta	55	15	30
		Jasaraharja	75	10	20
	Total		1020	982	938
4.	CT Scan Tanpa Kontras	Umum	15	11	17
		BPJS Kesehatan	164	137	137
		BPJS TK	0	0	0
		Asuransi Swasta	0	8	0
		Jasaraharja	0	3	3
	Total		179	159	157
5.	CT Scan Dengan Kontras	Umum	1	0	0
		BPJS Kesehatan	6	11	18

		BPJS TK	0	0	0	
		Asuransi Swasta	0	0	0	
		Jasaraharja	0	0	0	
Total			7	11	18	
6.	USG Kontras	Tanpa	Umum	18	9	24
			BPJS Kesehatan	187	184	217
			BPJS TK	0	0	0
			Asuransi Swasta	0	0	0
			Jasaraharja	0	0	0
Total			205	193	241	

3.1.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret – Mei 2024



Analisis :

- 1. Pelayan pemeriksaan dalam 3 bulan terakhir meliputi USG, CT-Scan, dan Rontgen terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi.
Pada 3 bulan terakhir pemeriksaan terbanyak yaitu :
 - a) Rontgen : 938
 - b) USG : 241
 - c) CT Scan : 175
- 2. Pada Bulan Mei produktivitas radiologi pada pemeriksaan USG sejumlah 241 pasien. Terbagi menjadi pasien Umum, BPJS, dan Asuransi. Mengalami peningkatan dibandingkan Bulan April, hal ini disebabkan karena adanya MCU pemeriksaan USG Abdomen.

Rencana Tindak Lanjut :

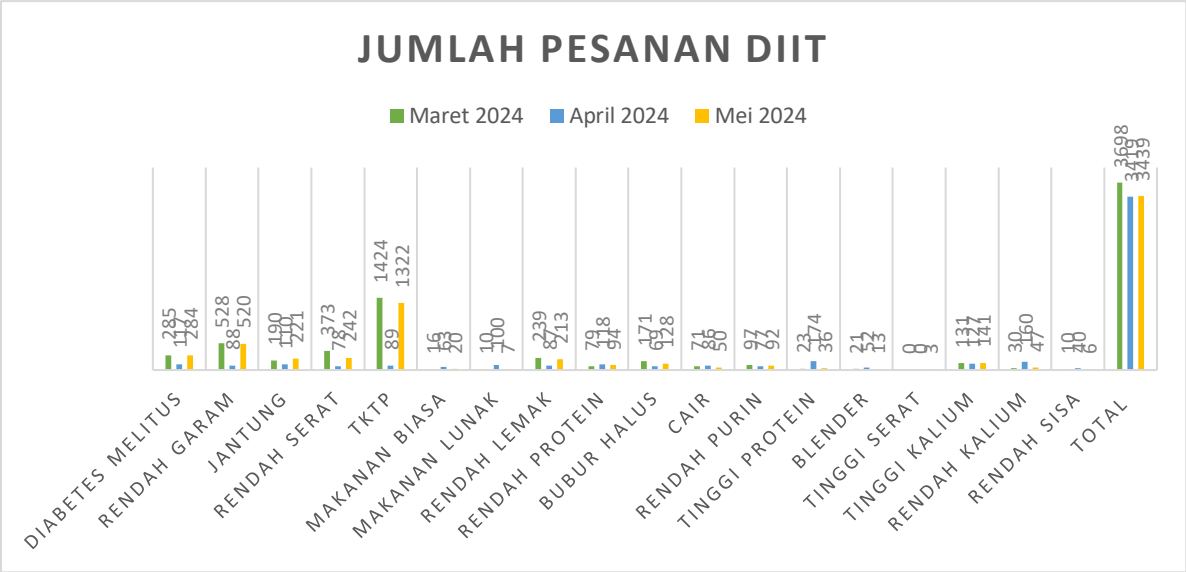
- 1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan promo/MOU dengan RS yang belum mempunyai Alat CT Scan.
- 2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengadakan MCU pemeriksaan USG.

3.4.5 Gizi

3.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Maret - Mei 2024

NO	NAMA DIIT	JUMLAH PESANAN DIIT			PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024	
1	Diabetes Melitus	285	117	284	2.4
2	Rendah Garam	528	88	520	5.9
3	Jantung	190	110	221	2
4	Rendah serat	373	78	242	3.1
5	TKTP	1424	89	1322	14.8
6	Makanan biasa	16	63	20	0.3
7	Makanan Lunak	10	100	7	0.07
8	Rendah Lemak	239	87	213	2.4
9	Rendah Protein	79	118	94	0.79
10	Bubur Halus	171	69	128	1.85
11	Cair	71	86	50	0.5
12	Rendah Purin	97	77	92	1.19
13	Tinggi Protein	23	174	36	0.2
14	Blender	21	52	13	0.25
15	Tinggi serat	0	0	3	100
16	Tinggi Kalium	131	127	141	1.2
17	Rendah Kalium	30	160	47	0.29
18	Rendah Sisa	10	40	6	0.15
Total		3698	3419	3439	137.39

3.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit 2024



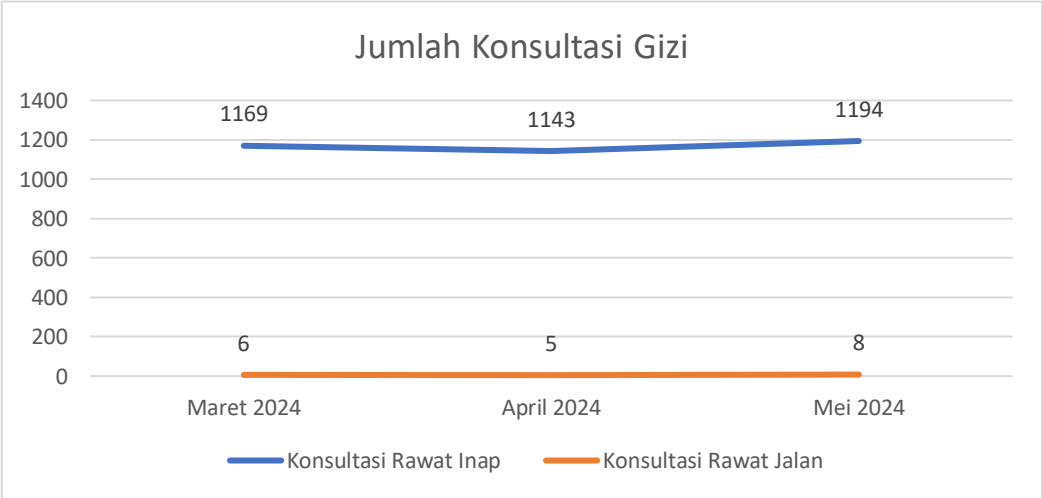
Analisis :
Adanya kenaikan jumlah pesanan diit tetapi tidak signifikan, jenis diit fluktuatif menyesuaikan kebutuhan pasien sesuai dengan advice DPJP.
Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap.
 - 2. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
 - 3. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.

3.4.5.3 Jumlah Konsultasi Gizi Maret - Mei 2024

NO.	INDIKASI	JUMLAH PASIEN MARET	JUMLAH PASIEN APRIL	JUMLAH PASIEN MEI
1.	Konsultasi Rawat Inap	1169	1143	1194
2.	Konsultasi Rawat Jalan	6	5	8

3.4.5.4 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi Maret - Mei 2024



Analisis :

Jumlah konsultasi gizi di rawat inap dan rawat jalan pada Bulan Mei 2024 meningkat, sebagian besar pasien minta diedukasi ulang sebelum KRS dari rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut :

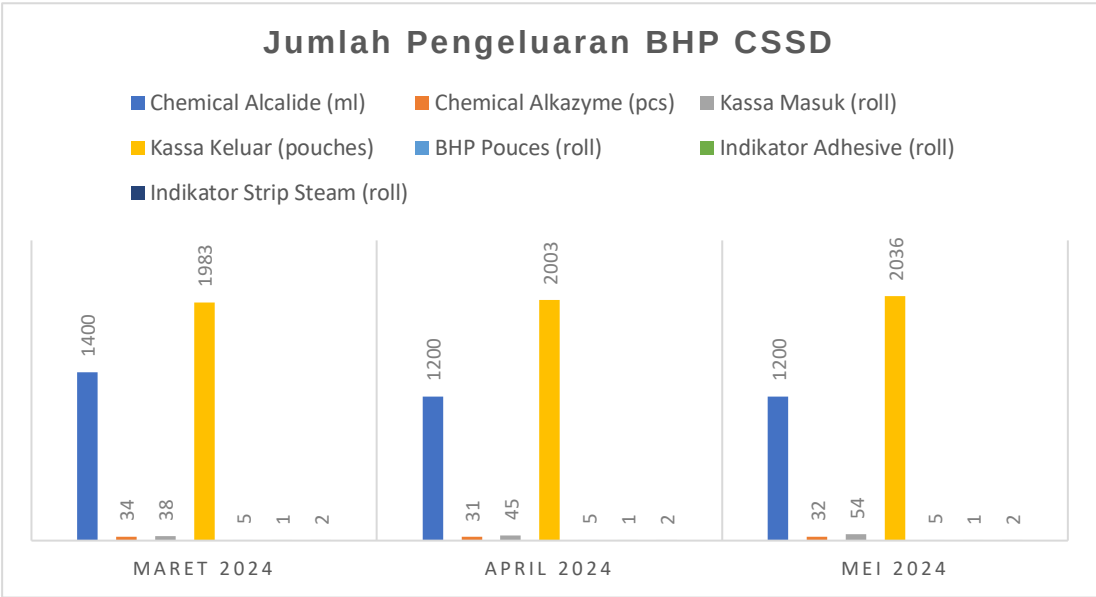
- 1. Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi.
- 2. Mengajukan MCU Gizi.

3.4.6 CSSD – Laundry

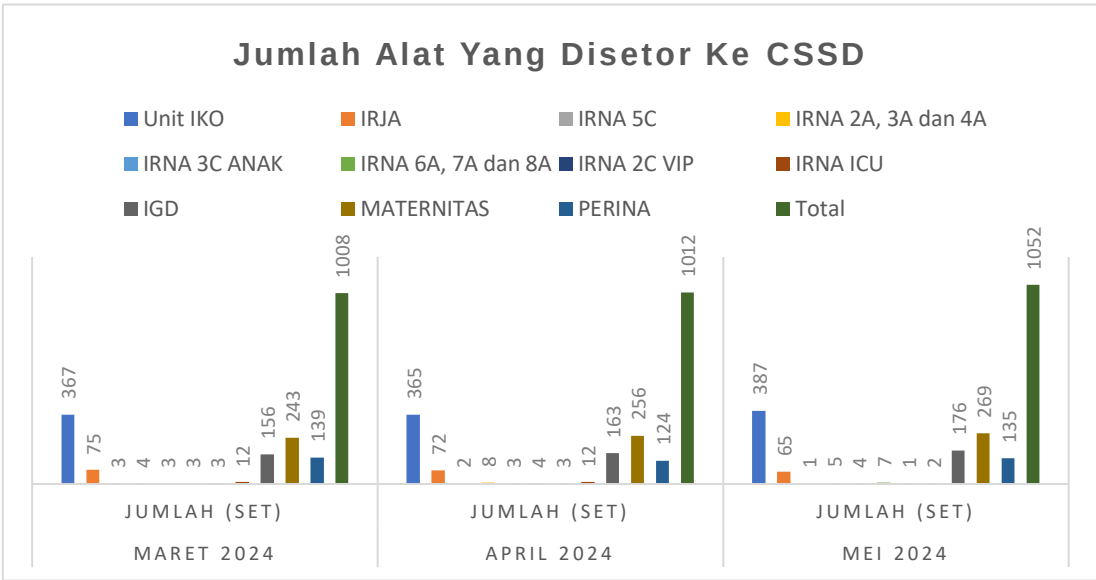
3.4.6.1 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD di Bulan Maret -Mei 2024

NO	HAL	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Chemical Alcalide	1400ml	1200ml	1200ml
2	Chemical Alkazyme	34pcs	31pcs	32pcs
3	Kassa Masuk	38roll	45roll	54roll
4	Kassa Keluar	1983pouches	2003pouches	2036pouches
5	BHP Pouces	5roll	5roll	5roll
6	Indikator Adhesive	1roll	1roll	1roll
7	Indikator Strip Steam	2roll	2roll	2roll
Alat yang disetor				
		Jumlah (set)	Jumlah (set)	Jumlah (set)
8	Unit IKO	367	365	387
9	IRJA	75	72	65
10	IRNA 5C	3	2	1
11	IRNA 2A, 3A dan 4A	4	8	5
12	IRNA 3C ANAK	3	3	4
13	IRNA 6A, 7A dan 8A	3	4	7
14	IRNA 2C VIP	3	3	1
15	IRNA ICU	12	12	2
16	IGD	156	163	176
17	MATERNITAS	243	256	269
18	PERINA	139	124	135
Jumlah		1008	1012	1052

3.4.6.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai CSSD di Bulan Maret - Mei 2024



3.4.6.3 Grafik Jumlah Alat Yang disetor ke CSSD di Bulan Maret - Mei 2024



Analisis :
Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat dalam 3 bulan terkahir yaitu sebanyak 1.108 set, diikuti dari Unit Maternitas 678 set dan IGD 468 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor.
 - Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.

3.5 Kinerja Umum dan Keuangan

3.5.5 SDM

3.5.1.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMK	41	5	0	5	0
		D3 Farmasi		19	4	15	1
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	4	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	2	2	0	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	16	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		2	0	2	0
		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	28	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0

17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	D3 TEM	7	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		D3 Teknik		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	11	7	7	1	1
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	5	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0
38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0

40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	1
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3		3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	4	0	4	0
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		2	2	0	2	0
TOTAL			451				

Keterangan :

Pada bulan Mei terdapat pengurangan 1 karyawan, masing-masing pada Instalasi Farmasi dan Maternitas., serta terdapat penambahan 1 dokter ruangan.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Apoteker	2	0	2	Sulit mencari kandidat yang cocok	Dilakukan rekrutmen tertutup dengan menggunakan relasi karyawan apoteker rs
2	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
3	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari dokter spesialis bedah mulut	Bekerja sama dengan dokter maupun staf RSPHM untuk membagikan lowongan pekerjaan dan menghubungi kampus dengan jurusan dokter spesialis tersebut.
4	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari dokter spesialis konservasi gigi	Bekerja sama dengan dokter maupun staf RSPHM untuk membagikan lowongan pekerjaan dan menghubungi kampus dengan jurusan dokter spesialis tersebut.
5	Terapi Wicara	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis wicara	Menghubungi sosial media

						komunitas terapis wicara, menghubun gu kampus dengan jurusan terapis wicara
--	--	--	--	--	--	---

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	2 Mei 2024	Orientasi Umum	Maharani Juwita Zhalsabilla S.Tr.Par	D4 Pariwisata	Pendaftaran	1 Mei 2024	Pengganti Resign
			Mayputri Nabilla, A.Md.Kes	D3 Kesehatan	Rekam Medis		
			Yeni Khikmatus Sholikhah. A.Md.Aktr	D3 Asuransi Kesehatan	Pendaftaran		
			Dea Rira Panduwinat a, A.Md. Aktr	D3 Asuransi Kesehatan	Pendaftaran		
			Niken Eka Lidiani, A.Md. Farm	D3 Farmasi	TTK		Penambahan
			Lola Novira Risdiyanti, A.Md.Kep	D3 Keperawatan	CSSD		Pengganti Pensiun
			M. Riza Kurniawan	SMA	CS		Penambahan
			Auliya Rahmatul Amani, A.Md.Kep	D3 Keperawatan	Perawat		Pengganti Resign
			Rifqi Eka Prasetya	SMA	CS		Penambahan
			Hamzah Zulfikar Jonas	SMA	Laundry		Pengganti Pensiun

3.5.1.4 Diklat

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS DIKLAT	JUDUL DIKLAT	SASARAN	KETERANGAN	RTL
1	2 Mei 2024	Inhouse Training	Refresh Training Alat Kesehatan Bersama PT Andson Sarana Bagus Tahun 2024	Seluruh Kepala Ruang, PJ Alat, dan ATEM sejumlah 27 orang.	Inhouse training alkes Bersama PT Andson Sarana Bagus dihadiri oleh seluruh staf yang ada di undangan.	Mengorganisir sertifikat peserta, disampaikan ke SDM PT Disa Prima Medika. Karena pelaksanaan inhouse training dilaksanakan di 2 RS dengan

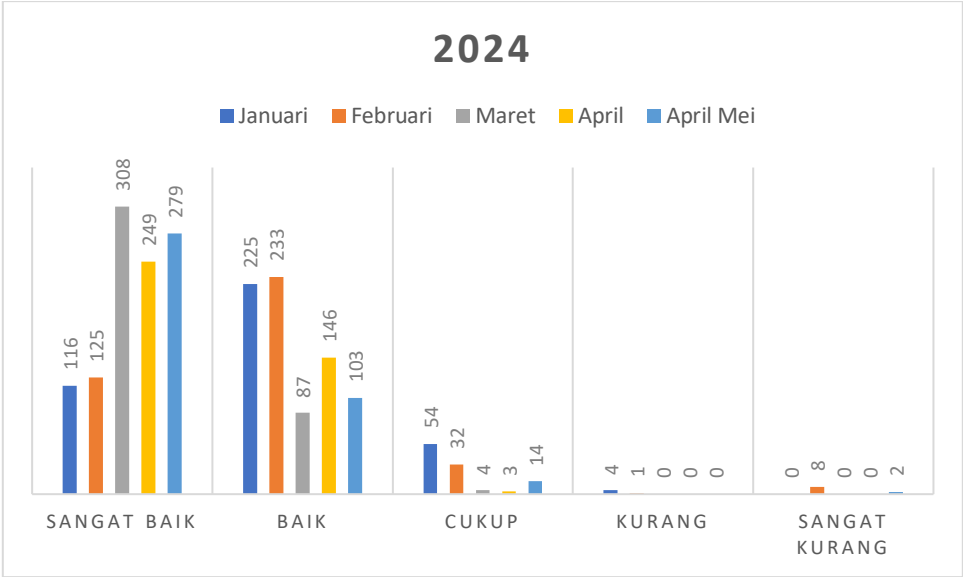
						tanggal yang berbeda dan dengan vendor yang sama.
2	8 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat Analisis Pengisian Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Oleh Perekam Medis di RS Prima Husada Malang Tahun 2024	Kepala bidang keperawatan, kepala bidang penunjang medis, sekretaris komite PPI, sekretaris komite Mutu dan beberapa karyawan rekam medis yang tidak bertugas sejumlah 8 staf.	Diklat internal Analisis Pengisian Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Oleh Perekam Medis di RS Prima Husada Malang dihadiri oleh seluruh nama yang ada di undangan.	Diklat memerlukan keberlanjutan dan ditujukan untuk seluruh perawat atau bidan atau staf nakes yang bertugas di ruangan dan berhubungan dengan rekam medis pasien.
3	11 Mei 2024	Pengajian Karyawan RS Prima Husada Malang Periode Mei Tahun 2024	Pengajian Karyawan RS Prima Husada Malang dengan Tema Menjaga Keseimbangan Antara Keluarga dan Pekerjaan dalam Bingkai Ibadah	Seluruh staf RS Prima Husada Malang yang sedang tidak bertugas, sejumlah 150 staf.	Pengajian karyawan dihadiri oleh 88 staf.	Share link review setiap selesai pengajian karyawan.
4	14 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat PPI Dasar Gelombang 1 Tahun 2024	Seluruh staf RS Prima Husada Malang sejumlah 414 (termasuk dokter IGD).	Pada Diklat PPI Dasar Gelombang 1 dihadiri oleh 182 staf RS Prima Husada Malang.	UMANDOK dimasukkan google drive supaya dapat diakses oleh rekan-rekan yang berhalangan hadir pada diklat PPI Dasar periode 2024.
5	15 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat PPI Dasar Gelombang 2 Tahun 2024	Seluruh staf RS Prima Husada Malang sejumlah 414 (termasuk dokter IGD).	Pada Diklat PPI Dasar Gelombang 1 dihadiri oleh 165 staf RS Prima Husada Malang.	
6	21 Mei 2024	Inhouse Training	Refreshment Training Public Speaking Bersama Bank Mandiri	Seluruh Kepala Bidang, Kepala Ruang, dan Kepala Instalasi Non Dokter RS Prima Husada Malang	Refreshment training dihadiri oleh 22 staf RS Prima Husada Malang.	Pembagian sertifikat peserta diklat dari SDM PT DPM kepada SDM RS PHM.
7	21 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat Kegawatdaruratan Jantung untuk Dokter Umum RS Prima Husada Malang Tahun 2024 (Materi Tatalaksana Awal Stemi oleh dr. Miryanti Cahyaningtyas, Sp.JP)	Seluruh dokter umum RS Prima Husada Malang berjumlah 10 orang.	Diklat dilaksanakan secara offline dan dihadiri oleh 3 dokter umum secara offline, dan 7 dokter umum hadir secara online.	Pada diklat selanjutnya jika pelaksanaan diklat secara offline maka tidak disediakan link zoom maupun google meet.
8	24 Mei 2024	Diklat	Diklat	Seluruh	Diklat	Materi diklat

		Internal	Kegawatdaruratan Jantung untuk Dokter Umum RS Prima Husada Malang Tahun 2024 (Materi ECG, Arrhythmia in Emergency Room oleh dr. Yoga Waranugraha, Sp.JP)	dokter umum RS Prima Husada Malang berjumlah 10 orang.	dilaksanakan secara offline dan dihadiri oleh 6 dokter umum.	akan dibagikan oleh dr. Wiryantari Akhdani kepada dokter umum yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan diklat.
9	25 Mei 2024	Pengajian Karyawan RS Prima Husada Malang Periode mei Tahun 2024	Pengajian Karyawan RS Prima Husada Malang dengan Tema Mengatasi Rasa Cemas dan Stres: Pembelajaran dari Sunnah dan Doa-doa.	Seluruh staf RS Prima Husada Malang yang sedang tidak bertugas, sejumlah 150 staf.	Pengajian karyawan dihadiri oleh 24 staf.	Share link review setiap selesai pengajian karyawan. Review kegiatan kajian selama bulan mei 2024 dan diinformasikan terkait evaluasi kegiatan oleh Kabid Umum & Keuangan kepada PT.
10	28 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat Kegawatdaruratan Jantung untuk Dokter Umum RS Prima Husada Malang Tahun 2024 (Materi Tatalaksana Awal NSTEMI)	Seluruh dokter umum RS Prima Husada Malang berjumlah 10 orang.	Diklat dilaksanakan secara online dan dihadiri oleh 8 dokter umum.	Materi diklat akan dibagikan oleh dr. Wiryantari Akhdani kepada dokter umum yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan diklat.
11	29 Mei 2024	Diklat Internal	Diklat Drill Emergency Maternal & Neonatal	Kepala bidang penunjang medis, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis, dan seluruh bidan RS Prima Husada Mlanag berjumlah 33 orang.	Diklat dihadiri oleh 3 kepala bidang dan 21 bidan RS Prima Husada Malang.	Umandok diklat dilengkapi dan dishare oleh pj diklat. Berkoordeinasi dengan pj diklat apakah ada kelanjutan dari Diklat Drill Emergency atau tidak.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	KATEGORI	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Sangat Baik	116	125	308	249	279
2	Baik	225	233	87	146	103
3	Cukup	54	32	4	3	14
4	Kurang	4	1	0	0	0
5	Sangat Kurang	0	8	0	0	2

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



Analisis :

- 1. Naik turun ini mayoritas adalah karena tingkat keterlambatan karyawan.Terdapat tren yang karyawan kategori “baik” menjadi “sangat baik”
- 2. Ada 2 staf dari unit farmasi dan CS dengan evaluasi kinerja sangat kurang di karenakan mangkir dari jadwal kerja yang telah di tentukan selama lebih dari 1 minggu

Rencana Tindak Lanjut :

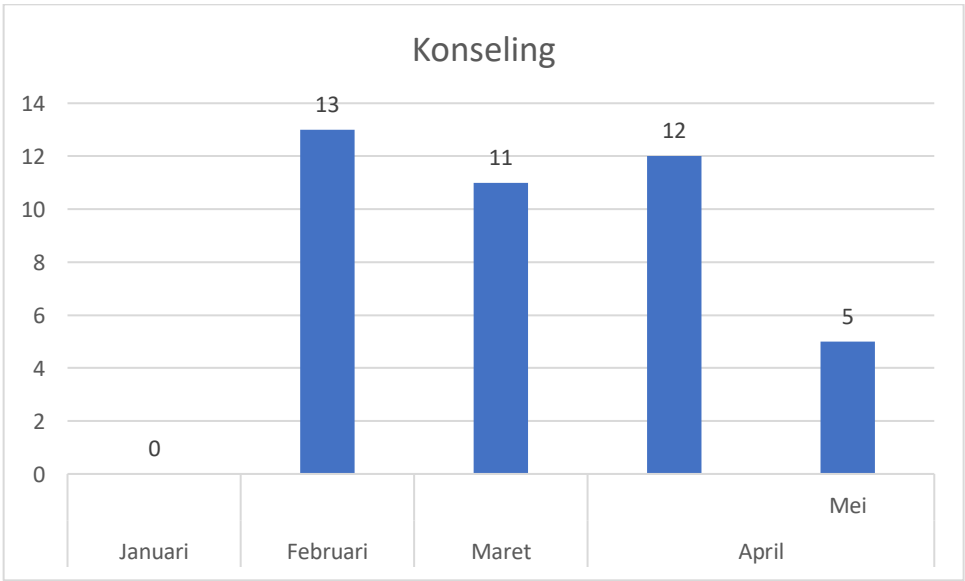
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Melakukan pemanggilan (bersurat) kepada petugas dengan evaluasi kinerja sangat kurang dan menonaktifkan petugas tersebut

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2024

NO	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Konseling	0	13	11	12	5

3.5.1.6.1.1 Grafik Jumlah Konseling



Analisis :

Program konseling karyawan rutin belum berjalan dikarenakan staf SDM masih menyesuaikan dengan jobdesk-jobdesk administratif lainnya. Jumlah konseling diatas adalah konseling karyawan dengan kasus tertentu.

Rencana Tindak Lanjut :

Mengkonsep Kembali program konseling dan menjadikannya program rutin dan berkelanjutan.

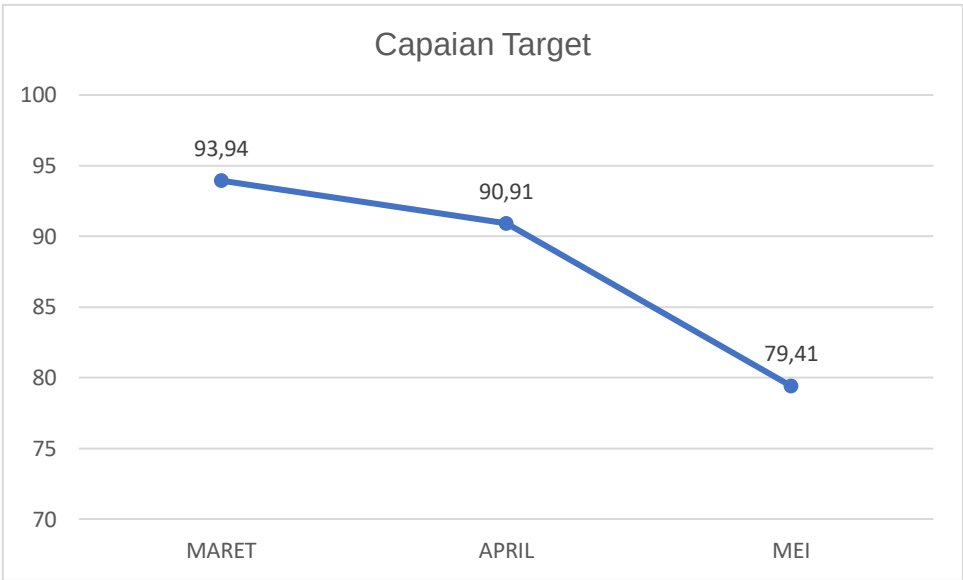
3.5.2 MFK dan K3RS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

NO	KET	TARGET	MARET	APRIL	MEI
1	Capaian Maintenance	90%	93,94	90,91	79.41



Analisis :

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien. Contoh IKO.

Rencana Tindak Lanjut :

Follow up ke Karu/Ka unit untuk memberikan info ketika alat medis yang belum di maintenance tidak dalam kondisi dipakai

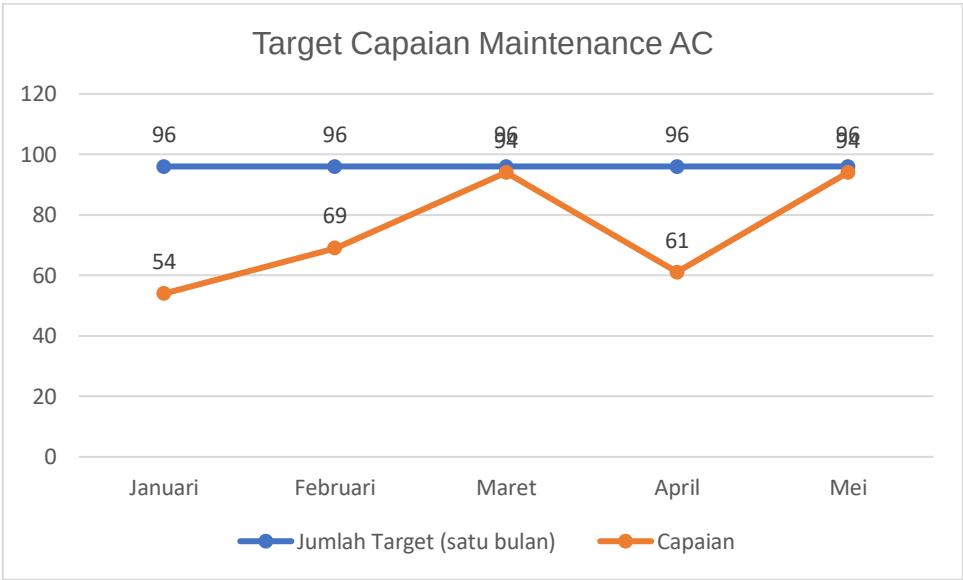
3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

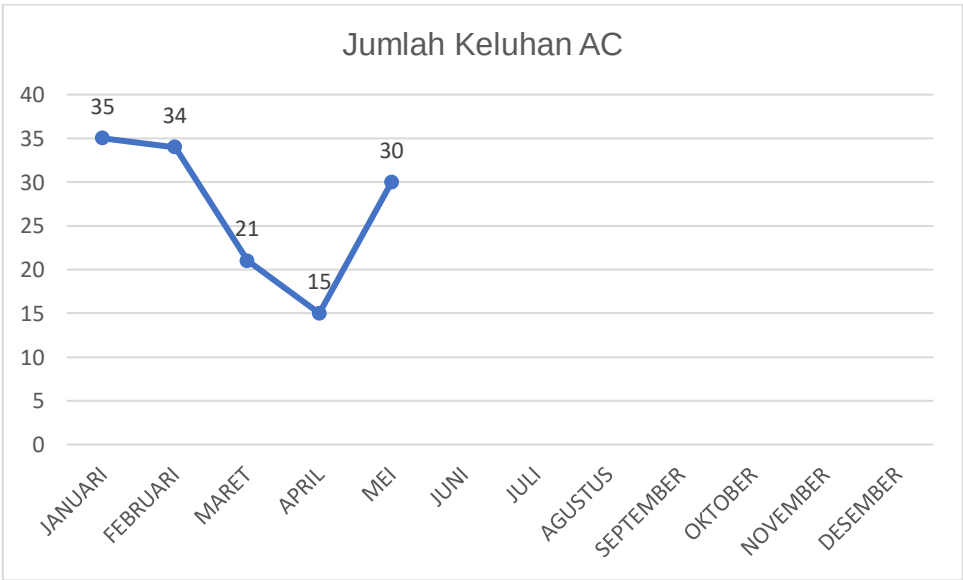
3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Januari	96	54	Belum mencapai target
2	Februari	96	69	Belum mencapai target
3	Maret	96	94	Belum mencapai target
4	April	96	61	Belum mencapai target
5	Mei	96	94	Belum mencapai target

3.5.2.2.1.2 Grafik Target Capaian Maintenance AC



3.1.1.1.1 Grafik Keluhan AC Split dari Unit



Analisis :

Sudah terdapat progress perbaikan yang baik terhadap pemeliharaan AC baik secara fisik maupun pelaporan ini berdampak pada keluhan staf di unit terhadap AC mulai berkurang setiap bulannya.

Beberapa penyebab yang mengakibatkan target masih tidak tercapai :

- 1. Masih ada pemeliharaan yang tidak tercatat sehingga tidak masuk laporan
- 2. Adanya tugas insidental diluar jadwal IPSRS
- 3. AC ruangan masih terdapat pasien / dalam pemakaian

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan evaluasi terutama terkait system pencatatan dan target perbulan.
- 2. Pembuatan aplikasi lokal IPSRS

3.5.2.2.3 Genset

3.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	5x/bulan	5x/bulan	100%	sudah mencapai target
2	Februari	5x/bulan	5x/bulan	100%	sudah mencapai target
3	Maret	5x/bulan	5x/bulan	100%	sudah mencapai target
4	April	5x/bulan	5x/bulan	100%	sudah mencapai target
5	Mei	5x/bulan	5x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Genset dilakukan perbaikan 5x dalam satu bulan. Selama 3 bulan terakhir genset sudah dilakukan maintenance sesuai SOP namun belum ada pelaporan yang rapi. Sejak bulan Maret tahun 2024 sudah terdata rapi dalam pelaporan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala

3.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil supervisi, petugas sudah berkeliling dan melakukan pencatatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

3.5.2.2.5 Liquid Oksigen

3.5.2.2.5.1 Gambar Bukti Supervisi Pencatatan Pemeliharaan Liquid Oksigen

<

Analisis :
Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.2.2.6 IPAL

3.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Pemeliharaan IPAL	1x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Pemeliharaan filter air	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.8 Lift

3.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Pemeliharaan lift	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.2.2.9 UPS

3.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

NO	KETERANGAN	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Pemeliharaan UPS	2x/bulan	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

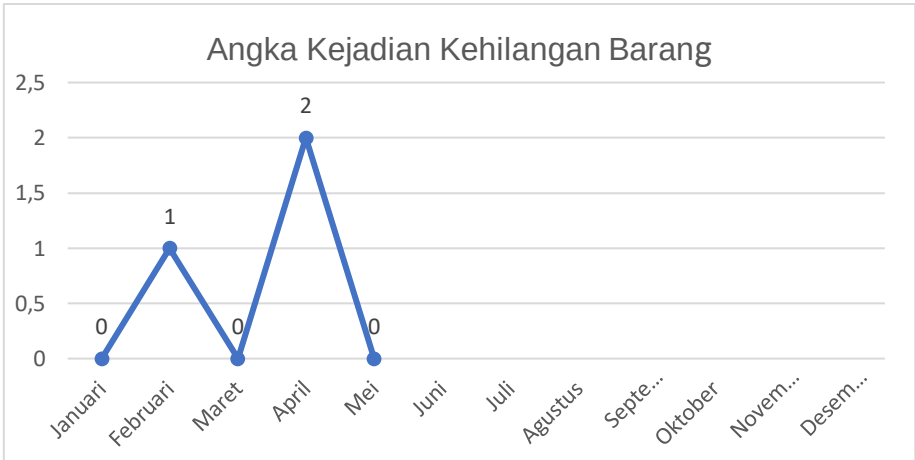
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1.	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	0	2	0

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



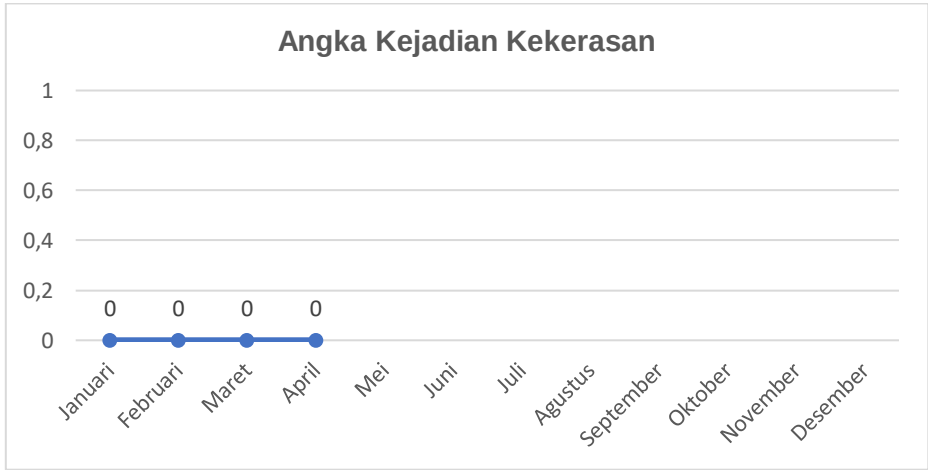
Analisis :
Tidak ada kehilangan barang pada bulan Mei 2024

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

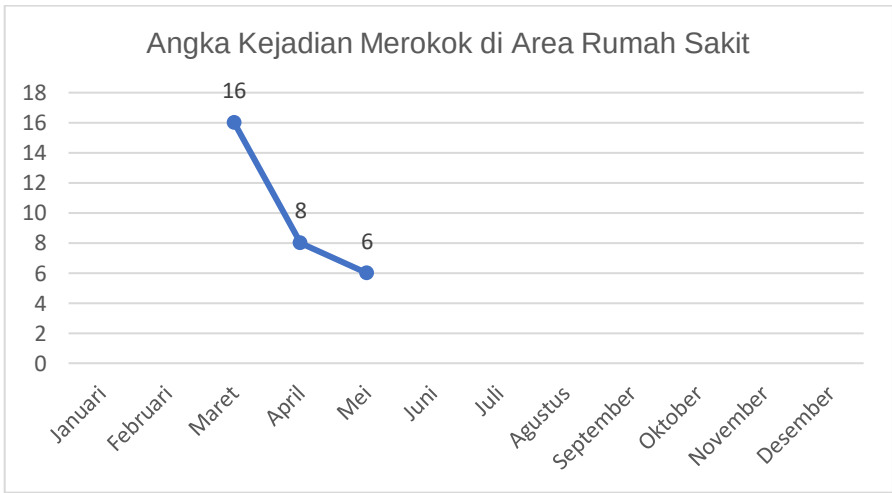


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	Tidak tercatat	Tidak tercatat	16	8	6



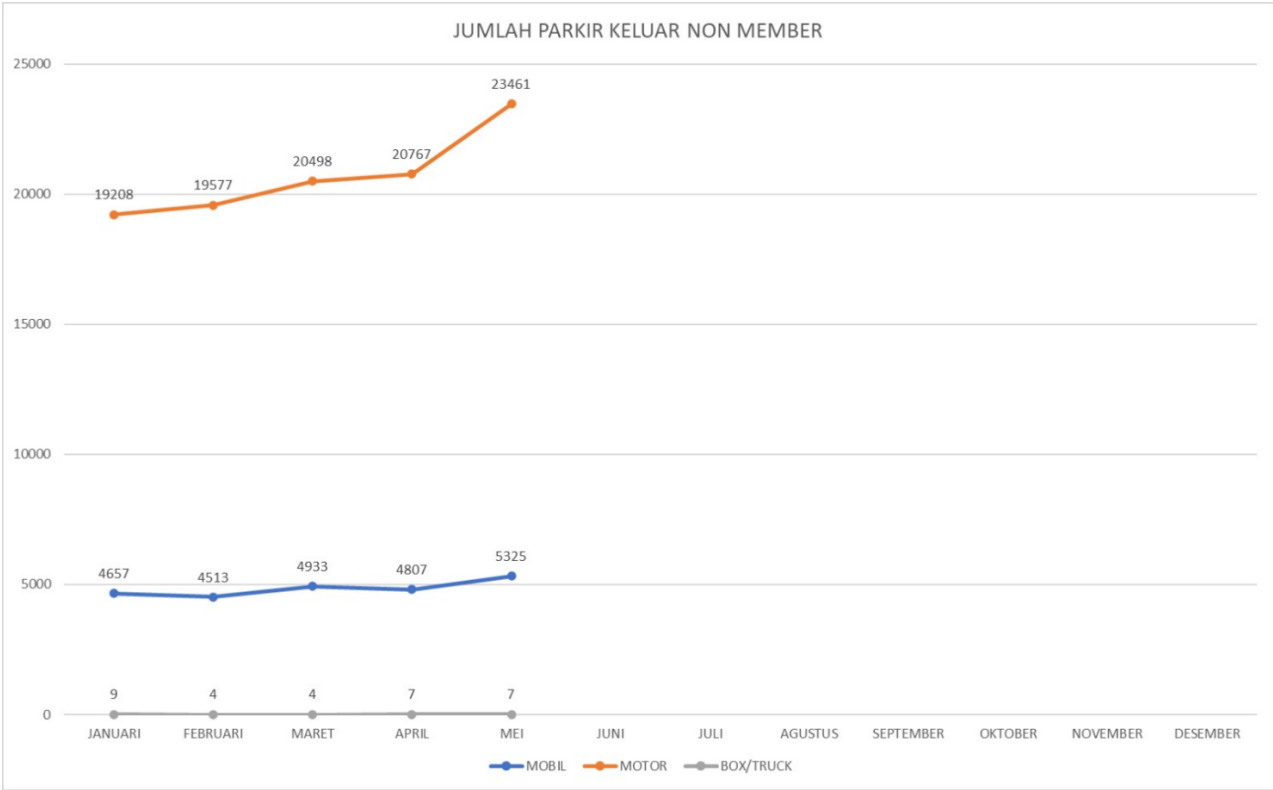
Analisis :
Angka kejadian merokok mulai tercatat rapi pada bulan Maret. Mengalami penurunan karena patroli dari satpam yang lebih intens dan dilaporkan dengan rapi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan teguran lisan kepada oknum yang merokok di area RS
2. Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member (Maret 2024)



Analisis :
Peningkatan kapasitas jumlah kendaraan parkir meningkat setiap bulan akibat kenaikan pasien, kendaraan yang masuk > 10 menit dan perluasan lahan parkir di belakang

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

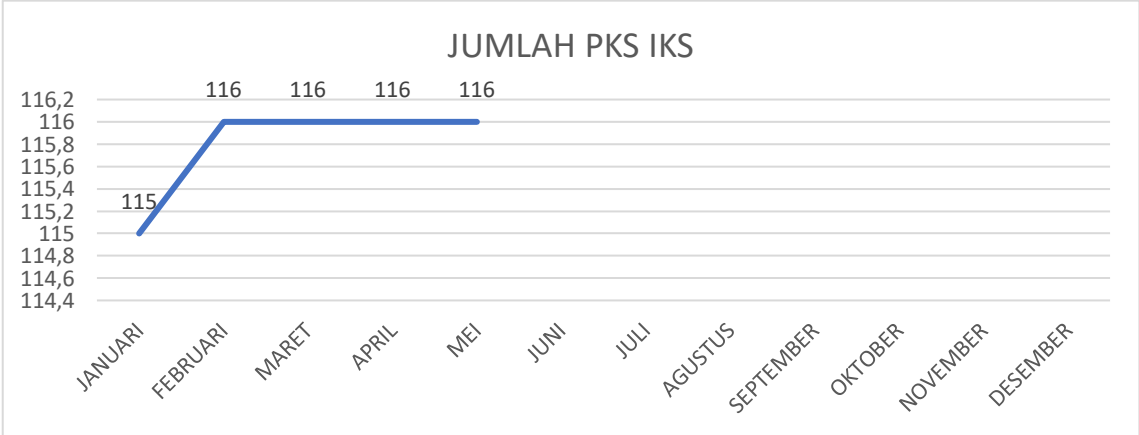
3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Tabel Jumlah PKS-IKS Aktif

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Jumlah PKS IKS AKTIF	115	116	116	116	116

3.5.5.1.2 Grafik Jumlah PKS – IKS



3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Bulan Mei 2024

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Pesta Pora Abadi	Review oleh pihak kedua	-
2	Batas Media 99	Disposisi PT	-
3	PT Yamaha Electronic Manufacturing Indonesia	Review oleh pihak kedua	-
4	PT Tentrem Sejahtera	Review oleh pihak kedua	-
5	PT Ustegra	Review oleh pihak kedua	-
6	PT Pancamas Elite	Disposisi PT	-
7	PT Unggul Anugerah Sejahtera	Disposisi PT	-
8	PT Bestari Murni Anugerah	Disposisi PT	-
9	PT Indonesia Marine	Review oleh pihak kedua	-
10	PT Randi Cones Indonesia	Review oleh pihak kedua	-
11	PT Kharisma Selaras	Review oleh pihak kedua	-
12	PT Indonesian Tobacco	Review oleh pihak kedua	-
13	PT Tonggak Ampuh	Review oleh pihak kedua	-
14	Klinik Beauty Medika	TTD Pihak kedua	-
15	Ibazz Aestetoc and Medical Center	Disposisi PT	-

Analisis :

- 1. Pada bulan Mei, PKS baru dengan instansi lain masih dalam progress
- 2. Progres MOU baru direalisasi setelah draft MOU baru di paparkan oleh Legal PT DPM
- 3. MOU masih dalam tahap review oleh pihak kedua

Rencana Tindak Lanjut :

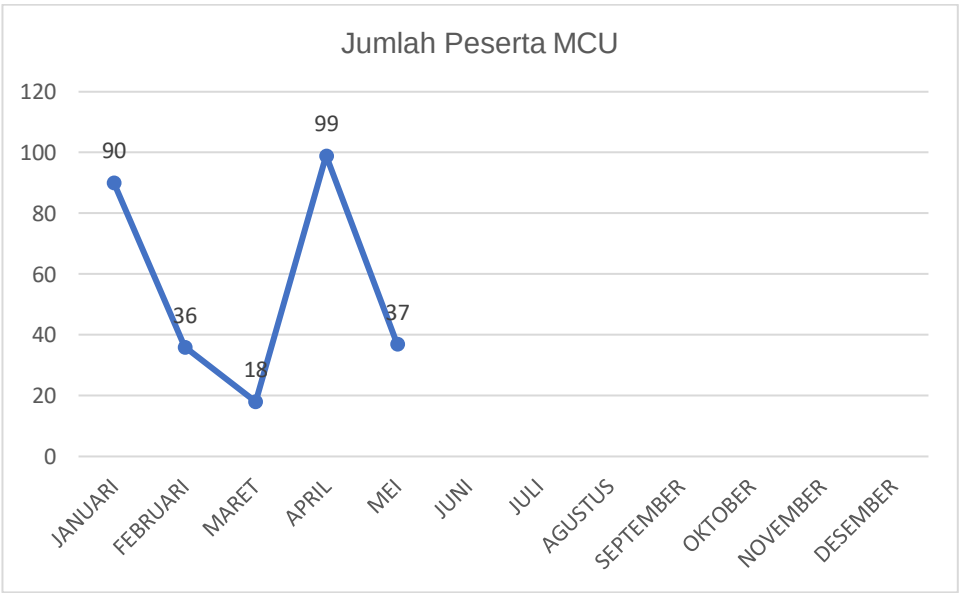
- 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua
- 2. Mengajukan surat permohonan PKS kepada Instansi Perusahaan, BPM, DPM, Klinik kesehatan, yang belum bekerjasama dengan RS Prima Husada Malang

3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Tabel Jumlah Peserta MCU

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	JUMLAH PESERTA MCU	90	36	18	99	37

3.5.5.2.2 Grafik Jumlah Peserta MCU



Analisis :

Berdasarkan data tersebut, jumlah pasien Medical Check Up menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Review hasil kunjungan dengan PDSA :

Plan :

- 1. Meningkatkan kunjungan ke Perusahaan
- 2. Meningkatkan kunjungan ke Universitas dan sekolah yang membutuhkan medical Check Up
- 3. Mempromosikan program MCU
- 4. Mereview tarif/biaya pemeriksaan

Do :

- 1. Mempromosikan program MCU setiap kali melakukan kunjungan ke instansi Perusahaan dan Universitas
- 2. Koordinasi dengan bagian keuangan terkait review tarif MCU agar bisa bersaing dengan vendor lain

Study :

- 1. Harga MCU mempengaruhi jumlah kunjungan MCU.
- 2. Perusahaan dan universitas memilih harga MCU paling murah diantara vendor.
- 3. Banyak perusahaan memilih MCU yang ditawarkan secara gratis dari klinik rekanan BPJS kesehatan karena hanya sebagai syarat pemenuhan dari Disnaker terkait kesehatan karyawan.

Action :

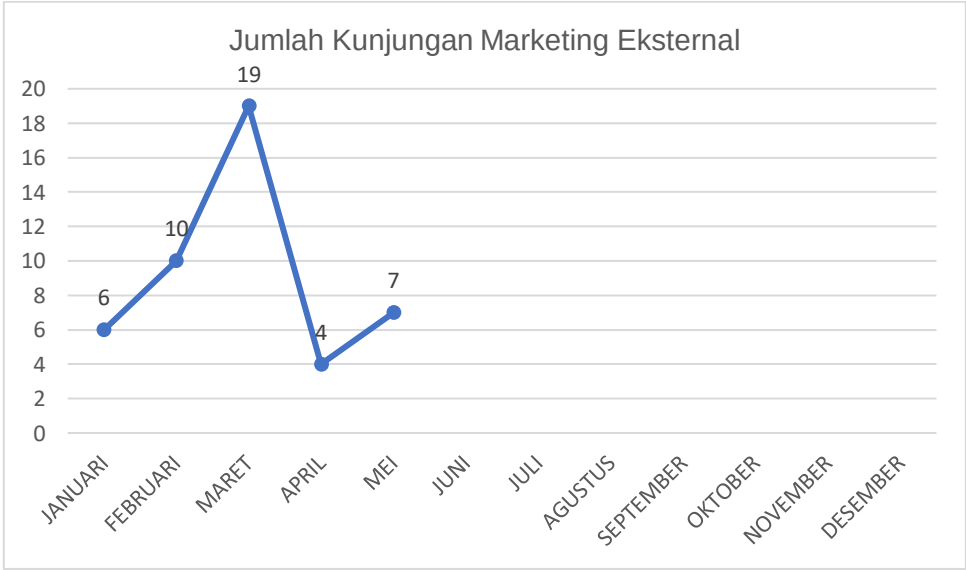
- 1. Pengajuan MCU ke berbagai Perusahaan untuk calon karyawan baru dan ke Institusi Pendidikan untuk calon Mahasiswa baru
- 2. Review harga pemeriksaan khusus untuk MCU

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	Jumlah Kunjungan	6	10	19	4	7

3.5.5.2.3.2 Grafik Jumlah Kunjungan Marketing Eksternal



Analisis :

Pada bulan Mei tidak maksimal untuk kunjungan perusahaan

Rencana Tindak Lanjut :
Menghubungi HRD dalam list perusahaan untuk menjadwalkan kunjungan kembali bagi perusahaan yang belum.

3.5.6 Penjaminan

3.5.6.1 Piutang

3.5.6.1.2 Tabel Piutang BPJS Kesehatan (FPK dan Pengajuan Reguler Mei 2024

REKAPITULASI FPK BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	TARIF FPK/ PENGAJUAN	TGL FPK	TGL BAYAR	REALISASI PEMBAYARAN	SELISIH AUDIT DAN ADM BANK	SALDO PIUTANG FPK
PELAYANAN 2023							
							-
1	OBAT KRONIS SEPT 23	435.837.336	18.01.2024	29.01.2024	435.837.336		-
2	FPK REG UTAMA DES 23	6.189.055.000	18.01.2024	29.01.2024	6.189.055.000		-
5	FPK 'OBAT KRONIS OKT 23	493.809.876	18.02.2024	26.02.2024	493.809.876		-
6	FPK LUPIS NOV 23 AMBULANCE	6.650.000	22.02.2024	28.02.2024	6.650.000		-
7	FPK LUPIS NOV 23 ALKES	6.215.000	22.02.2024	28.02.2024	6.215.000		-
8	FPK LUPIS DES 23 AMBULANCE	7.210.000	22.02.2024	28.02.2024	7.210.000		-
9	FPK LUPIS DES 23 ALKES	6.710.000	22.02.2024	28.02.2024	6.710.000		-
10	FPK OBAT KRONIS NOV 2023	465.212.636	21.03.2024	01.04.2024	465.212.636		-
11	FPK PEND DES 23	607.514.500	06.03.2024	18.03.2024	607.514.500		-
12	FPK OBAT KRONIS DES 2023	469.804.704	25.03.2024	03.04.2024	469.804.704		-
13	FPK OBAT KRONIS Pend Des 23	10.367.860	08.05.2024	20.05.2024	10.367.860		-
PELAYANAN 2024							
1	FPK Januari 2024	7.006.082.092	18.02.2024	28.02.2024	6.967.698.792	38.383.300	-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	6.015.000	20.03.2024	16.04.2024	6.015.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	12.485.000	20.03.2024	16.04.2024	12.485.000		-
	FPK OR Januari 2024	516.543.814	08.05.2024	20.05.2024	516.543.814		-
	FPK Pending Januari 2024	468.390.779	08.05.2024	20.05.2024	468.390.779		-
2	FPK Februari 2024	7.215.241.743	20.03.2024	28.03.2024	7.215.241.743		-
	FPK LUPIS JAN 24 AMBULANCE	7.740.000	20.03.2024	16.04.2024	7.740.000		-
	FPK LUPIS JAN 24 ALKES	3.795.000	20.03.2024	16.04.2024	3.795.000		-
	FPK OR Februari 2024	498.722.702	08.05.2024	20.05.2024	498.722.702		-
3	FPK Maret 2024	7.372.267.949	26.04.2024	08.05.2024	7.350.598.749	21.669.200	-
4	FPK April 2024	6.926.723.374	20.05.2024	29.05.2024	6.901.742.874	24.980.500	-
5	Reguler Mei 2024 belum FPK	7.963.106.400					7.963.106.400
		46.695.500.765			38.647.361.365	85.033.000	7.963.106.400

3.5.6.1.3 Tabel Saldo Pending BPJS Kesehatan

REKAP KLAIM DAN PENDING BPJS KESEHATAN							
NO	PERIODE LAYANAN	JENIS	JML KLAIM	FPK	Tidak Layak	JML PEND	% PEND
1	FEB 24	RJ	11.519	11.510	2	9	0,1%
		RI	1.004	915	-	89	9%
2	MARET 24	RJ	11.887	11.882		5	0,0%
		RI	1.104	983		121	11%
3	APRIL 24	RJ	11.384	11.366	2	18	0,2%
		RI	1.082	990	-	92	9%

3.5.6.1.4 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG				JUMLAH PIUTANG
		a	b	(a-b-c= d)	e	f	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	Total
	PERIODE MEI 2024 :											
1	Asuransi	168.979.473	120.922.812	46.145.111	187.428.540	30.396.208	202.095.404	191.500.991	2.195.025	4.033.612	1.957.034	202.095.404
2	Perusahaan	132.549.736	40.518.420	91.957.885	78.049.331	3.468.000	166.489.216	157.936.508	-	-	-	166.489.216
3	Mandiri Inhealth	109.570.125	34.063.416	75.700.737	23.972.831	-	99.673.569	99.673.569	-	-	-	99.673.569
4	Jasa Raharja	161.006.944	161.006.944	0	70.977.004	21.086.923	49.890.081	49.890.081	-	-	-	49.890.081
5	BPJS Ketenagakerjaan	1.888.415.758	687.350.600	1.193.241.632	458.053.471	-	1.651.295.103	1.648.082.202	-	-	-	1.651.295.103
							2.169.443.372	2.147.083.350	2.195.025	4.033.612	1.957.034	2.169.443.372

Keterangan :

- 1 Cut off piutang per tanggal 31 Mei 2024 dengan saldo Rp 2.169.443.372,-
- 2 Piutang Asuransi jatuh Tempo Reliance sudah dilakukan penutupan layanan dan sudah bersurat email ke asuransi.
- 3 BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan pembayaran pada bulan Mutasi bank mei sebesar Rp 687.350.600,-

3.5.6.2 Klaim Pending

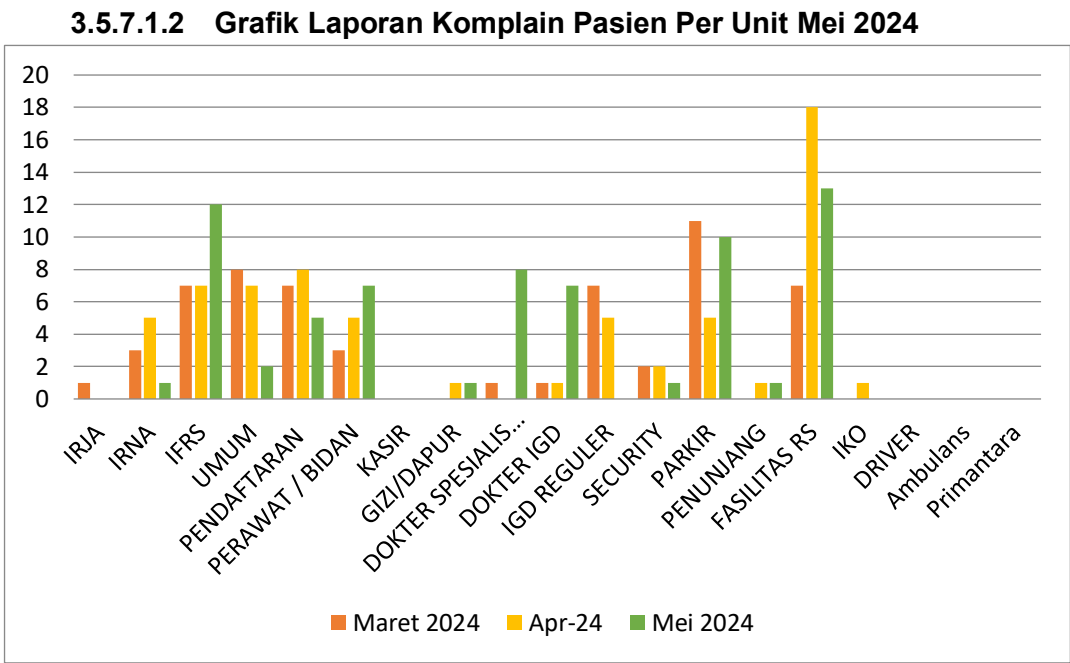
NO	MASALAH	DAMPAK	TINDAK LANJUT
1.	Penggunaan diagnosa Fever pada pasien Demam	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
2.	Penggunaan diagnosa Gerd diminta Resleksi Dyspepsia	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending
3.	Konfirmasi indikasi tindakan USG pada Rawat Jalan	Klaim Pending	Menjawab konfirmasi pending

3.5.7 PIPP – MOD – MPP

3.5.7.1 Laporan Komplain Pasien

3.5.7.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Mei 2024

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1.	IRJA	1	0	0
2.	IRNA	3	5	1
3.	IFRS	7	7	12
4.	UMUM	8	7	2
5.	PENDAFTARAN	7	8	5
6.	PERAWAT / BIDAN	3	5	7
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	0	1	1
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	1	0	8
10.	DOKTER IGD	1	1	7
11.	IGD REGULER	7	5	0
12.	SECURITY	2	2	1
13.	PARKIR	11	5	10
14.	PENUNJANG	0	1	1
15.	FASILITAS RS	7	18	13
16.	IKO	0	1	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	0
Total		60	66	68



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Mei 2024 mengacu pada komplain pasien. Asal komplain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- 1. Pada bulan Mei 2024 jumlah komplain Terjadi peningkatan dibanding bulan April 2024 yaitu sebanyak 68 kasus complain.
- 2. Komplain terbanyak pada bulan Mei 2024 yaitu dari Fasilitas RS sebanyak 13 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 15 jenis komplain dengan rincian :
 - 1) Fasilitas RS sebanyak 7 kasus (Penambahan jumlah kursi tunggu poli rawat jalan spesialis, penambahan ruangan kelas 1 dan penempatan jumlah pasien 1 kamar yang terlalu banyak 4 orang)
 - 2) Parkir sebanyak 8 kasus terkait tarif dan luas lahan parkir

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

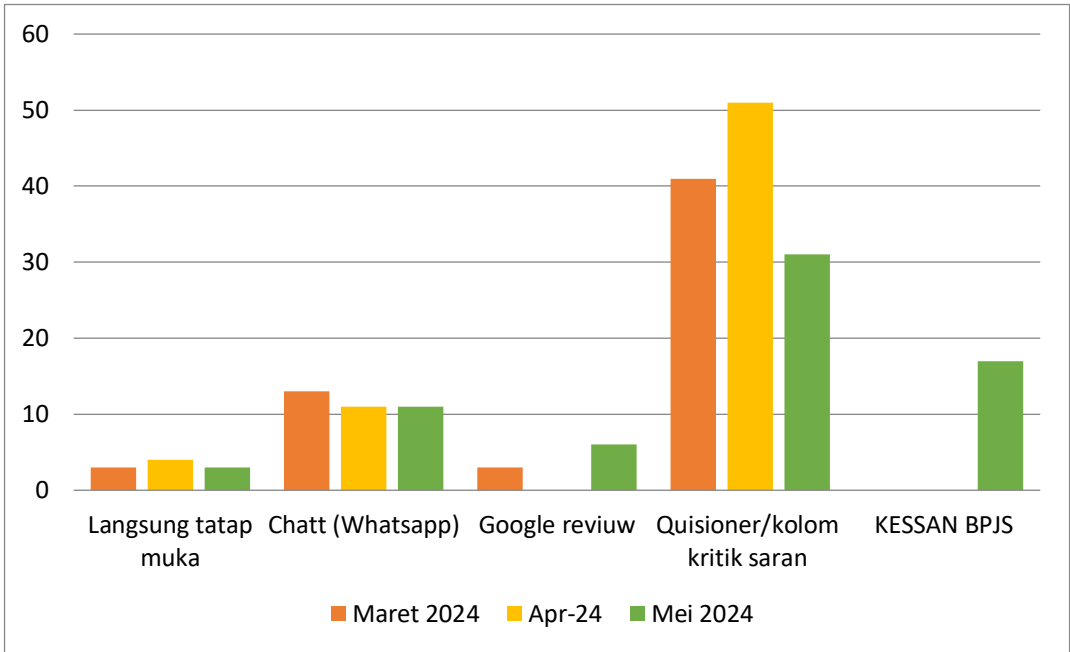
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Mei 2024				
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1.	Langsung tatap muka	3	4	3
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	13	11	11
	b. Google review	3	0	6
3.	Quisioner/kolom kritik saran	41	51	31
4.	KESSAN BPJS	0	0	17
Total		50	50	60

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	1	0	5	16	18

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Mei 2024



Analisis :

Pada bulan Mei 2024 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 31 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari kessan BPJS kesehatan sebanyak 17 kasus kemudian complain dari chattt WA sebanyak 11 kasus, secara tatap muka / langsung 3 kasus, sedangkan dari google rewiuw sebanyak 6 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplai Bulan Mei 2024

NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	WAKTU TANGGAP		WAKTU PENYELESAIAN		< 3 HR MANAJERIAL RS	7 HR KE PT
		STANDARD < 5 ‘	PENCAPAIAN (DARI WAKTU TOTAL DIBAGI JML KOMPLAI ATAU RATA2 WAKTU TANGGAP)	STANDARD < 60 ‘	PENCAPAIAN		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	3	0	0
					100%		
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	11	0	1
					91%		
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	6	0	0
					100%		
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	31	0	10
					71%		
5.	KESSAN	100%	0	100%	17	3	1
					71.4%		

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian complain pasien pada bulan Mei 2024 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui chatt capaian 91%, dari kuisisioner capaian 71% dan dari Kessan 71.4%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS dan parkir yang memerlukan diskusi dengan manajemen.
Adapun Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 15 jenis complain dengan rincian :

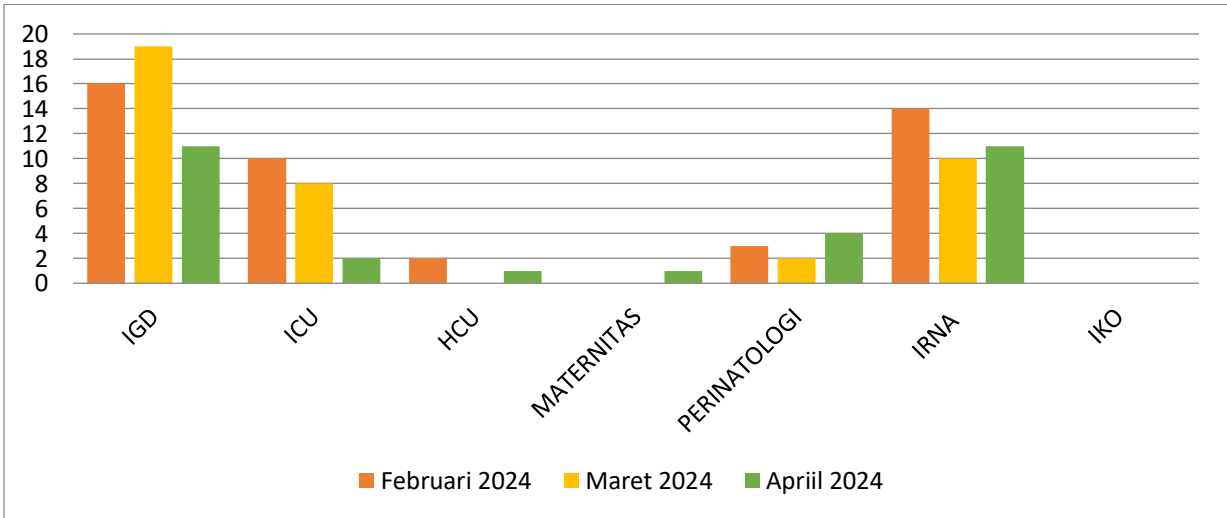
- 1) Fasilitas RS sebanyak 7 kasus
 Penambahan jumlah kursi tunggu poli rawat jalan spesialis, penambahan ruangan kelas 1 dan penempatan jumlah pasien 1 kamar yang terlalu banyak 4 orang
- 2) Parkir sebanyak 8 kasus terkait tariff dan luas lahan parkir

Rencana Tindak Lanjut :
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait diantaranya :
1) Fasilitas RS
 a) Jumlah kursi tunggu → sudah konfirmasi ke IRJA untuk melakukan penghitungan kembali jumlah kursi yang tersedia, bila kurang bisa melakukan pengajuan penambahan kursi tunggu pasien
 b) penambahan ruangan kelas 1 dan penempatan jumlah pasien 1 kamar yang terlalu banyak 4 orang → sudah sesuai dengan kondisi gedung Rumah sakit
2) Parkir
 a) Terkait parkir yang dikeluhkan adalah tarif parkir yang terlalu mahal dan tidak ada akses khusus untuk pasien rawat inap, sehingga keluarga pasien terlalu banyak membayar parkir setiap keluar masuk RS saat mengambil barang dirumah atau diluar RS.
 b) Sudah dilakukan pelaporan oleh Kabid umum dan keuangan ke PT terkait hal tersebut → Untuk tariff tidak bisa berubah

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Mei 2024

NO	UNIT PERUJUK	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1.	IGD	16	19	11
2.	ICU	10	8	2
3.	HCU	2	0	1
4.	MATERNITAS	0	0	1
5.	PERINATOLOGI	3	2	4
6	IRNA	14	10	11
7	IKO	0	0	0
Total		45	39	30

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan April 2024



- Analisis :**
- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam 3 bulan terakhir, jumlah terbanyak pada bulan April 2024 yaitu dari Unit IGD yaitu 11 pasien, IRNA 11 pasien, ICU 2 pasien, HCU 1 pasien, Neonatologi 4 pasien, Maternitas 1 pasien, dengan total pasien rujukan keluar April 2024 sebanyak 30 pasien.
 - Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Spesialis Bedah Syaraf, Bedah Anak, Bedah Digestif.
 - Percutaneous Coronary Intervention (PCI).
 - Hemodialisis (HD)
 - Pro scleroterapi endoscopy.
 - Pro kolonoskopi.
 - Stroke unit.
 - Membutuhkan alat khusus (locking plate, C-Arm)
 - Membutuhkan ventilator bayi
 - Alasan rujuk karena plavon habis pada bulan april 2024 tidak ada.

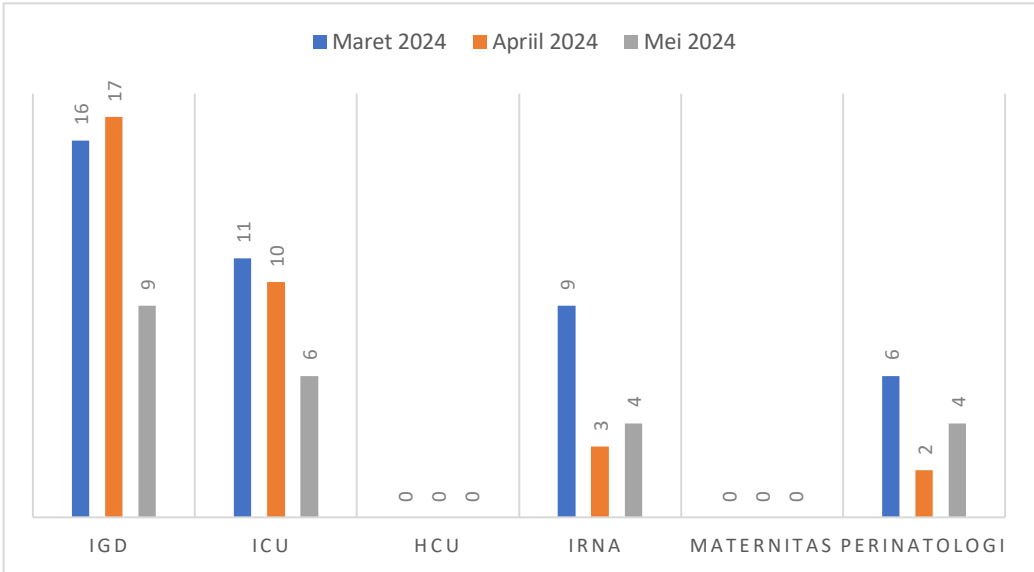
- Rencana Tindak Lanjut :**
- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
 - Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.6 Pengisian Form A, B, Discart Planning

3.5.7.6.1 Kelengkapan Pengisian Form A-B dan Dischard Palanning Bulan Mei

NO	NAMA PETUGAS	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH
1	Daning Pravitia YSM, S.Tr.Keb	92	32
2	Novita Pratama M,Amd.Keb	96	33
3	Fadilla Ayu,S.Kep	111	34
4	Cindytya,S.Kep	106	33
5	Wiwit Indah Yanti,S.Kep	97	32

3.5.7.6.2 Grafik Jumlah Pasien Meninggal Bulan Mei 2024



- Analisis :
- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Mei 2024 sebanyak 23 pasien
 - Jumlah terbanyak yaitu dari IGD sejumlah 9 pasien, ICU sebanyak 6 pasien, Neonatologi sebanyak 4 pasien yang terdiri dari IUFD 2 dan premature 2 dan dari IRNA sebanyak 4 pasien.
 - Pada bulan Mei 2024 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.
 - Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.7 Pengisian Form A, B dan Discart Planning

3.5.7.7.1 Tabel Kelengkapan Pengisian Form A, B dan Discart Planning

NO	NAMA PETUGAS	FEBRUARI		MARET		APRIL	
		FORM MPP	DISCARD PLANING	FORM MPP	DISCARD PLANING	FORM MPP	DISCARD PLANING
		JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
1	Daning Pravitia YSM,S.Tr.Keb	48	32	52	32	64	32
2	Novita Pratama M,Amd.Keb	43	33	43	33	66	33
3	Fadilla Ayu,S.Kep	29	34	49	34	58	34
4	Cindytya,S.Kep	32	33	42	33	62	33
5	Wiwit Indah Yanti,S.Kep			32	32	48	32

3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Tabel Evaluasi

NO	JENIS	TARGET	MEI	
			CAPAIAN	PROSENTASE
1	SEIRI / RINGKAS	6	4.02	67%
2	SEITON / RAPI	8	7.00	88%
3	SEISO / RESIK	66	36.12	55%
4	SEIKETSU / RAWAT	8	5.67	71%
5	SHITSUKE / RAJIN	12	8.09	67%

Analisis :
Metode evaluasi unit CS masih dilakukan bertahap dilakukan uji coba pada bulan Maret 2024. Monitoring dan evaluasi metode kemudian dilakukan perbaikan pada bulan April. Hasil mulai terlihat pada bulan Mei 2024. Capaian masih belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh : penyesuaian pengisian borang supervise baru oleh ka unit CS, hasil supervise dilapangan yang masih banyak perlu pembenahan termasuk kebersihan area (55%)

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Penyempurnaan pengisian borang di bulan Mei 2024
 - 2. Supervisi rutin dengan evaluasi terfokus pada Seiso/resik

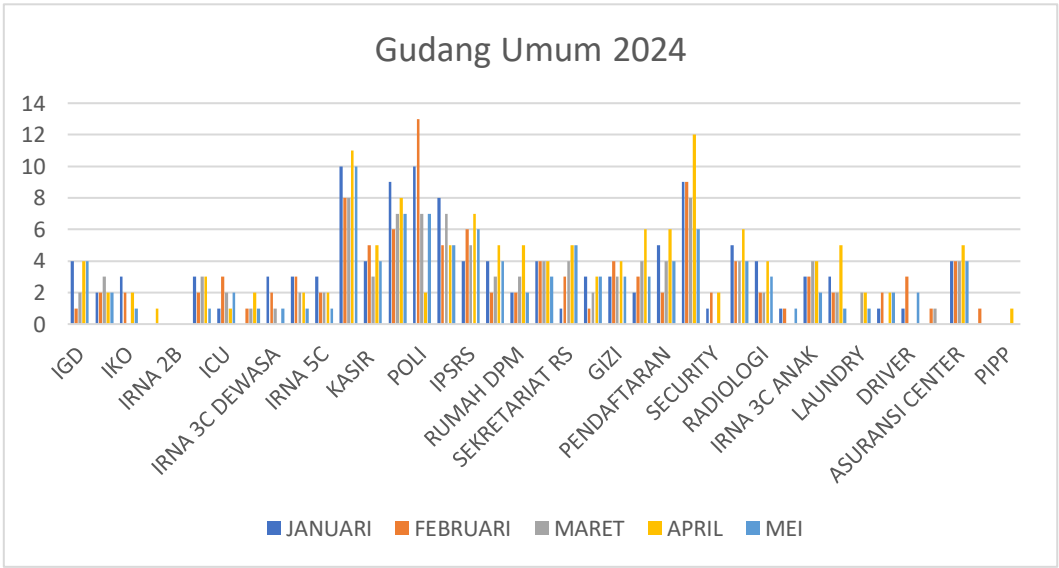
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	IGD	1	2	4	4
2	MATERNITAS	2	3	2	2
3	IKO	2	0	2	1
4	IRNA 2A	0	0	1	0
5	IRNA 2B	0	0	0	0
6	IRNA 2C	2	3	3	1
7	ICU	3	2	1	2
8	IRNA 3A	1	1	2	1
9	IRNA 3C DEWASA	2	1	0	1
10	IRNA 4C+4A	3	2	2	1
11	IRNA 5C	2	2	2	1
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	8	8	11	10
13	KASIR	5	3	5	4
14	DAPUR	6	7	8	7
15	POLI	13	7	2	7
16	CLEANING SERVICE	5	7	5	5
17	IPSRs	6	5	7	6
18	GUDANG FARMASI	2	3	5	4
19	RUMAH DPM	2	3	5	2

20	SEKRETARIAT PT	4	4	4	3
21	SEKRETARIAT RS	3	4	5	5
22	CSSD	1	2	3	3
23	GIZI	4	3	4	3
24	REKAM MEDIS	3	4	6	3
25	PENDAFTARAN	2	4	6	4
26	DEPO FARMASI	9	8	12	6
27	SECURITY	2	0	2	0
28	LABORATORIUM	4	4	6	4
29	RADIOLOGI	2	2	4	3
30	FISIOTERAPI	1	0	0	1
31	IRNA 3C ANAK	3	4	4	2
32	NS NICU	2	2	5	1
33	LAUNDRY	0	2	2	1
34	LANTAI 6A,7A,8A	2	0	2	2
35	DRIVER	3	0	0	2
36	SIMRS	1	1	0	0
37	ASURANSI CENTER	4	4	5	4
38	DPW	1	0	0	0
39	PIPP		0	1	0

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang



Analisis :
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara Sehat

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke all unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.6 Komite dan Tim

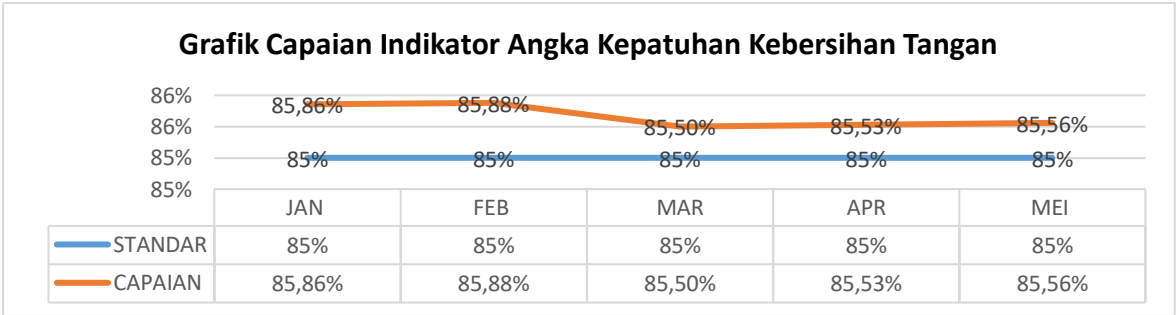
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
INDIKATOR MUTU NASIONAL							
1	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,04%	93,15%	93,3%	93,52%	93,73%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	95,2%	91,7%	95,74%	52,7%	65,2%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	76,19%	79,08%	79,28%	78,06%	76,32%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,46%	97,5%	98,9%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	63,8%	71,62%	67,56%	66,7%	100%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	93,15%	100%	100%	100%
13	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%

3.6.1.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

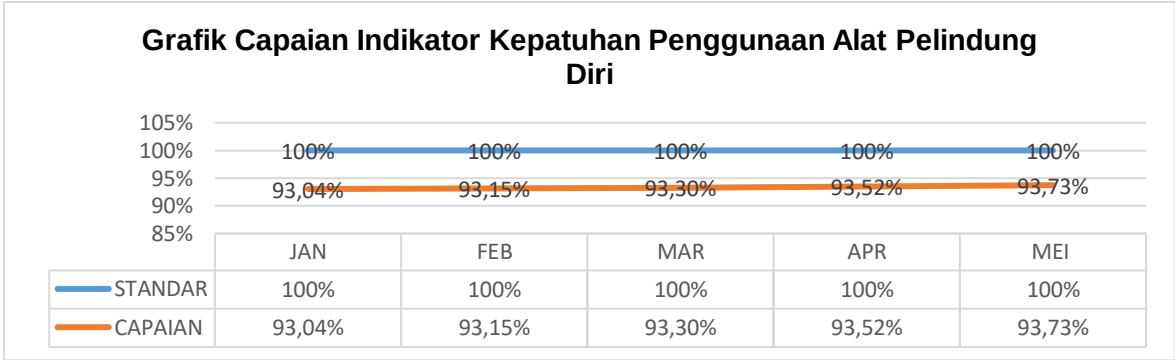
3.6.1.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,56%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	-Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

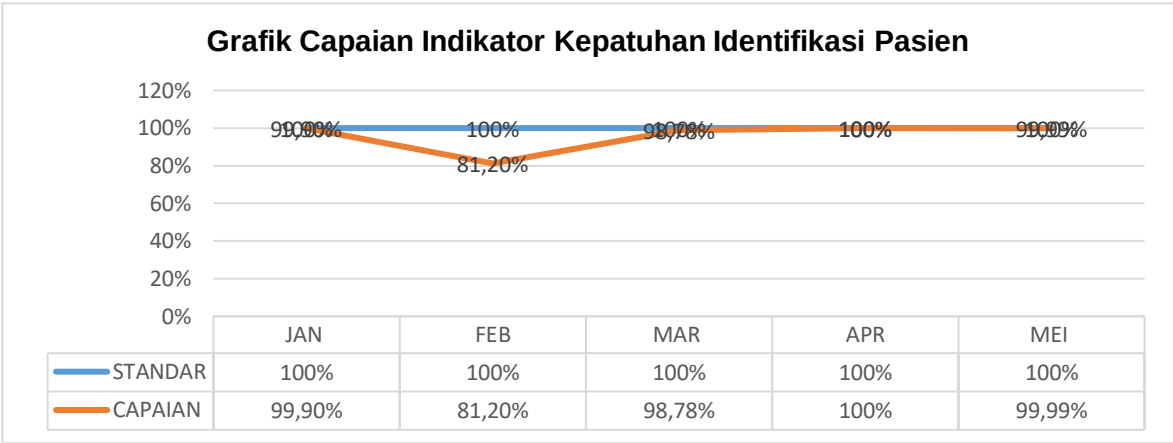


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	- Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,52% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, penggunaan APD oleh petugas nakes non dokter sudah cukup baik, namun masih ditemukan 1 petugas yang masih berlebihan memakai APD, seperti halnya pada salah satu dokter yang lebih memilih memakai handscoon saat visite karena beranggapan safety untuk dirinya. Peningkatan APD juga ada pada unit CS Dimana petugas sudah tertib memakai sarung tangan kerja, tidak memakai handscoon saat membersihkan ruangan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. - Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. - Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. - Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan
---------------------------------------	---	--	--	---	------------

3.6.1.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

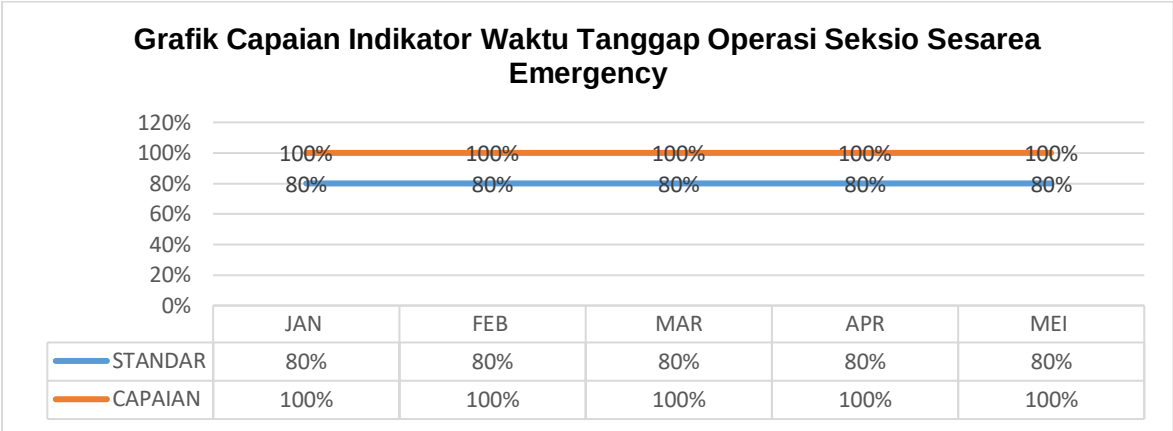
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei, capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu bulan

3.6.1.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

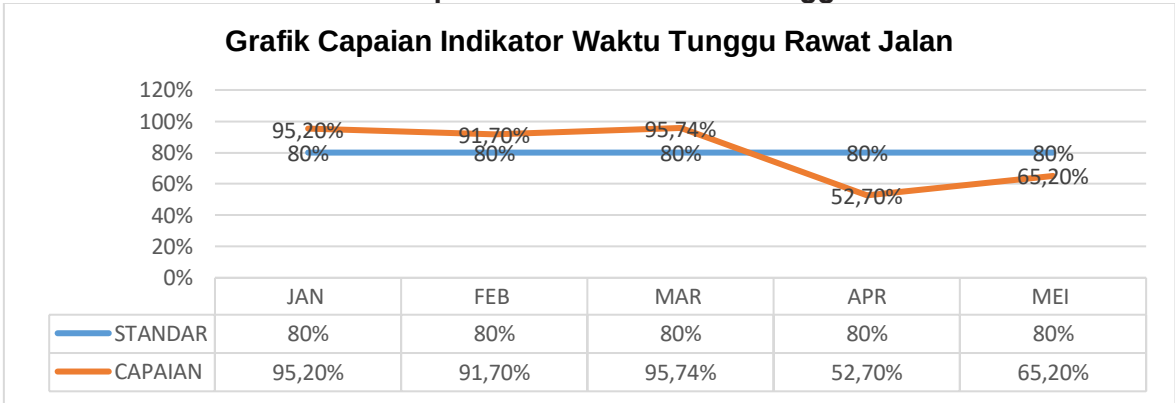
3.6.1.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisa Capaian :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 juga capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea Emergency telah mencapai standart. Tim IGD dan IKO melakukan koordinasi dan tindakan secara tepat dan cepat sehingga operasi bisa dilaksanakan.

3.6.1.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

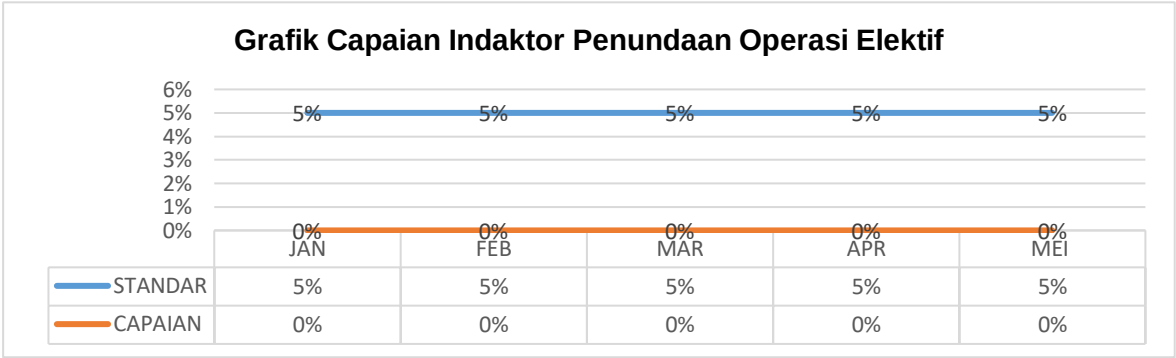
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator waktu rawat jalan hingga mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang sering datang terlambat.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024 telah mencapai standart jika dilihat dari input mutu pada SIMRS, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan hasil supervisi dan juga keluhan terkait keterlambatan dokter untuk praktek poli. Berdasarkan hal tersebut, mutu melakukan penilaian dengan observasi langsung dan juga mengevaluasi keterlambatan DPJP. Pada bulan Mei tahun 2024 diketahui prosentase waktu tunggu rawat jalan 65,2% dan dapat disimpulkan belum mencapai standart. - Dpjp tepat waktu : dr.Farid, Sp.N, dr. Aida, Sp.OG, dr. Akhmad Syahrir, Sp.N, dr. Ardhi Bustami, Sp. PD, dr. Dewi Maharani, Sp.S, dr. Dicky, Sp.A, dr.Vita, Sp.KK, dr.Humaira, Sp.OG, dr.Ira, Sp.JP, dr.Miryanti, Sp.JP, dr.Nimim, Sp.THT.KL, dr.Pradana,Sp.U, dr.Yoga, Sp.JP, dr.Zora, Sp.PD , dr Viona Sp.A - Dpjp Tidak tepat waktu : dr.Andi,Sp.B, dr.Andy,Sp.P, dr.Elvi,Sp.P, dr.Iwan,Sp.B, dr.Nurhadi,Sp.M, - Dpjp dengan tindakan lama : dr. Anton, Sp.B, dr.Huda, Sp.KJ, dr.Didid, Sp.KJ, dr.Eko, Sp.KFR.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Meningkatkan capaian indikator waktu tunggu rawat jalan.	Waktu tunggu rawat jalan <80%	Mengevaluasi dpjp yang sering terlambat dan juga memberikan teguran melalui komdik dan SDM.	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.6 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

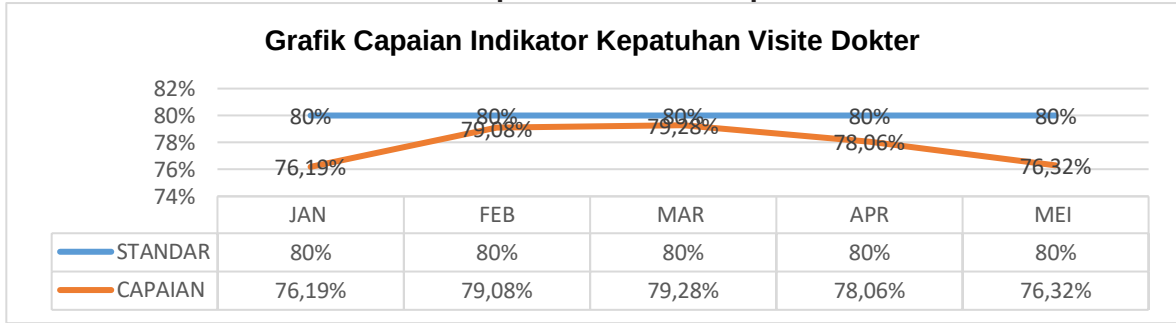


Analisa Capaian :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selama bulan Januari hingga Mei tahun 2024 tidak ada penundaan operasi elektif.

3.6.1.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

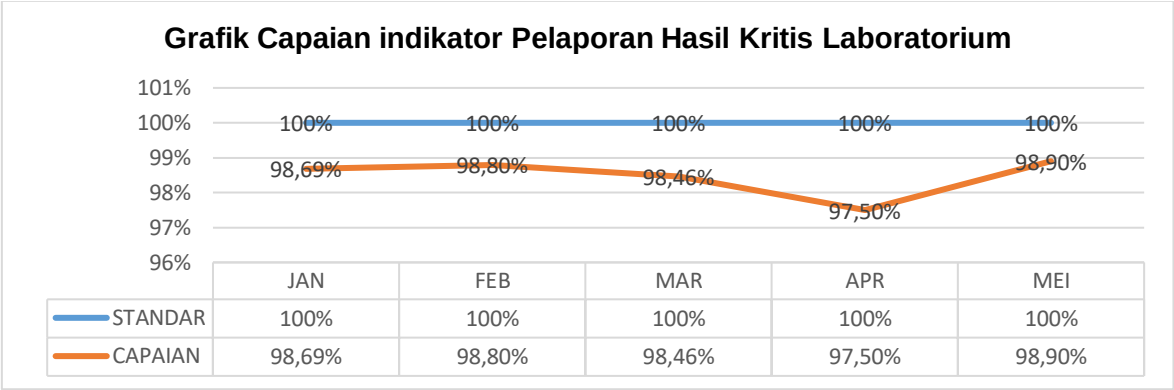
3.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan teguran kepada DPJP yang melakukan visite lebih dari jam 14.00				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 belum mencapai standart. Dari hasil supervisi didapatkannya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS lain karena RS Prima Husada tidak memiliki Dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Mengevaluasi hasil setelah memberikan teguran kepada DPJP dan memberikan surat peringatan kepada DPJP yang masih visite di atas jam 14.00	Manajemen RS	Satu bulan

3.6.1.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

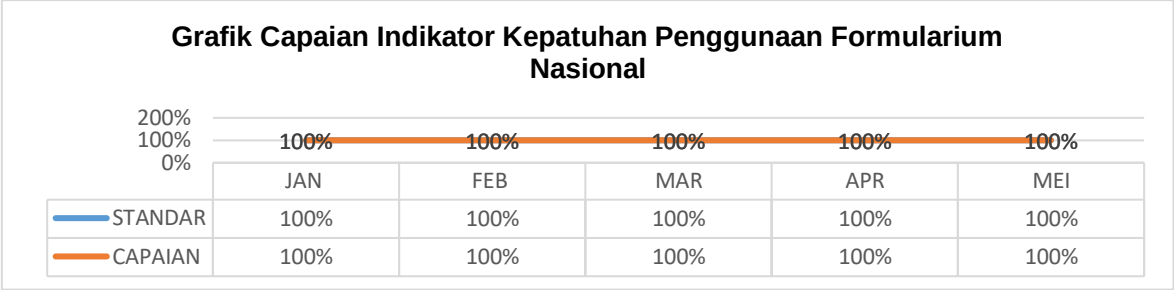
3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 masih belum mencapai standart. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memberikan teguran secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	Satu bulan

3.6.1.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

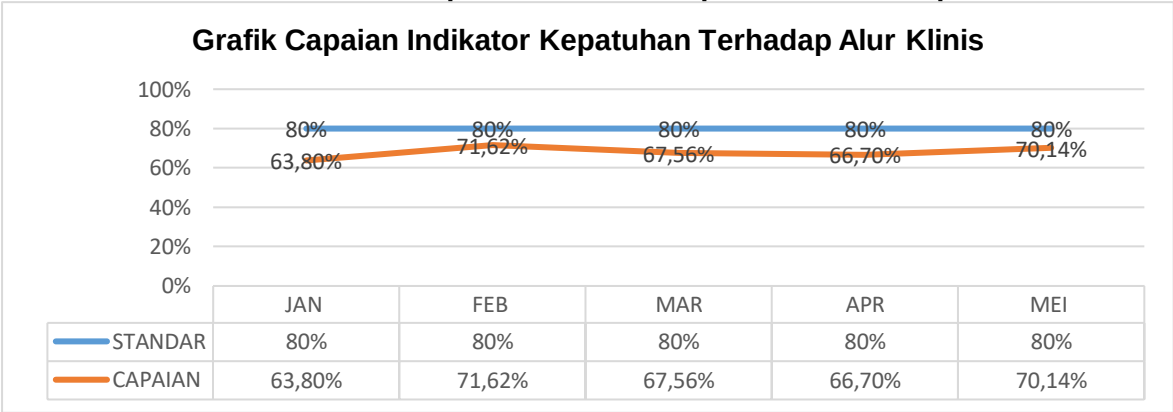
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional pada Bulan Januari hingga Mei Tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

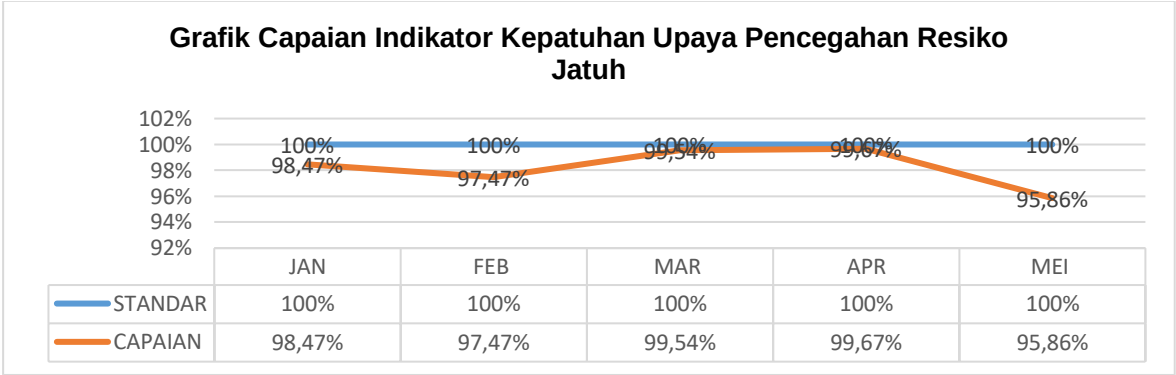
3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis hingga mencapai standart 80%.				
DO	Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator kepatuhan terhadap alur klinis masih belum stabil. Masih ditemukan profesi yang tidak memberikan asuhan sesuai dengan CP yang telah disepakati.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis	Capaian indikator kepatuhan terhadap alur klinis bisa mencapai standart 80%.	Melibatkan seluruh bidang profesi (dokter, perawat, apoteker dan ahli gizi) supaya mengisi form CP sesuai dengan yang diberikan kepada pasien sehingga kepatuhan terhadapa alur klinis dapat dianalisa.	Komite mutu	Satu bulan

3.6.1.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

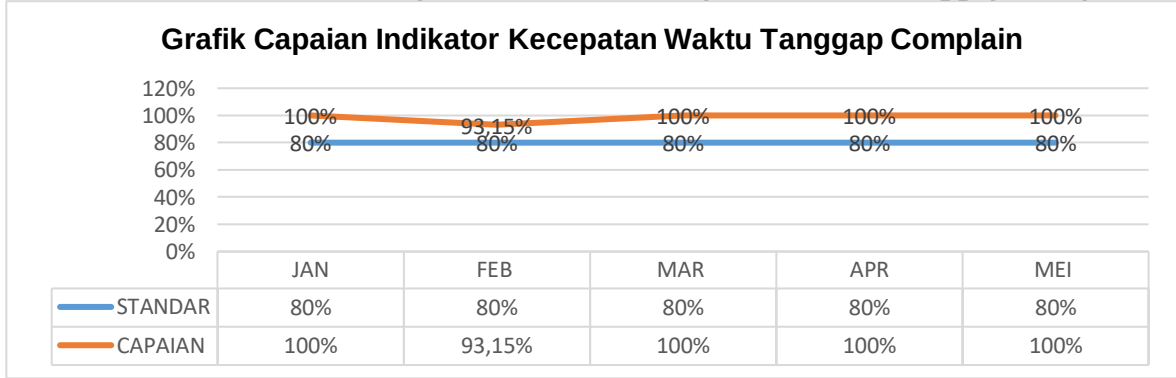
3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

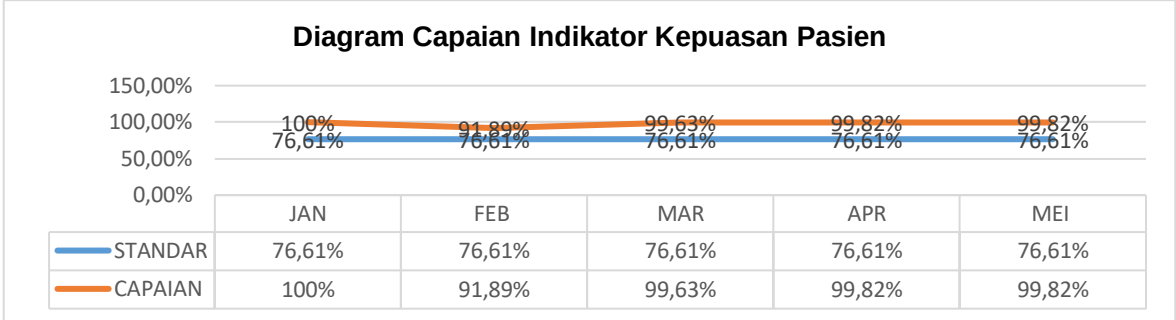
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa persentase kecepatan waktu tanggap komplain pada bulan Januari tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%, PIPP dan bidang terkait telah menanggapi dan menyelesaikan complain kurang dari 24 jam. Pada bulan Februari capaian menurun menjadi 93,15% tetapi masih diatas standart, pada bulan Maret hingga Mei capaian kembali meningkat menjadi 100%.

3.6.1.1.13 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.13.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis :
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa persentase kepuasan pasien pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 sudah mencapai standart

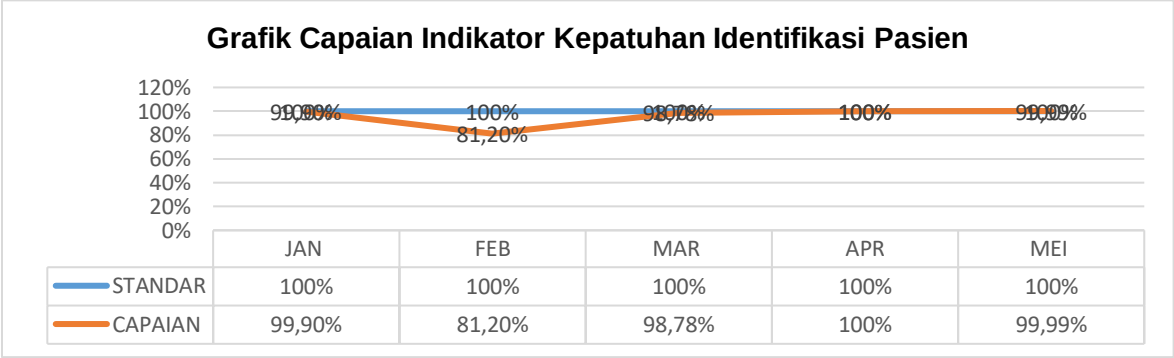
3.6.1.2 Indikator Mutu Prioritas

3.6.1.2.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,9%	81,2%	98,78%	100%	99,99%
2	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0
3	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0
4	Kepatuhan kebersihan tangan	100%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53%	85,56%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	98,47%	97,47%	99,54%	99,67%	95,86%

3.6.1.2.1.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

3.6.1.2.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien

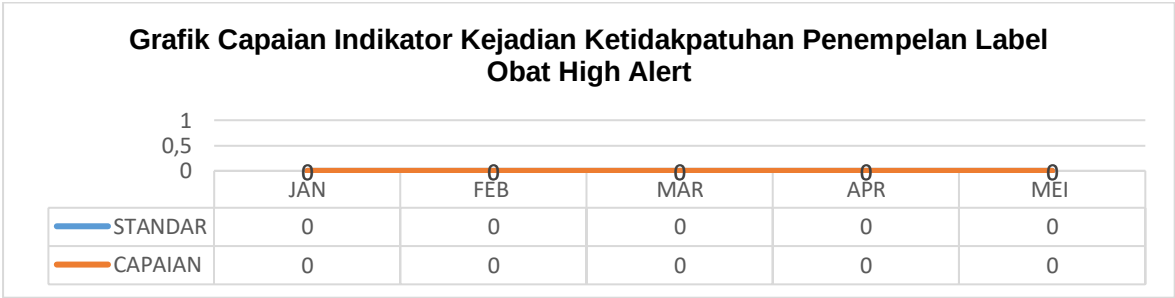


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart pada bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024 capaian telah mencapai standart 100%. Pada bulan Mei, capaian kembali menurun karena ditemukan kejadian insiden keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang salah mendaftarkan pasien karena tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.2 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

3.6.1.2.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert

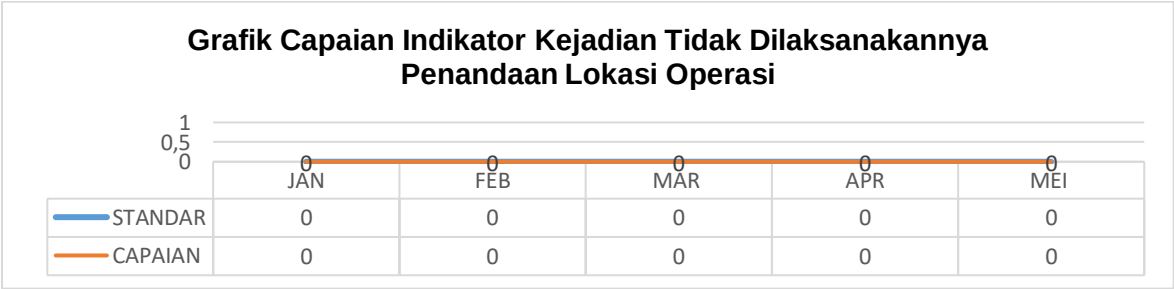


Analisis

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui persentase ketidakpatuhan penempelan label obat high alert pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.3 Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

3.6.1.2.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kejadian Tidak Dilaksanakannya Penandaan Lokasi Operasi

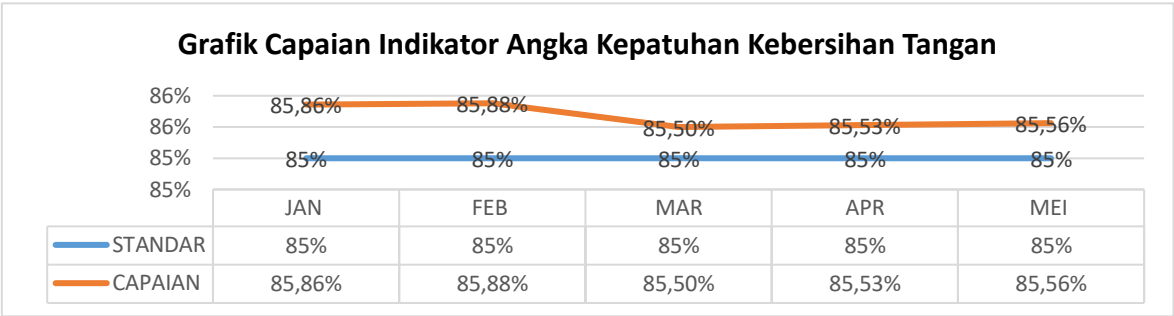


Analisis :

Berdasarkan data diatas dapat diketahui persentase tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.1.4 Kepatuhan Kebersihan Tangan

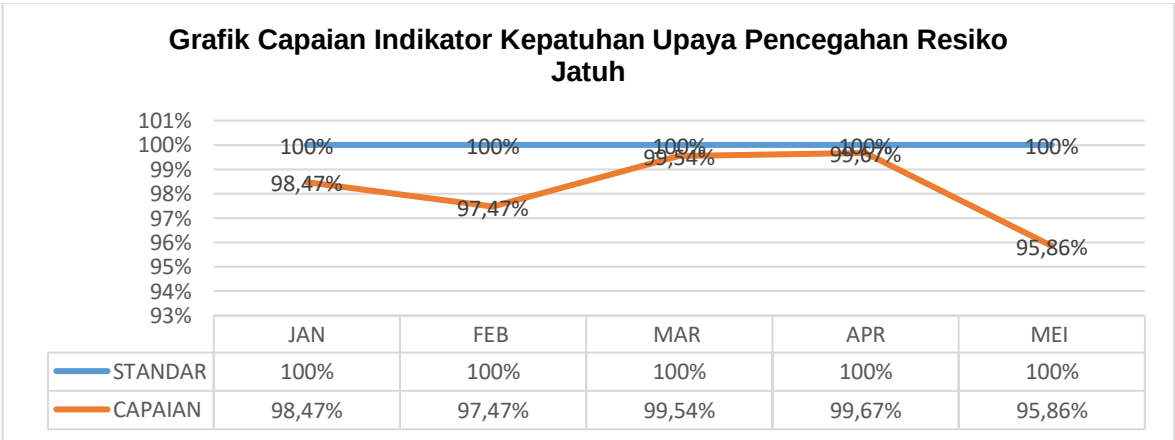
3.6.1.2.1.4.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO					
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,56%. Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Selain itu, dari hasil supervise fasilitas kebersihan tangan masih ditemukan bed pasien atau troli tindakan yang tidak dilengkapi dengan handrub. Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk Memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi DPJP.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.		Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.1.5 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.2.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



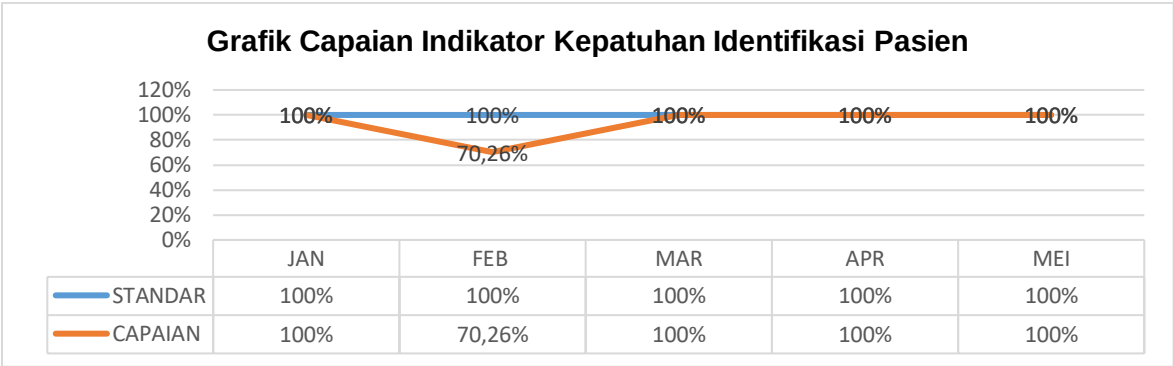
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 belum mencapai standart. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalumemasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu bulan

3.6.1.2.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0
14	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%

3.6.1.2.2.1 Kepatuhan Identifikasi Pasien

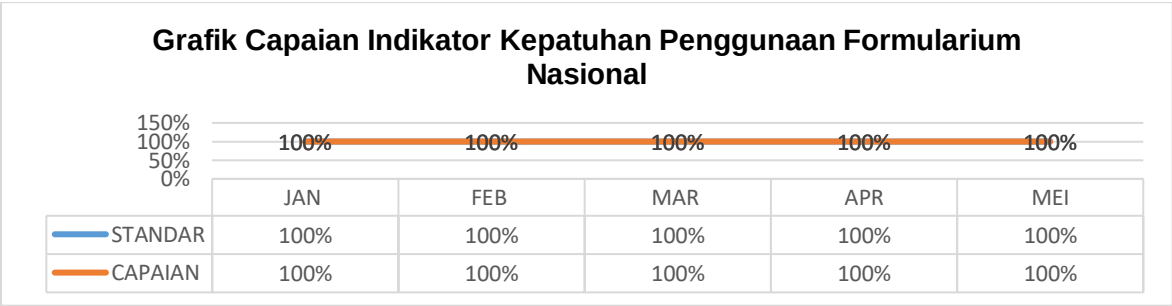
3.6.1.2.2.1.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien masih belum mencapai standart di bulan Februari, pada bulan Januari hingga Mei capaian telah mencapai standart 100%. Dari hasil supervisi didapatkan masih ditemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat ketika akan melakukan tindakan. Misalnya Ketika keluarga pasien mengambil obat dan tidak tahu tanggal lahir pasien beberapa petugas tetap memberikan obat tersebut.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Meningkatkan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien denga tepat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.2 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

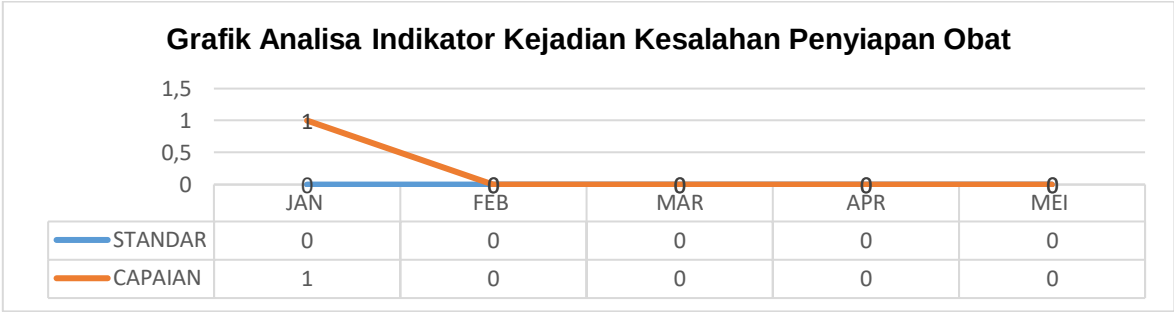
3.6.1.2.2.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Analisis Capaian :
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024 telah mencapai standart.

3.6.1.2.2.3 Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat

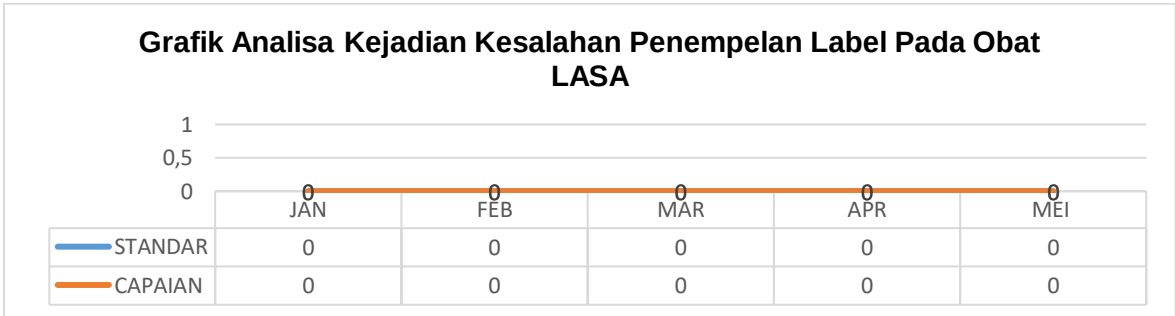
3.6.1.2.2.3.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat yang pada bulan ini telah mencapai standart.				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kesalahan pemberian obat masih terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Kesalahan pemberian obat terjadi karena petugas tidak teliti dalam melakukan penyiapan obat. Pada bulan Februari hingga Mei tahun 2024 diketahui tidak ada kejadian kesalahan penyiapan obat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Mempertahankan capaian kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	- Meningkatkan supervisi pada petugas di unit farmasi secara berkelanjutan - Kepala unit farmasi harus menindaklanjuti anggota yang melakukan kesalahan penyiapan obat - Memberikan proses pembelajaran untuk petugas yang melakukan kesalahan pemberian obat	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.4 Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA

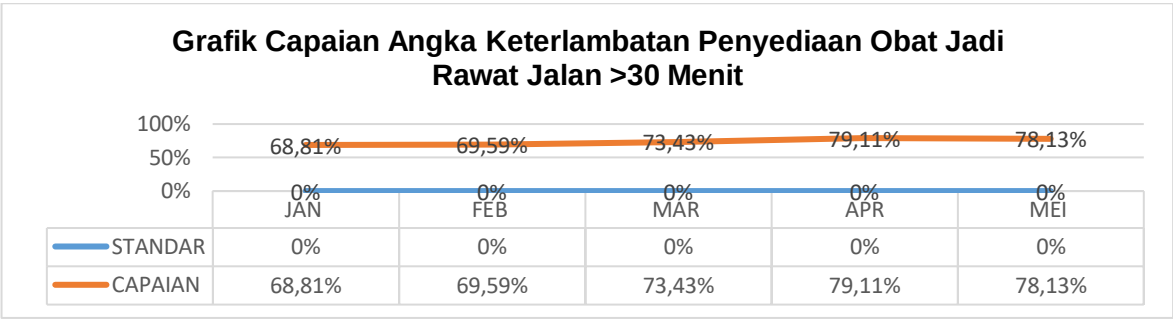
3.6.1.2.2.4.1 Grafik Analisa Kejadian Kesalahan Penempelan Label Pada Obat LASA



Analisis Capaian :
 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tidak ditemukan kejadian kesalahan penempelan pada obat LASA pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.5 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit

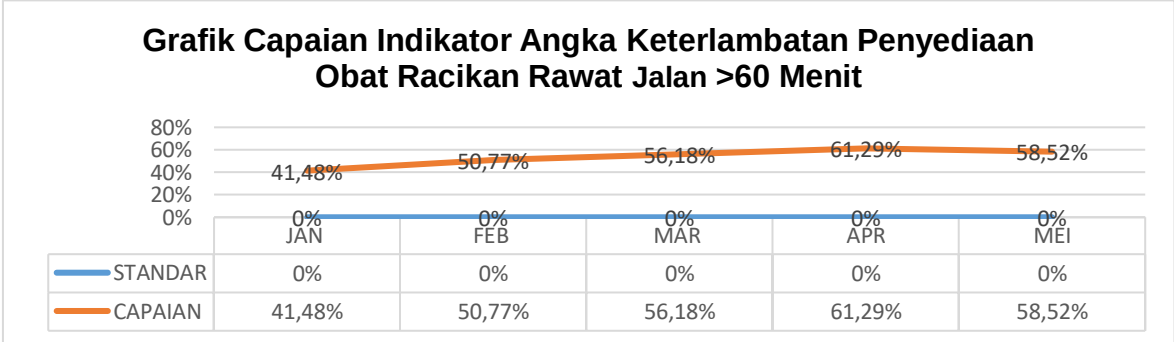
3.2.1.2.2.5.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Jadi Rawat Jalan >30 Menit



PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat jadi rawat jalan >30 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari. - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 30 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

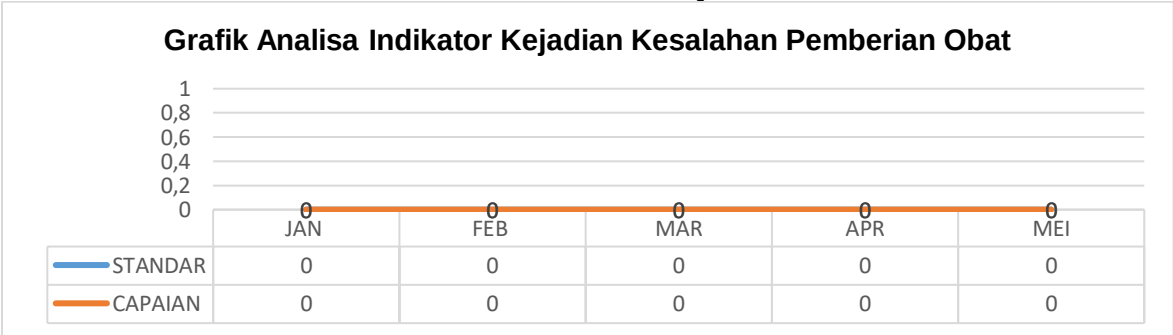
3.6.1.2.2.6 Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit

3.6.1.2.2.6.1 Grafik Capaian Indikator Angka Keterlambatan Penyediaan Obat Racikan Rawat Jalan >60 Menit



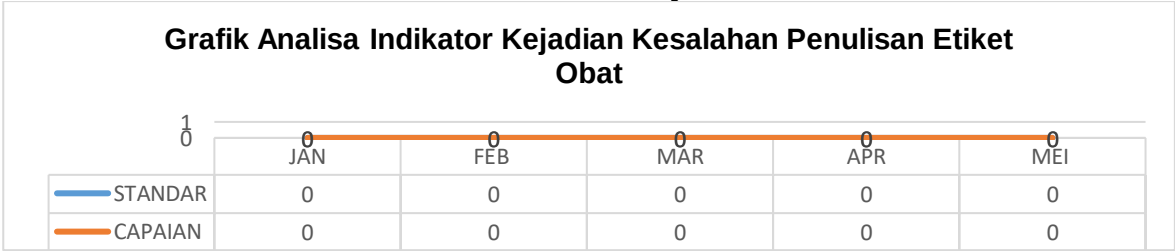
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka keterlambatan obat racikan rawat jalan >60 menit hingga mencapai standart 0% dengan target angka menurun 5% setiap bulan.				
DO	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai				
STUDY	Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit masih belum mencapai standart. Hal ini disebabkan karena : - Pasien cendereung naik beberapa hari - Tanda tangan elektronik diperlakukan untuk semua resep, termasuk rawat jalan IGD dan rawat jalan non kronis sehingga petugas farmasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Mengurangi angka keterlambatan penyediaan obat racikan rawat jalan >60 menit.	Obat jadi rawat jalan bisa diselesaikan kurang dari 60 menit .	- Menganalisa jumlah ketenagaan dengan jumlah pasien rawat jalan - Melakukan rapat Bersama kepala instalasi farmasi supaya petugas tidak merapel klik setelah pelayanan farmasi selesai - Dari hasil supervisi kepala instalasi farmasi maka akan diberlakukan pembelajaran pada betugas yang tidak langsung klik selsai pelayanan ketika layanan farmasi telah selesai	Seluruh petugas farmasi	Satu bulan

3.6.1.2.2.7 Kejadian Kesalahan Pemberian Obat
 3.6.1.2.2.7.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Pemberian Obat



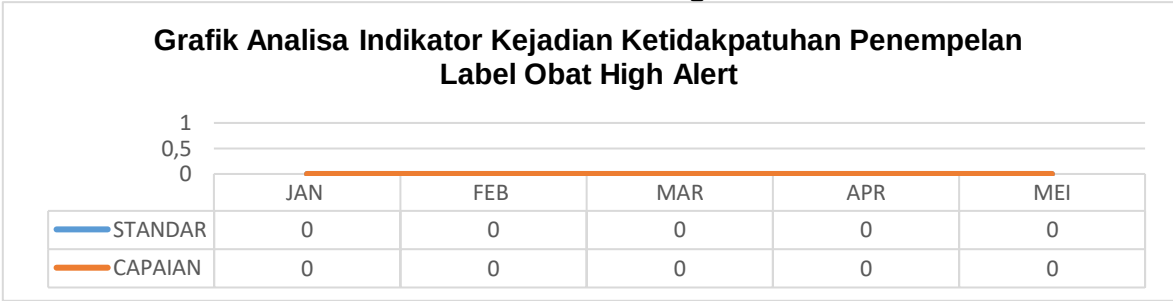
Analisis Capaian :
 Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan pemberian obat sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.8 Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat
 3.6.1.2.2.8.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat



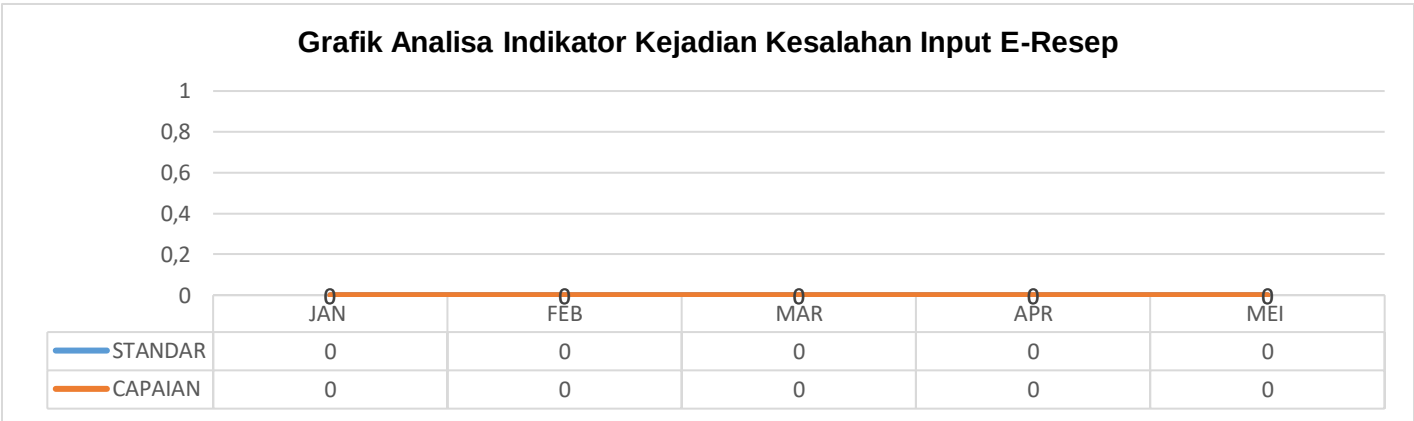
Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian kesalahan penulisan etiket obat sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.9 Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert
3.6.1.2.2.9.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Penempelan Label Obat High Alert



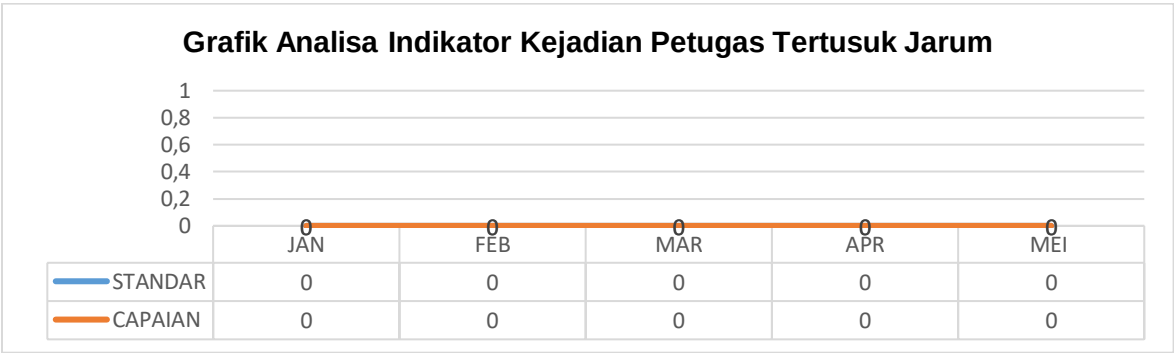
Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan penempelan obat high alert sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.10 Kejadian Kesalahan Input E-Resep
3.6.1.2.2.10.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Kesalahan Input E- Resep



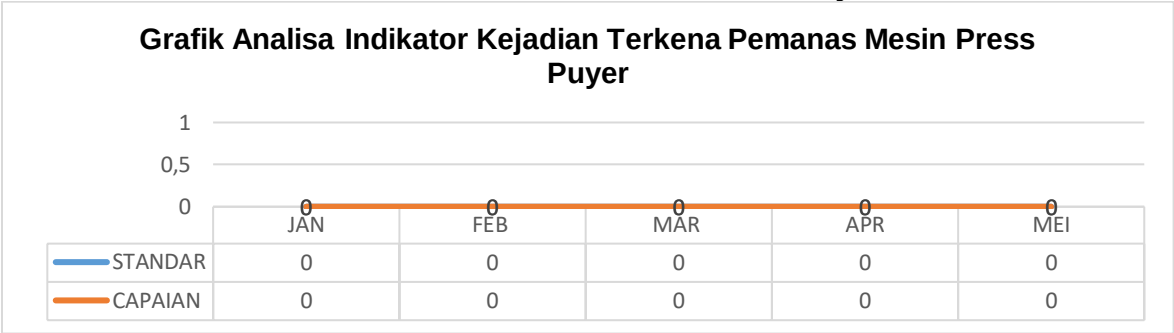
Analisis :
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian kesalahan input e-resep pada bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.11 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum
3.6.1.2.2.11.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum



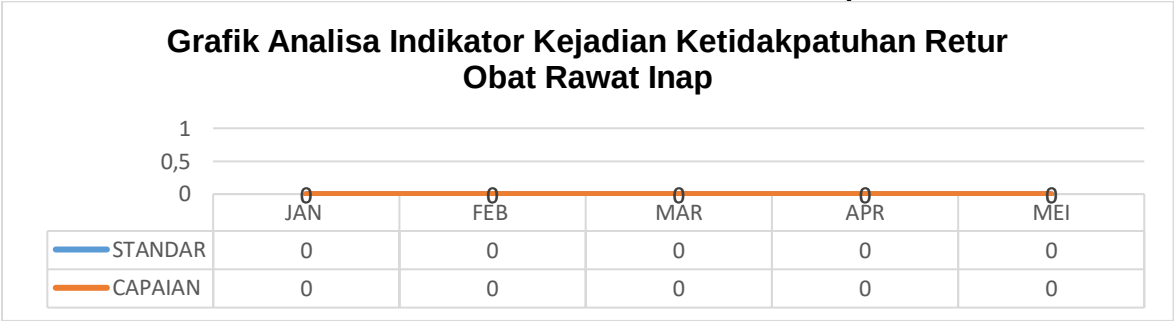
Analisis:
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian petugas tertusuk jarum sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.12 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer
3.6.1.2.2.12.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



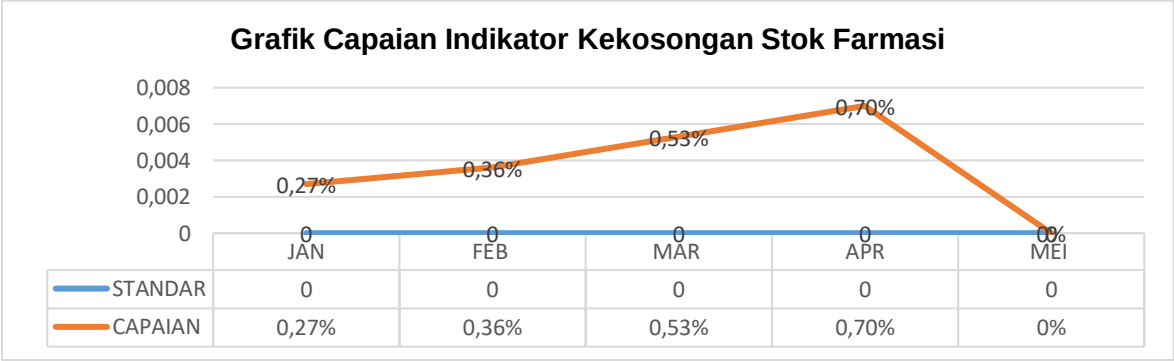
Analisis :
Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.13 Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap
3.6.1.2.2.13.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Ketidakpatuhan Retur Obat Rawat Inap



Analisis Capaian :
Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap sejak bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2024.

3.6.1.2.2.14 Kekosongan Stok Sediaan Farmasi
3.6.1.2.2.14.1 Grafik Capaian Indikator Kekosongan Stok Farmasi



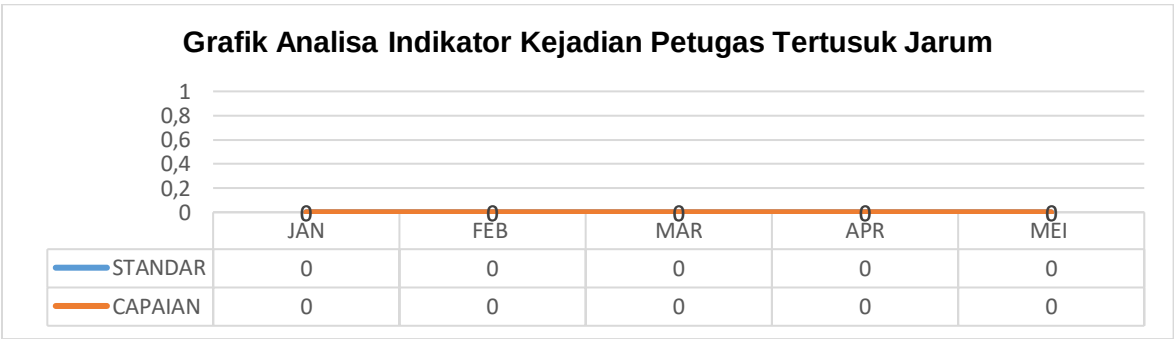
PLAN	Kami berencana Menurunkan angka kekosongan stok farmasi				
DO	Melakukan Analisa perhitungan waktu pengajuan hingga barang datang dengan kebutuhan, sehingga petugas dapat memperkirakan sediaan yang harus segera diinput pada pengadaan.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui masih terjadi kekosongan stok farmasi pada bulan Januari hingga April. Pada bulan Mei masih ada kekosongan obat teratasi dengan adanya substitusi sehingga tidak mengganggu pelayanan. Kekosongan obat farmasi disebabkan karena : 1. Barang yg sudah dipesan di pbf belum dikirim karena : - Barang sedang kosong distributor - Sp yg dikirim ke salesman belum terinput di data pemesanan pbf 2. Barang memang sedang kosong nasional karna bahan baku tidak ada 3. Human eror, bisa jadi terselip di defecta jd belum minta ke pengadaan 4. Barang yg awalnya slow moving, tiba2 jd fast moving. Banyak dipakai oleh dpjp ybs, padahal sebelumnya jarang sekali 5. Ada barang tertentu yg sedang dilakukan penyesuaian harga bpjs jadi belum bisa di jual oleh pbf 6. Ijin edar obat tertentu belum di setujui bpom, seperti kasus per sirup an kemarin				
ACTION/RT L	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Mengurangi angka kekosongan stok farmasi	Tidak ada kekosongan stok obat di farmasi	Memperbaruhi surat perjanjian kerjasama yang berisi tentang ketepatan waktu pengiriman obat setelah gudang farmasi order.	-Kepala Instalasi farmasi -Pengadaan Farmasi PT	Satu bulan

3.6.1.2.3 Manajemen Resiko

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0
2	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0

3.6.1.2.3.1 Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

3.6.1.2.3.1.1 Grafik Analisa Indikator Kejadian Petugas Tertusuk Jarum

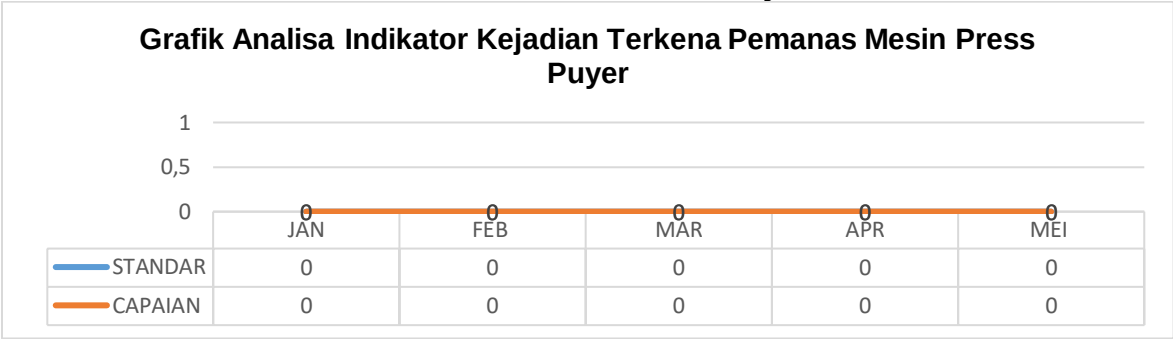


PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervisi terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervisi terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.2.3.2 Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer

3.6.1.2.3.2.1

Grafik Analisa Indikator Kejadian Terkena Pemanas Mesin Press Puyer



Analisis:

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada kejadian terkena pemanas mesin press puyer sejak bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2024.

3.6.1.3 Mutu Unit

3.2.1.3.1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	96,25%	100%	100%	100%
2.	Angka Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien IGD	0%	0%	0,17%	0%	0,28%	0,15%
3.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,7%	0,85%	0,61%	0,73%	0,5%
5.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergenci	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2 IRNA 2C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	93,41%	100%	97,22%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	80%	73,53%	74,84%	73,57%	73,23%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	-	-	0%	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,8%	100%	95,93%	100%	93,75%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	1,03%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	94,7%	100%	100%	97,14%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	86,36%	100%	100%	100%

3.2.1.3.3 IRNA 3A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	93,18%	89,4%	91,28%	80,29%	87,79%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,75%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	84,96%	87,65%	82,43%	83,94%	89,17%

3.2.1.3.4 IRNA 4A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	94,84%	78,23%	86,54%	86,84%	89,19 %
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	71,83%	97%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	90,75%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.5 IRNA 3C ANAK

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	97,4%

3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	0%	0%	0%	0%	0%
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0,37%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.6 IRNA 5C

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	62,07%	66,86%	64,86%	55,35%	67,48%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0,54%	0,55%	0,74%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator Baru 2024)	100%	99,13%	97,75%	93,02%	96,38%	95,58%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator Baru 2024)	100%	86,49%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.7 IRNA 6A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	61,11%	79,63%	84,92%	83,21%	82,79%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.8 IRNA 7A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	MAR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	58,22%	76,67%	75%	84,56%	76,74%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	96,67%	100%	100%	100%	97,12%

5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0,7%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	86,52%	100%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.9 IRNA 8A

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	92,21%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	54,39%	78,49%	81,45%	84,56%	71,76%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	99,15%	100%	100%	96,72%
5	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Angka Kelengkapan Penulisan Dalam Pengkajian Awal Medis (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	98,91%	100%	100%
7	Kelengkapan Pengisian EWS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.10 ICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '23	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	98,2%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	98,7%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%					
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	81,8%	92,53%	86%	90,4%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU.	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	-	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.11 HCU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥80%	-	-	-	-	-
4	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	96,3%	100%
5	Angka kelengkapan asesmen pasien tahap akhir kehidupan	100%	-	-	-	-	-
6	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk HCU	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.12 IRJA

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,75%	100%	95,71%	100%	100%
2	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	95,2%	91%	95,74%	52,7%	63.8%
3	Ketepatan Waktu Jam Praktek Dokter	100%	84,42%	82,35%	84,04%	84,04%	70.04%
4	Angka rujukan horizontal FKRTL	0%	0%	0%	0%	0%	37,03%

3.2.1.3.2.13 Maternitas

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	99,44%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Angka keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	0%	0%
8	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Kejadian perdarahan post partum	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian partus lama	0	1	2	0	0	0
11	Kejadian eklamsi	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian pre eklamsi	0	3	1	0	0	0
13	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidaklengkapan 10T pada ANC	0%	0%	0%	0%	0%	0%
15	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%
16	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	3,82%	0,83%	3,6%	8,49%	6,41%
17	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	0	0	0	0	0
18	Prosentase Pulang Atas Permintaan Sendiri	0%	0%	0%	0,73%	0%	0%

3.2.1.3.2.14 NICU

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	≥80%	-	-	-	-	-

3	Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥80%	85,92%	90,63%	84,72%	90,8%	84,82%
5	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	4,17%	3,26%	0%	0%
6	Angka Kematian Bayi	0	0%	0%	0%	0%	3,7%
7	Kejadian tidak dilakukannya IMD (inisiasi menyusui dini) pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.15 IKO

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	10	10	10	10
5	Kejadian konversi tindakan anestesi dari local/regional ke general	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian tidak dilaksanakannya asesmen pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian tidak dilaksanakannya pemantauan diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian tidak lengkapnya asesmen pra bedah	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidaklengkapan formulir penandaan pasien operasi	0	0	0	0	0	0
14	Angka ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC (indikator baru 2024)	0%	0%	0%	23,08%	0%	0%

3.2.1.3.2.16 Laboratorium

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	98,69%	98,8%	98,48%	97,5%	98,9%
3	Kejadian Pengulangan Phlebotomi Saat Sampling	0	3	2	4	2	2
4	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0
5	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium >140 menit (Indikator baru 2024)	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.17 Radiologi							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	3,72%	3,61%	2,65%	3,81%	3,81%
3	Kejadian Ketidakpatuhan persiapan pasien USG (Indikator baru 2024)	0	1	0	0	0	0

3.2.1.3.2.18 Gizi							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,76%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	1	0	0	0	0
3	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0
4	Kejadian Pasien Tidak Mendapat Makan	0	0	1	0	0	0

3.2.1.3.2.19 Farmasi							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	70,26%	100%	100%	100%
2	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	1	0	0	0	0
4	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0
5	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,81%	69,59%	73,43%	79,11%	78,13%
6	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	41,48%	50,77%	56,18%	61,29%	58,52%
7	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	0	0	0
8	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	0	0	0
9	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0
10	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	0	0	0
11	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	0	0	0	0
12	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0
13	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.20 Pengadaan Farmasi							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0,27%	0,36%	0,53%	0,7%	0%

3.2.1.3.2.21 PPI							
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APRIL '24	MEI '24
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,24%	0,8%	0,27%	0 %	0,24 %
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰

3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,28%	0,22%	0,4%	0,25%	0,34%
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,86%	85,88%	85,5%	85,53 %	85,62%
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,04%	93,05%	93,3%	93,52%	93,73%
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	91,91%	92,09%	92,22%	92,29%	92,19%
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0

3.2.1.3.2.22 PIPP

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100%	100%	93,15%	100%	100%	100%
4	Kepuasan Pasien	76,61%	100%	91,89%	99,63%	99,82%	99,63%
5	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	86,94%	75,31%	57,76%	52,92%	55,36%

3.2.1.3.2.23 SDM

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	1	0	1
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	98,99%	98,97%	99,14%	98,76%	95,9%
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	3,32%	3,34%	2,97%	14,3%	4,12%

3.2.1.3.2.24 Rekam Medis

NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda.	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Angka Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	0%	-	-	96,65%	93,04%	94,08%
3.	Kejadian kendala pada SIMRS dalam upaya menunjang pelayanan rekam medis rekam medis elektronik (Indikator baru 2024)	0	0	0	0	0	0
4.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	0%	0%	7,06%	9,44%	7,88%

3.2.1.3.2.25 Keuangan							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka keterlambatan pembayaran klaim lebih dari 90 hari	0%	7,7%	6%	3,86%	10,98%	1,57%
2	Kejadian piutang umum atas permintaan sendiri	0	0	0	0	0	0
3	Angka keterlambatan pembayaran klaim BPJS	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.26 K3RS							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	1	0	0	0

3.2.1.3.2.27 Asuransi Center							
NO.	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka pending klaim BPJS	0%	1,07%	1,04%	0,78%	0,97%	-
2	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	1,69%	1,04%	2,17%	1,66%	2,25%
3	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS (Indikator baru 2024)	100%	9,73%	0,57%	0,44%	0,42%	0,55
4	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	0	0	1	1	0

3.2.1.2.28 IPSRS							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	100%	91%	89%	89,47%	91,67%

3.2.1.3.2.29 UMUM							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	3	7	4	3	6
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	11	4	5	2	4

3.2.1.3.2.30 Cleaning Service							
NO	JUDUL	STAND	DES '23	JAN '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	1,39%	1,67%	29,17%	28,95%	3,13%

3.2.1.3.2.31 Kesekretariatan							
NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 5 setiap bulannya	0%	34,21%	0%	20,69%	78,38%	48,72%

2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	25%	100%	62,5%	71,83%	56,25%
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	65%	-	60,71%	86,21%	22,73%

3.2.1.3.2.31 Laundry

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	0%	5,2%	1,95%	4,19%	1,35%
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0%	0%	0%

3.2.1.3.2.33 CSSD

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	1	0	0	0	0
2	Kejadian instrument kurang	0	1	0	1	1	1

3.2.1.3.2.34 Humas dan Pemasaran

NO	JUDUL	STAND	JAN '24	FEB '24	MAR '34	APR '34	MEI '24
1	Angka kunjungan rawat inap >80 pasien perhari	0%	99,17%	90,88%	100%	100%	100%
2	Angka kunjungan rawat jalan >300 pasien perhari	0%	93,71	100%	92,82%	92,82%	91,73%

3.2.1.3.2.35 IT

NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	96,97%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3.2.36 Kamar Jenazah

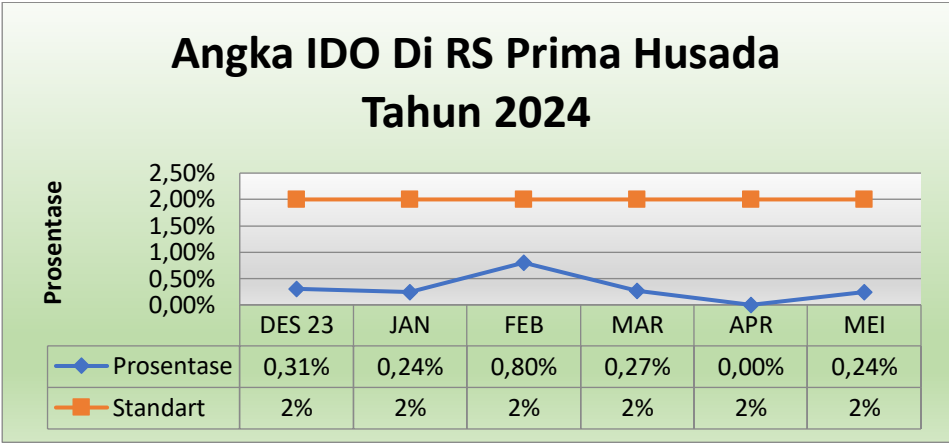
NO	JUDUL	STAN	JAN '24	FEB '24	MAR '24	APR '24	MEI '24
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.6.2 Komite PPI

3.6.2.1 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

3.6.2.1.1 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

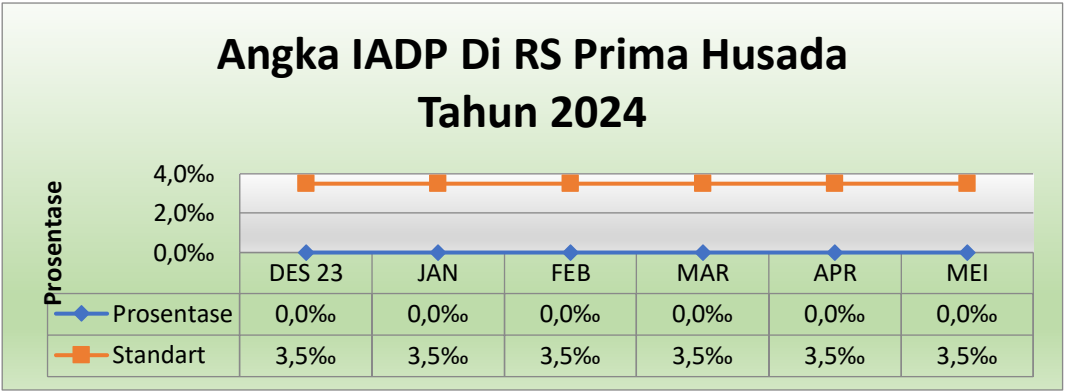
3.1.1.1.1 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO):



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka IDO seminimal mungkin. (0%)				
DO	- Melakukan koordinasi dengan DPJP obgyn terkait Teknik aseptik pada saat melakukan perawatan luka maupun prosedur operasi. - Melakukan koordinasi dengan tim Kamar operasi terkait penggunaan kamar operasi dan pembersihannya saat ada operasi estafet (memakai kamar operasi yang berbeda, jika kamar operasi lainnya kosong). - Melakukan koordinasi dengan petugas unit perawatan untuk tetap menjaga Teknik aseptic saat melakukan proses perawatan luka pasien. - Berkoordinasi dengan ahli gizi dan perawat unit untuk pemantapan proses edukasi pasien terutama diit pasien pada saat pasien dirawat atau akan KRS. - Monitoring pembersihan alat dan kebersihan ruang kamar operasi tetap dilakukan secara rutin. - Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai SPO.				
STUDY	Ditemukan kasus 1 kasus IDO pada bulan ini. Kasus IDO pada pasien post operasi SC, dimana terdapat luka rembesan darah pada balutan luka. Dari hasil anamnesa pasien tidak ada kendala dari diit pasien maupun mobilisasi pasien. Namun pada saat operasi memang ada perlengketan karena pasien dahulu pernah mengalami operasi laparatomi. Namun pada kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium kultur sehingga tidak dapat memastikan.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan bundle IDO.	Pertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IDO.	Kepatuhan audit bundle IDO meningkat 3% pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian handscon steril saat rawat luka. - Monitoring kepatuhan mandi dengan air sabun sebelum operasi. - Monitoring kepatuhan penggunaan alat cukur satu kali pakai dan pembersihan wadah alat cukur yang dipakai berulang. - Monitoring kepatuhan petugas dalam menjaga aseptic saat melakukan rawat luka/tindakan bedah.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

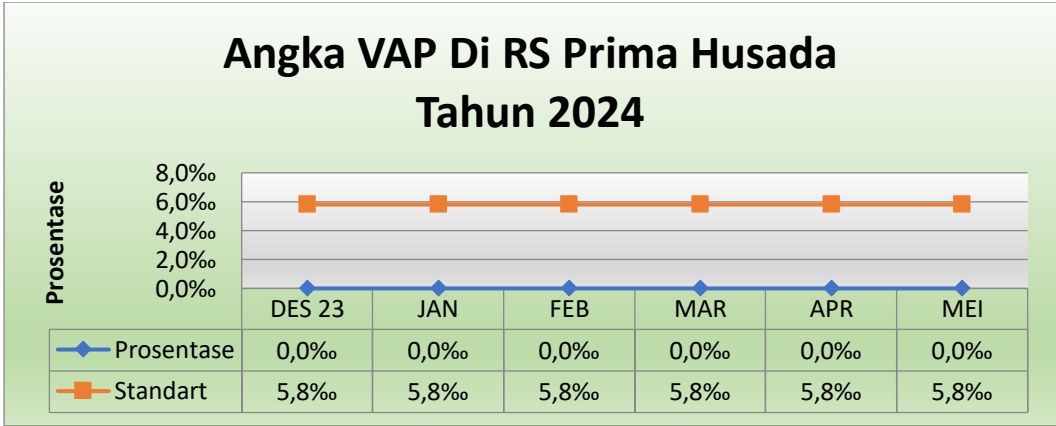
3.6.1.1.2.1 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka IADP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle IADP sesuai standart.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak dilakukan pemasangan CVC pada pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Kepatuhan bundle IADP tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)

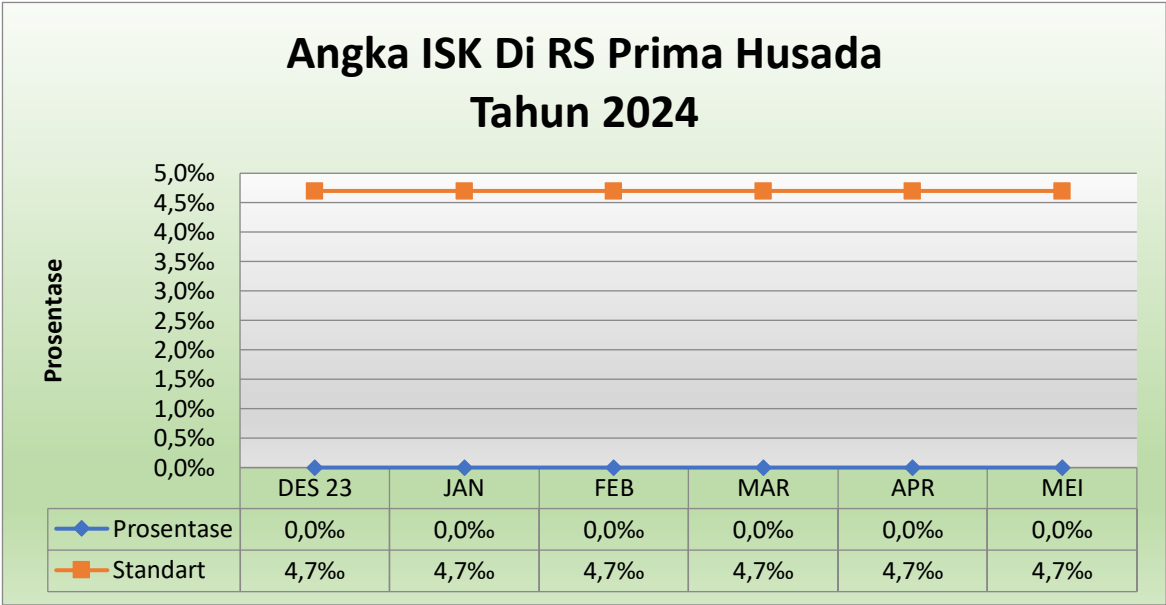


PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka VAP sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)				
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle VAP sesuai SPO.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 6 hari lama pemasangan ventilator.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle VAP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam	Kepatuhan bundle VAP tetap	Resosialisasi 5 moment cuci tangan.	- Perawat /Bidan - Dokter	Satu bulan

	menjalankan bundle VAP.	baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. - Monitoring posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. - Monitoring perawatan pemasangan ventilator, pemberian profilaksis dan perawatan oral <i>hygiene</i>.	- Karu - IPCLN/IPCN	
--	-------------------------	--	---	--	--

3.6.1.1.4 ISK

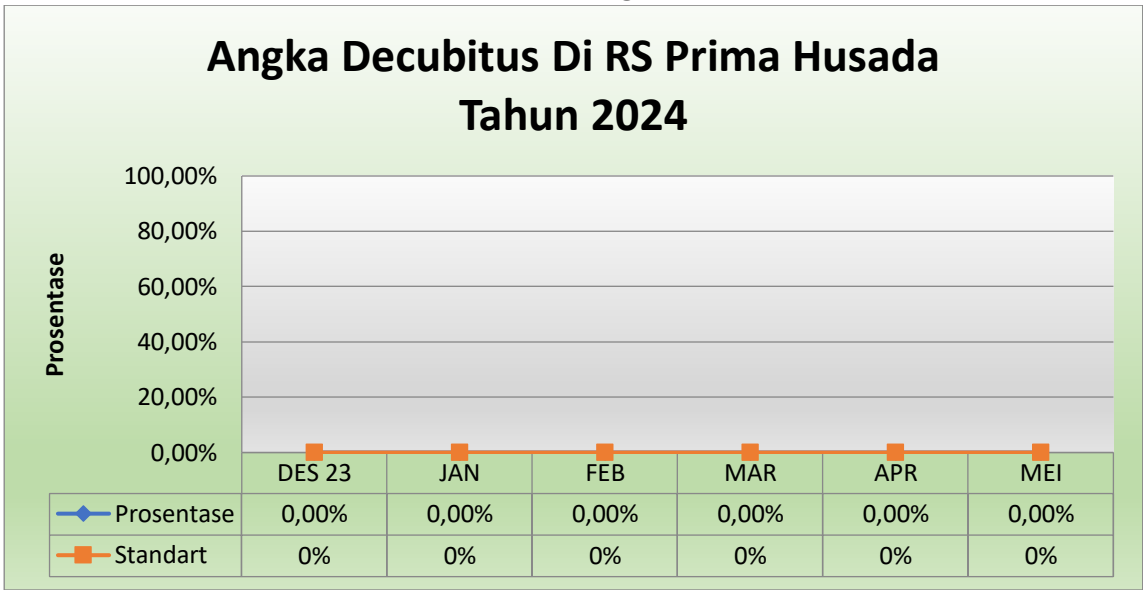
3.1.1.1.4.1 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka ISK sesuai standart seminimal mungkin. (0‰)					
DO	Monitoring pelaksanaan audit bundle ISK sesuai SPO.					
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1039 hari lama pemakaian kateter pasien.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	Kepatuhan bundle ISK tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. - Monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.		- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.5 Decubitus

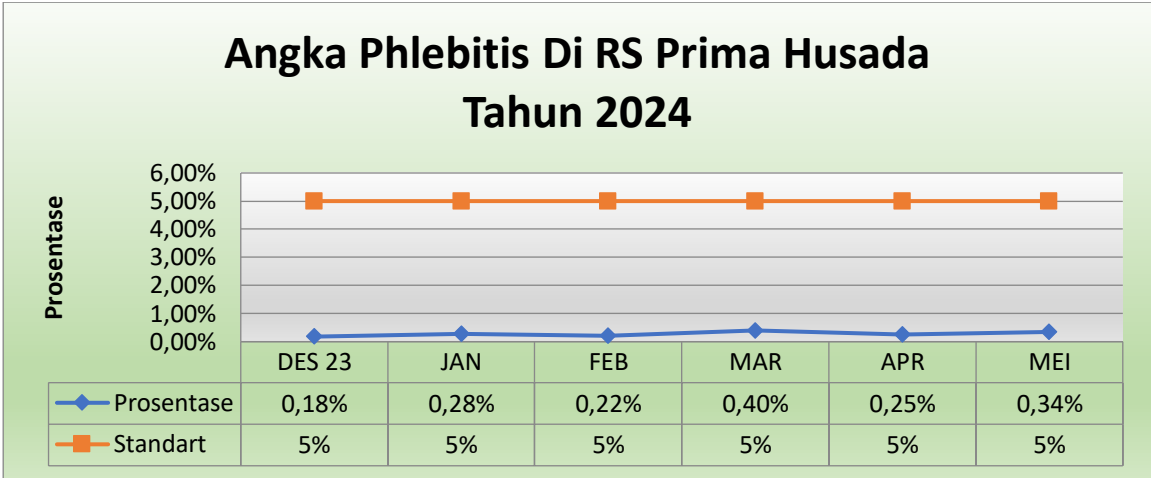
3.1.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



PLAN	Kami berencana untuk mempertahankan angka decubitus sesuai standart seminimal mungkin. (0%)				
DO	Monitoring pelaksanaan pencegahan decubitus pada perawatan pasien dengan tirah baring lama.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus decubitus pada 57 pasien tirah baring lama (>3x24 jam).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Kepatuhan pencegahan dekubitus tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus. - Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	- Perawat /Bidan - Karu - IPCLN/IPC�	Satu bulan

3.6.1.1.6 Phlebitis

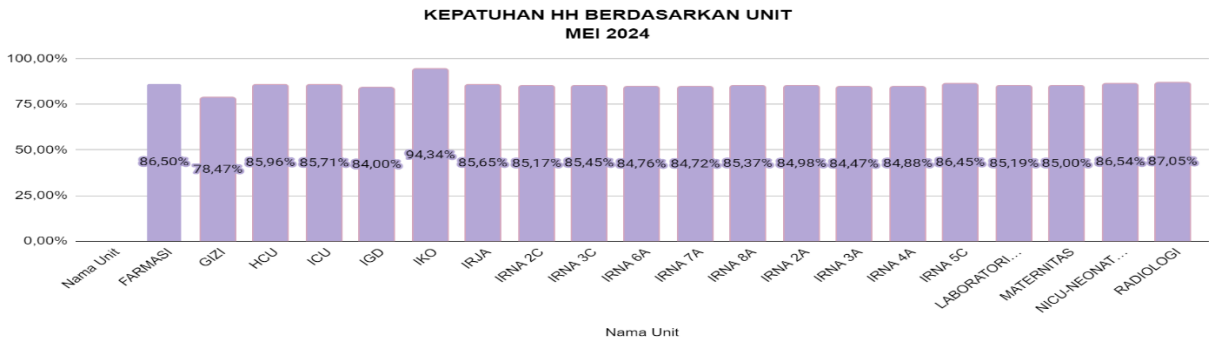
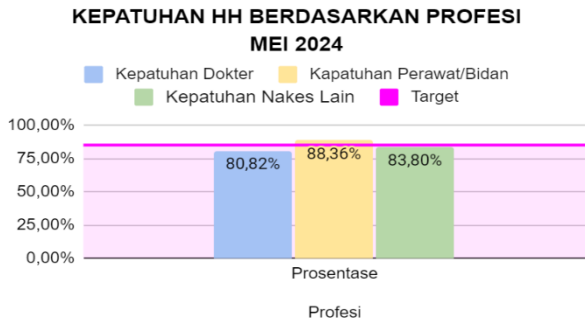
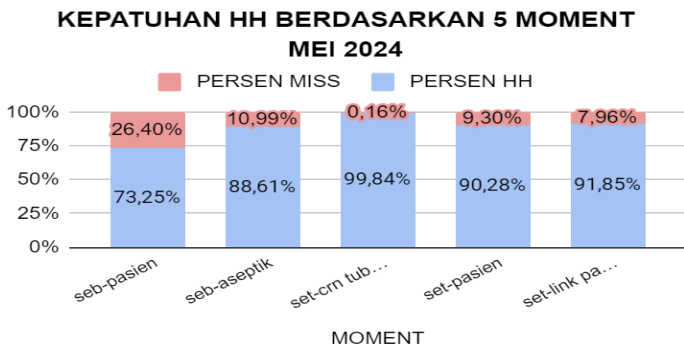
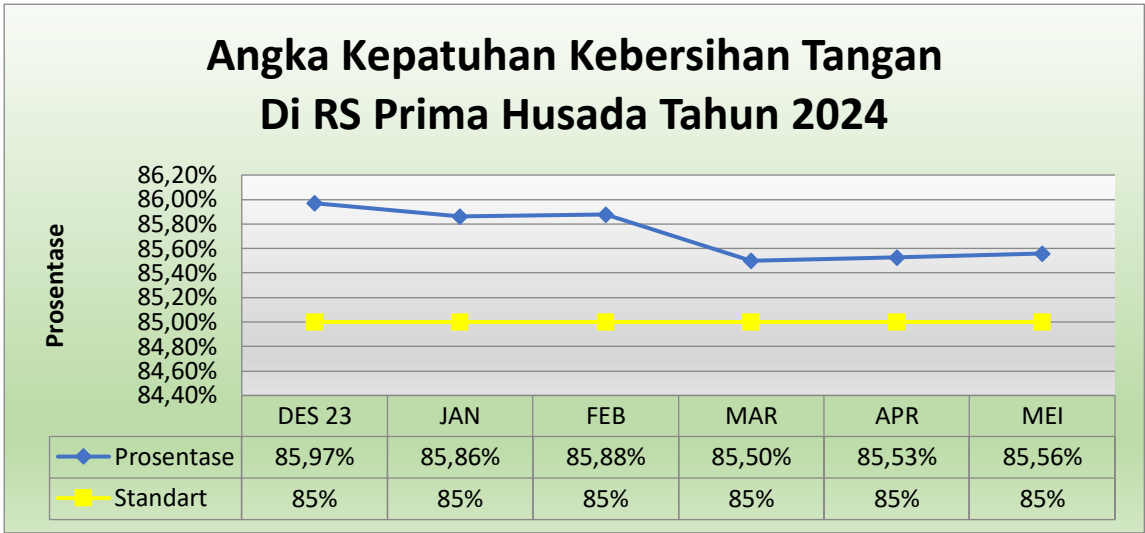
3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan angka phlebitis seminimal mungkin. (0%)				
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit bundle phlebitis sesuai SPO. - Melakukan sosialisasi kepada perawat tentang handhygiene dan pemakaian APD yang benar. - Berkolaborasi dengan komite keperawatan untuk melakukan supervisi berkala terkait prosedur pemasangan infus dan perawatan luka infus. - Monitoring pelaksanaan penyuntikan yang aman dan Teknik aseptic saat penyuntikan.				
STUDY	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2903 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,34%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh, 3 dari 10 pasien yang mengalami phlebitis merupakan pasien yang mendapat cairan/obat yang konsentrasinya lebih pekat (NS 3%, KCL, dll). 5 pasien lainnya yang mengalami phlebitis merupakan pasien anak-anak dan 2 sisanya adalah pasien lansia dimana pembuluh darah pasien cenderung lebih rentan phlebitis dan mendapatkan injeksi antibiotic. Dari 8 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle phlebitis.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Kepatuhan bundle phlebitis tetap baik atau meningkat pada bulan berikutnya.	- Resosialisasi 5 moment cuci tangan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus. - Monitoring teknik aseptic dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Monitoring penyuntikan yang aman. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)

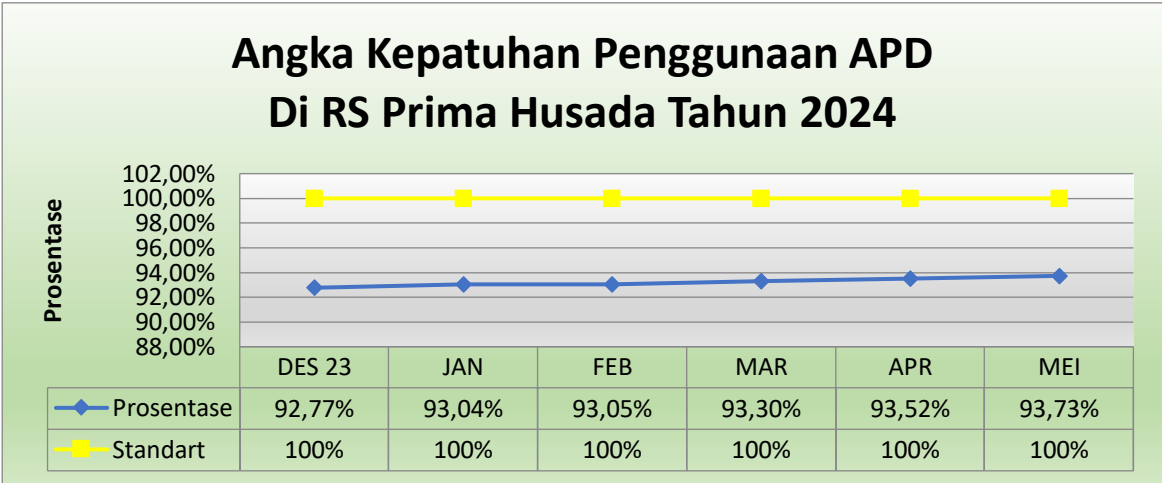


PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.
DO	- Mendata ulang jumlah kebutuhan tatakan dan botol handrub unit. - Mengajak Karu untuk ikut mengecek kebutuhan fasilitas kebersihan tangan unitnya. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan kebersihan tangan. - Melakukan supervisi terkait fasilitas kebersihan tangan. - Melakukan sosialisasi kebersihan tangan antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
STUDY	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,56%. Jika dilihat berdasarkan profesi, masih ditemukan prosentase di bawah standart yaitu pada profesi dokter (80,82%) dan nakes lain (83,80%) dimana berdasarkan 5 moment cuci tangan, kebanyakan dari petugas tidak melakukan moment sebelum kontak dengan pasien (73,25%). Banyak ditemukan temuan petugas tidak melakukan kebersihan tangan sebelum melakukan tindakan karena terbiasa beranggapan tangannya sudah bersih dan perlu diingatkan dulu (pada saat di audit baru patuh). Dari segi petugas, ada yang lebih memilih untuk memakai sarung tangan (handscoon) dibandingkan dengan cuci tangan seperti pada profesi dokter. Namun beberapa perawat sudah mengurangi penggunaan sarung tangan bedah sesuai dengan kebutuhannya saja.

ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Tercapainya kepatuhan kebersihan unit masing-masing diatas 85%.	- Resosialisasi 5 moment dan 6 langkah cuci tangan. - Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Memberikan reward-pembelajaran. - Melakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

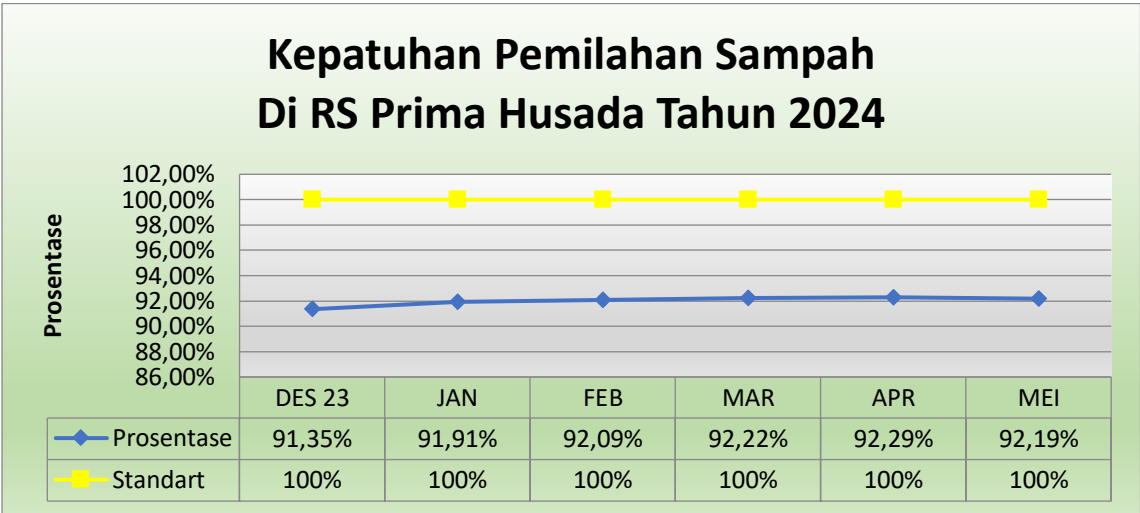
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan $\pm$ 5% setiap bulannya.				
DO	• Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Menegur dan melakukan sosialisasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. • Menegur kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. • Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,73% meningkat sedikit dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, terdapat sedikit peningkatan terkait penggunaan APD setelah dilakukan diklat internal PPI dasar dimana petugas menjadi lebih paham kapan harus menggunakan APD yang tepat.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD unit minimal meningkat 2% pada bulan berikutnya.	• Melakukan sosialisasi antar staf tentang penggunaan APD. • Menegur staf yang salah dalam penggunaan APD dan memberikan metode pembelajaran dengan mendata ketidak patuhan teman-teman di unitnya. • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Berkolaborasi dengan perawat untuk tidak memberikan handscoon jika CS meminta handscoon. Selain itu kolaborasi dengan Karu CS untuk menyediakan stok sarung tangan sesuai nama petugas dan 1 stok tiap ruangan untuk menanggulangi sarung tangan yang cepat rusak. • Menjadikan kebiasaan pemakaian APD sesuai dengan jenis transmisi penyakit dan tindakan yang akan dilakukan.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.9 Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius

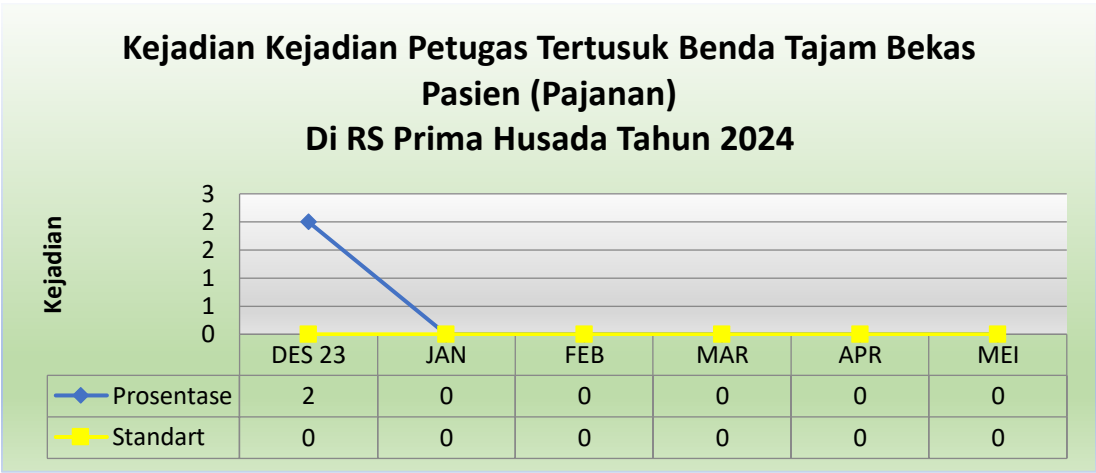
3.6.1.1.9.1 Grafik Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan



PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius semaksimal mungkin (100%) dengan target peningkatan ± 5% setiap bulannya.				
DO	- Melakukan supervise terkait pemilahan pembuangan sampah di unit pelayanan pasien. - Melakukan supervise terkait pembuangan sampah di ruang TPS B3. - Melakukan sosialisasi pemilahan sampah yang yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Menegur langsung petugas unit dan Karu/PJ saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan dan memberitahukan pemilahan sampah yang benar.				
STUDY	Prosentase kepatuhan pemilahan sampah infeksius dan non infeksius keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 92,19%, sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan kesalahan pemilahan sampah terutama pada sampah infeksius dimana ditemukan ujung tajam selang infus tidak dibuang disafety box. Selain itu juga ditemukan bungkus-bungkus alkes yang seharusnya dibuang di sampah non infeksius dibuang di sampah infeksius.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Tercapainya kepatuhan pemilahan sampah unit minimal meningkat 3% pada bulan berikutnya.	- Melakukan sosialisasi antar staf tentang pemilahan sampah. - Menegur langsung petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. - Menyampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



PLAN	Kami berencana untuk menurunkan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan) seminimal mungkin (0).				
DO	- Menginputkan laporan pada surveilans SIMRS dan kolaborasi dengan K3RS dan SDM. - Mengevaluasi keadaan luka pasien dan kondisi penyakit sumber pajanan. - Melakukan supervise terkait pengolahan benda tajam dan penyuntikan yang aman. - Melakukan supervise terkait penggunaan APD yang benar sesuai transmisi dan tindakan yang akan dilakukan.				
STUDY	Pada bulan ini tidak ditemukan kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan).				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Melakukan penyuntikan aman.	Mempertahankan capaian kejadian pajanan 0 kejadian.	Tercapainya standar pajanan 0 kejadian setiap bulannya.	Mempertahankan kegiatan penyuntikan yang aman karena sudah meminimalisir kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

NO	UNIT	TARGET	MAR	APRIL	MEI	%	MANDOK	KETERANGAN
1	IRNA 2C	8x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
2	ICU HCU	8x/Bulan	50%	0%	25%	↓	Ada	
3	IRNA 3C	8x/Bulan	100%	100%	75%	↓	Ada	
4	MATERNITAS	8x/Bulan	75%	75%	100%	Tercapai	Ada	
5	PERINATOLOGI	8x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
6	IRNA 5C	8x/Bulan	100%	25%	100%	Tercapai	Ada	
7	IRNA 2A,3A,4A	8x/Bulan	100%	50%	50%	↓	Ada	
8	IRNA 6A,7A,8A	8x/Bulan	100%	100%	75%	↓	Ada	
9	IGD	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
10	FARMASI	8x/Bulan	100%	25%	100%	Tercapai	Ada	
11	GIZI	8x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
12	IRJA	8x/Bulan	100%	75%	100%	Tercapai	Ada	
13	PPI		100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

Analisis

:

Unit mengalami kenaikan produktivitas dalam melakukan edukasi kelompok, Pada unit ICU HCU mengalami perbaikan dalam melakukan edukasi kelompok.

Unit yang tidak tercapai ada di IRNA Gedung A dan Irna 3C dengan analisis terdapat kendala full pelayanan pasien setiap hari

Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Kepala Ruang dan Kepala Bidang Keperawatan

3.6.3.2 KIE Individu

NO	UNIT	TARGET	MAR	APRL	MEI	%	KETERANGAN
1	IRNA 2C	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ICU HCU	100%	100%	100%	100%	100%	
3	IRNA 3C	100%	100%	100%	100%	100%	
4	MATERNITAS	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERINATOLOGI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	IRNA 5C	100%	100%	100%	100%	100%	
7	IRNA 2A,3A,4A	100%	100%	100%	100%	100%	
8	IRNA 6A,7A,8A	100%	100%	100%	100%	100%	
9	IGD	100%	100%	100%	100%	100%	
10	FARMASI	100%	100%	100%	100%	100%	
11	GIZI	100%	100%	100%	100%	100%	
12	IRJA	100%	100%	100%	100%	100%	

3.6.3.3 Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Edukasi (DRM) Edukasi

NO	LEMBAR DRM	JML SAMPLE	KELENGKAPAN		ISI BENAR	VERIFIKASI KE PASIEN	KET
			YA	TIDAK			
1	General Consent	8	8	0	Isi sesuai	Ya	- Kekuranga n TTD pada nama petugas
2	SBAR	8	8	0	Isi sesuai	Ya	Ketidaklengka pan pada penulisan nama petugas dan nama pasien yg jelas
3	Perencanaan Edukasi / Rencana Asuhan	8	8	0	Isi sesuai	Ya	Nama Petugas tidak terisi lengkap
4	Pengkajian Kebutuhan KIE	8	8	0	Isi sesuai	Ya	
5	KIE Informed Consent	8	8	0	Isi sesuai	Ya	Nama Petugas Tidak terisi lengkap
6	CPPT	8	8	0	Isi sesuai	Ya	-
7	Ringkasan Pasien Pulang	8	8	0	Lengkap	Ya	-
8	Discharged Planning	8	8	0			
9	Edukasi kolaborasi	8	8	0	Isi sesuai	Ya	-
11	KIE Menjelang Akhir Kehidupan (Pada Pasien yang mau meninggal)	1	1	0	Isi sesuai		
12	Form AMA	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	
13	Semua Form yang ada Pemberian Informasi Ke Pasien	8	8	0	Isi Sesuai	Ya	
14	KIE Pre OP di Lembar Pre OP	1	1	0	Isi Sesuai	Ya	

Analisis : Seluruh DRM edukasi terisi , terdapat beberapa ketidaklengkapan meliputi kekurangan pada penulisan nama petugas pemberi KIE , Kekurangan pada isi yang kurang lengkap di perencanaan edukasi .

Rencana Tindak Lanjut : Sosialisasi kepada PPA Pelaksana untuk melengkapi DRM dengan baik dan benar

3.6.3.4 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

NO	UNIT	TARGET	KEGIATAN	MAR	APR	MEI	%	MANDOK	KET
1	Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	100%	
			Hypnoterapi						
			KIE						
2	Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	100%	
			Hypnoterapi						
			KIE						
3	Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	100%	
			Karya wisata						
4	Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	100%	
5	Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	
6	General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%		100%		100%	
7	Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							Planning dilakukan di Bulan Juli

3.6.3.5 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

NO	UNIT	TARGET	MAR	APR	MEI	%	MANDOK	KETERANGAN
1	PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
2	HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
3	STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
4	KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		
5	TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	0%		

Analisis : Penanggungjawab PROGNAS Inaktif selama Tahun 2024 tidak melakukan kegiatan edukasi kelompok

Rencana Tindak Lanjut : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat menghidupkan kembali kegiatan PROGNAS

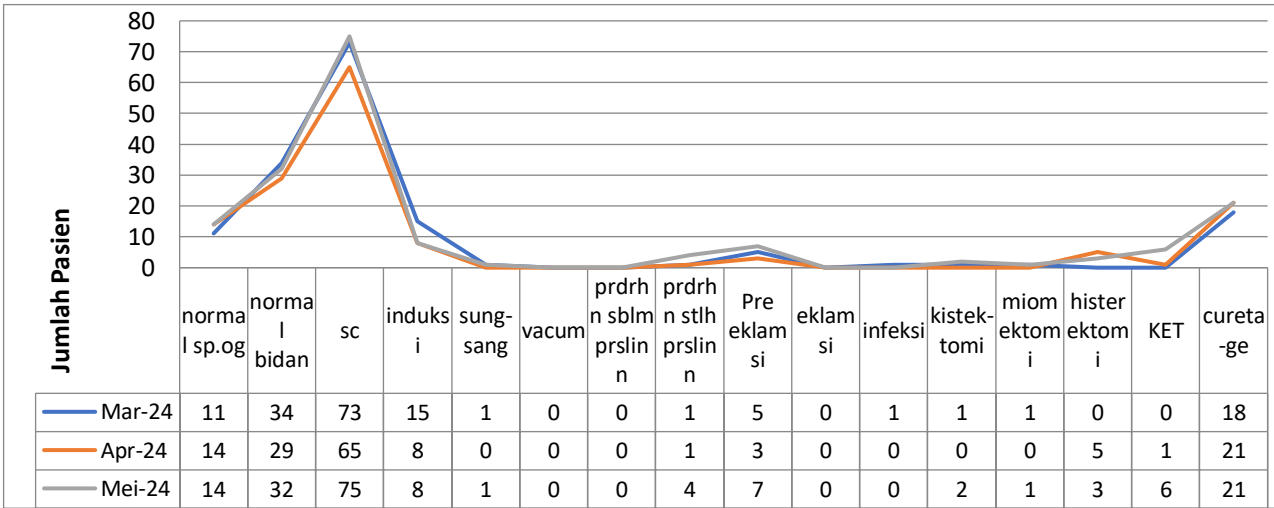
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Mei 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	11	14	14
	b. Persalinan Normal Bidan	34	29	32
	c. <i>SectioCaesaria</i>	73	65	75
2				
	a. Induksi / Drip	15	8	8
	b. Sungsang	1	0	1
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	1	4
	c. Pre Eklamsi	5	3	7
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	1	0	0
4				
	a. Curretage	18	21	21
	b. Kistektomi	1	0	2
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	0	5	3
	e. KET	0	1	6

3.6.2.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 75 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan April dan Mei 2024

tetap 14 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 32 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.

2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
3. Terdapat 1 Persalinan sungsang pada bulan Maret dan Mei 2024 sedangkan pada bulan April tidak ada persalinan sungsang. Sedangkan untuk persalinan dengan vacum pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024 tidak ada.
4. Induksi Persalinan pada bulan April dan Mei tetap sebanyak 8 pasien.
5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 7 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024.
6. Jenis pelayanan curretage di bulan April dan Mei 2024 tetap 21 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynecology biasanya dengan indikasi menometoragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

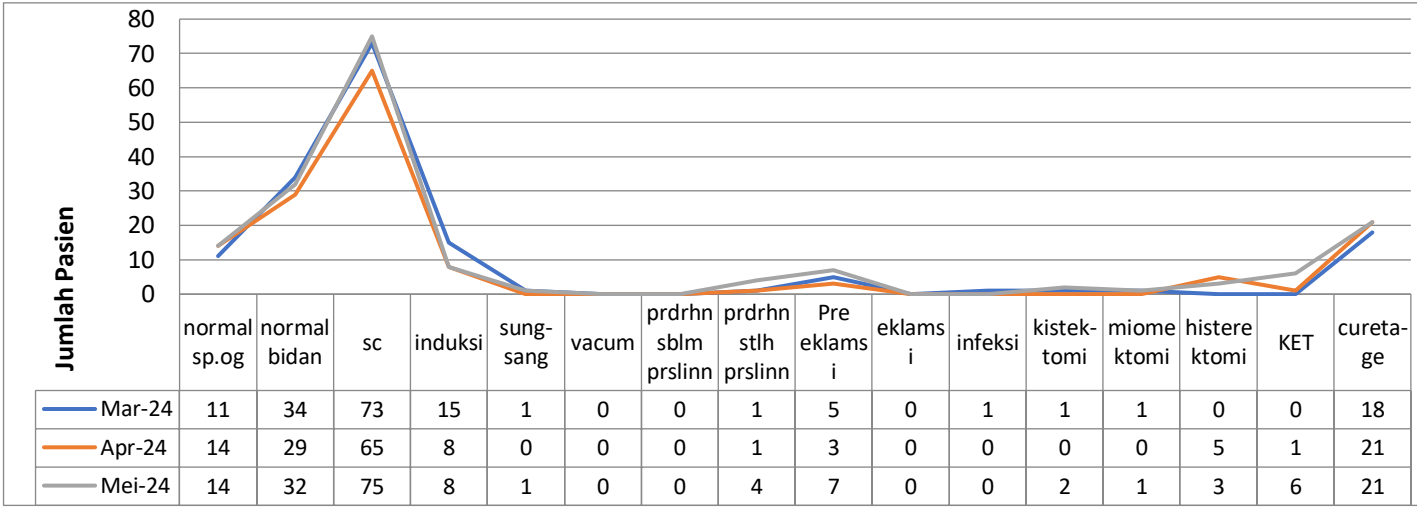
3.6.4.1.2 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.2.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Mei 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal Sp. OG	11	14	14
	b. Persalinan Normal Bidan	34	29	32
	c. <i>SectioCaesaria</i>	73	65	75
2				
	a. Induksi / Drip	15	8	8
	b. Sungsang	1	0	1
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	0	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	1	1	4

	c. Pre Eklamsi	5	3	7
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	1	0	0
4				
	a. Curretage	18	21	21
	b. Kistektomi	1	0	2
	c. Miomektomi	1	0	1
	d. Histerectomy	0	5	3
	e. KET	0	1	6

3.6.2.1.2.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

- Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 75 pasien. Dan untuk persalinan normal ditolong dokter pada bulan pada bulan April dan Mei 2024 tetap 14 pasien. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 32 pasien. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong bidan terlebih dahulu.
- Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
- Terdapat 1 Persalinan sungsang pada bulan Maret dan Mei 2024 sedangkan pada bulan April tidak ada persalinan sungsang. Sedangkan untuk persalinan dengan vacum pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024 tidak ada.
- Induksi Persalinan pada bulan April dan Mei tetap sebanyak 8 pasien.
- Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 7 pasien. Dan tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024.
- Jenis pelayanan curretage di bulan April dan Mei 2024 tetap 21 pasien. *Curretage* dilakukan untuk indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-

kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometoragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut

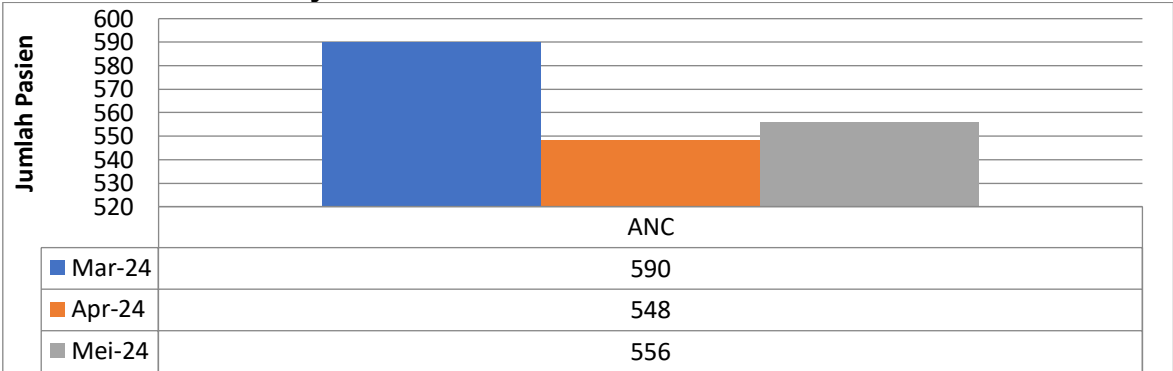
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)

Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponok RSPHM Mei 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	ANC	590	548	556

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

Pelayanan ANC pada bulan Mei 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 556 kunjungan.

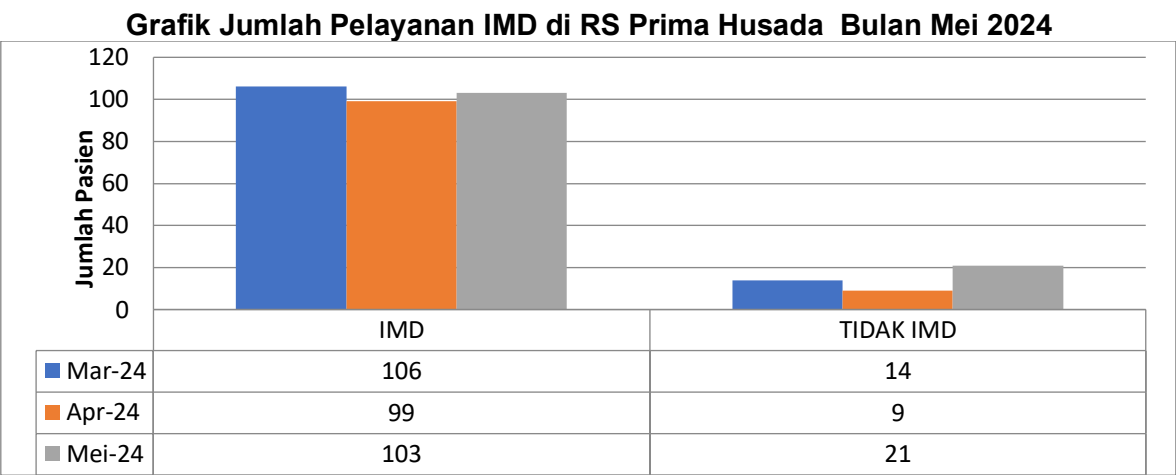
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Mei 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	IMD	106	99	103
2	Tidak IMD	14	9	21

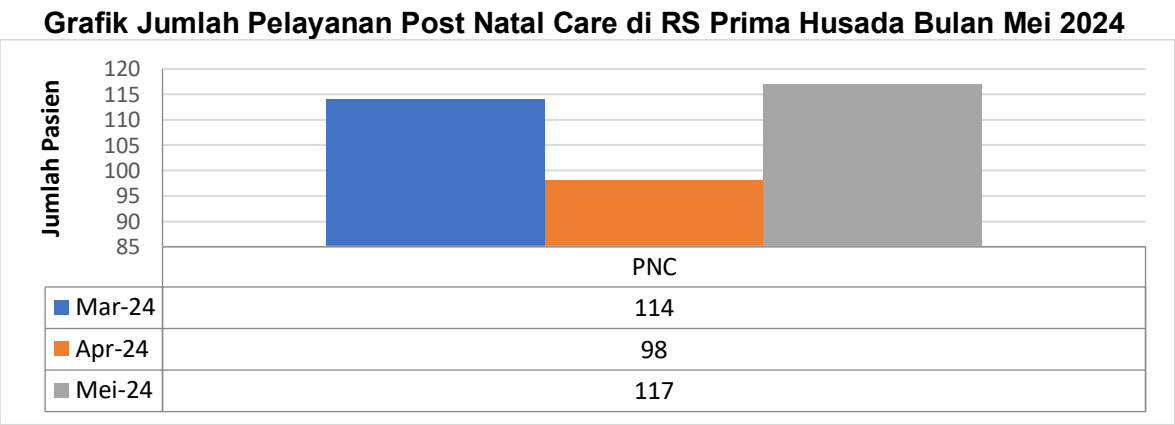


- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Mei 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 103 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 21 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Mei 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	PNC	114	98	117



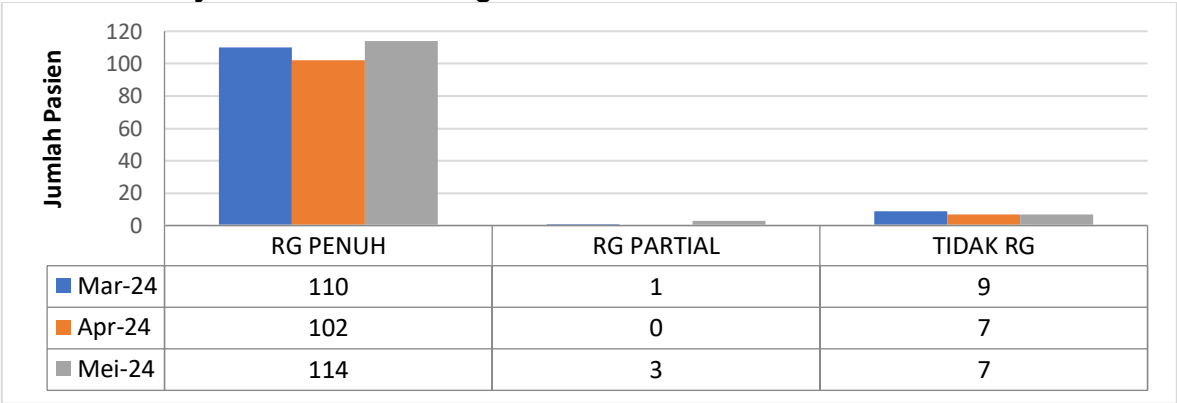
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 117 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponек Mei 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Rawat gabung penuh	110	102	114
2	Rawat gabung partial	1	0	3
3	Tidak Rawat gabung	9	7	7

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 114 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan April dan Mei 2024 sama, yaitu sebanyak 7 bayi.

Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram dan masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan.

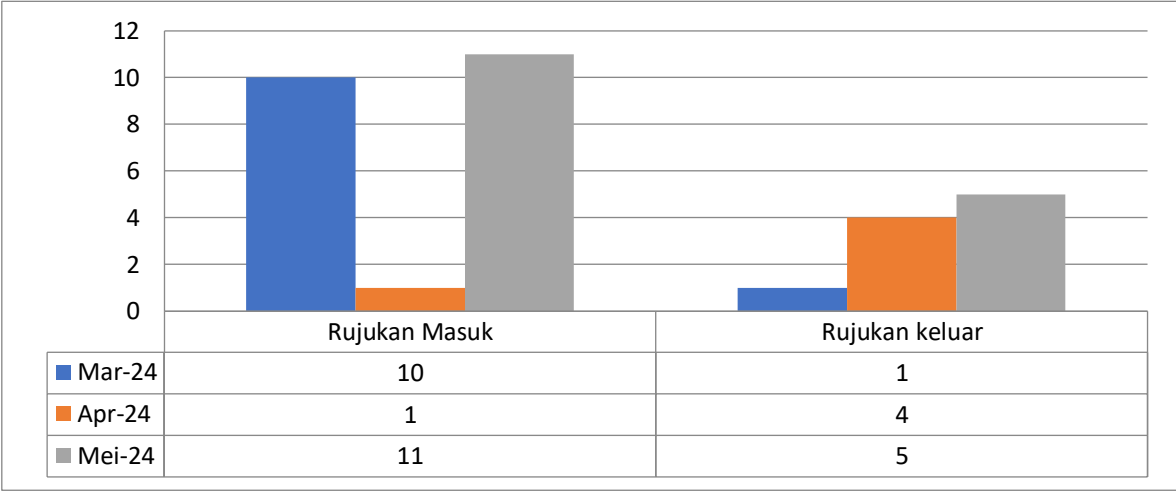
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Mei 2024

NO	RUJUKAN	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Rujukan Masuk	10	1	11
2	Rujukan keluar	1	4	5

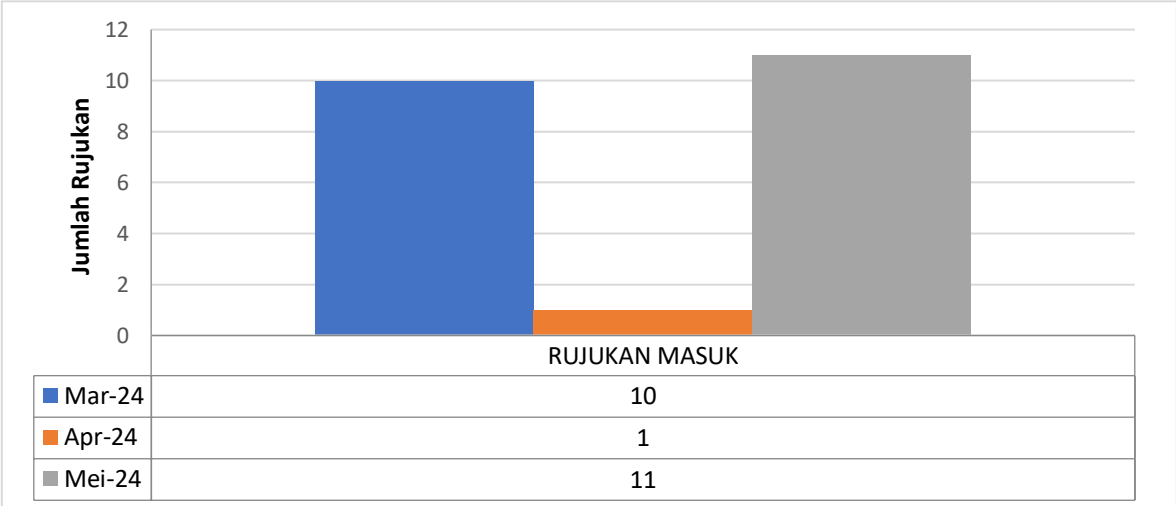
Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Mei 2024



3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Mei 2024

BULAN MARET 2024		
1	G1 P0000 Ab000 UK 30-32 mgg dengan PPR0M	RS Sumber Sentosa
2	G1 P0000 Ab000 UK : 28-30 mgg dg obs vomiting + anemia	Klinik Mutiara Sehat
3	G3 P2002 Ab000 UK : 39-40 mgg dg Prolong Fase laten + KPD	PKM Singosari
4	G1 P0000 AB000 UK 40-41 MGG DG KIFL	BPM Anis Sulisyorini
5	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg BSC	PMB Indi
6	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 mgg dg prolong fase laten	RS Marsudi Waluyo
7	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 mgg dg KIFL + BSC	BPM Sri Utami
8	G1 P0000 Ab000 UK 39-40 mgg dg PE	BPM Titik
9	G2 P1001 Ab000 UK 42 mgg dg KIFA+ PE	BPM Lilik Agustina
10	G3 P2002 Ab000 UK 38-39 mgg dg PE	BPM Subaeda
BULAN APRIL 2024		
1	G1 P0000 ab000 UK 38-39 mgg dg PEB	BPM Sofia
BULAN MEI 2024		
1	G1 P0000 Ab000 Uk 35-36 mgg dg PPR0M	RS Permata Bunda
2	Late HPP + Iekosinosis + anemia	PKM Pakis
3	G2 P1001 ab000 Uk 35-36 mgg dg PPI + letak lintang	RS Munir
4	G3 P2002 Ab000 Uk 32-33 mgg dg BSC 2x	BPM Indah M
5	G2 P0000 Ab000 Uk 30 mgg dg PPI	RS Permata Bunda
6	G2 P1001 ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	PKM Ardimulyo
7	G1 P0000 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Tri Widiyawati
8	G1 P0000 Ab000 Uk 28-30 mgg dg Gemeli + PPI	BPM Nuri Afanti
9	G3 P2002 Ab000 Uk 40-41 mgg dg kala 2 lama	BPM Suma'iyah
10	KET + ANEMIA	Klinik Putra Husada
11	G1 P0000 ab000 Uk 32-34 mgg dg KIFL + PPI	Rs Permata Bunda

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Mei 2024



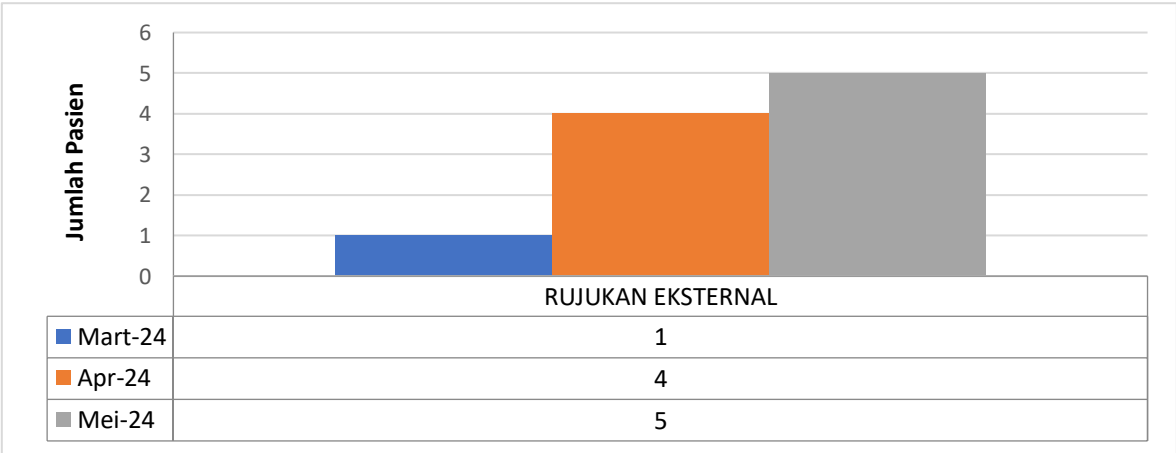
Analisis :
Jumlah rujukan masuk pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 11 rujukan masuk.

Rencana dan Tindak Lanjut
Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponok Mei 2024

BULAN MARET 2024		
1	NKB + BBLSR + ASFIKSIA	RS Soepraoen
BULAN APRIL 2024		
1	RDS+HMD dd Neonatal Pneumonia	RS Lavalette
2	RDS dd HMD + BBLSR	RS Lavalette
3	RDS + Prematur + BBLSR	RS Saiful Anwar
4	Akut Abdomen + kista ovarium curiga ganas	RS Saiful Anwar
BULAN MEI 2024		
1	G4 P2012 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Gemeli + PE + edema paru	RS Saiful Anwar
2	G4 P2002 Ab000 UK 28-30 mgg dg Impending Eklamsia	RS Saiful Anwar
3	Prematur BBLASR + RDS okHMD dd Neonatal Pneumonia	RS Saiful Anwar
4	Post Op Eksplorasi Laparatomi + CKD	RS Saiful Anwar
5	Neonatal seizure	Rs Soepraoen

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :
Pada bulan Mei 2024 pasien yang dirujuk keluar meningkat jika dibandingkan dengan 2

bulan Sebelumnya, yaitu 5 pasien.

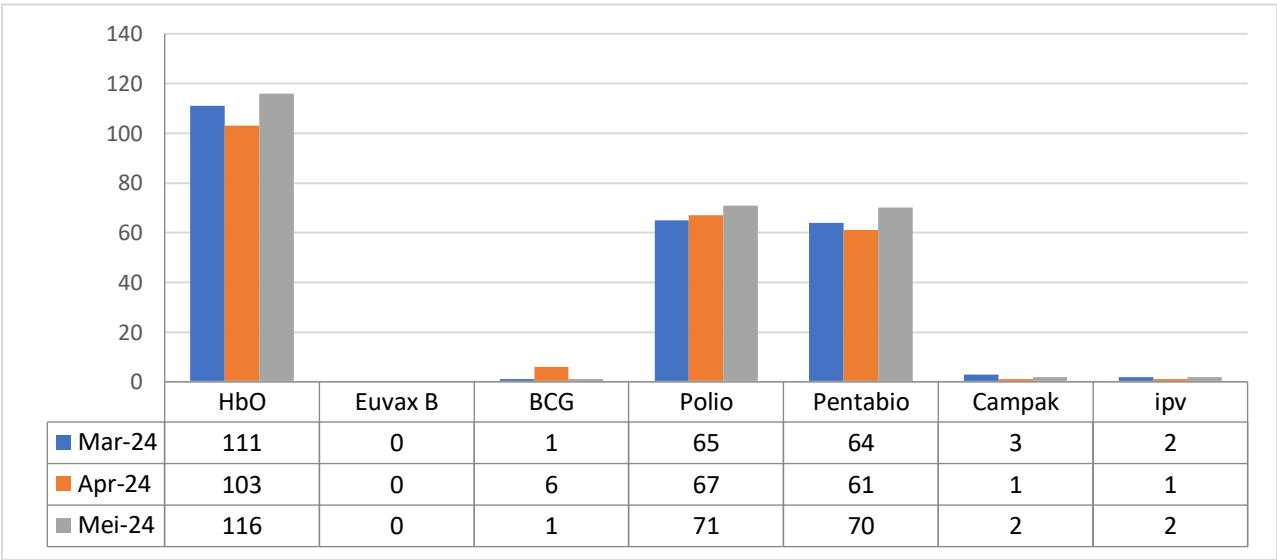
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Mei 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	HbO	111	103	116
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	6	1
3	Polio	65	67	71
4	Pentabio	64	61	70
5	Campak	3	1	2
6	IPV	2	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Mei 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi Hb0 unijek.
2. Imunisasi Hb0 pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 116 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Mei sedikit meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
5. Pada periode Mei 2024 bayi yang melakukan Imunisasi Campak mengalami penurunan yaitu 2 bayi.
6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 71 bayi
7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 70 pasien

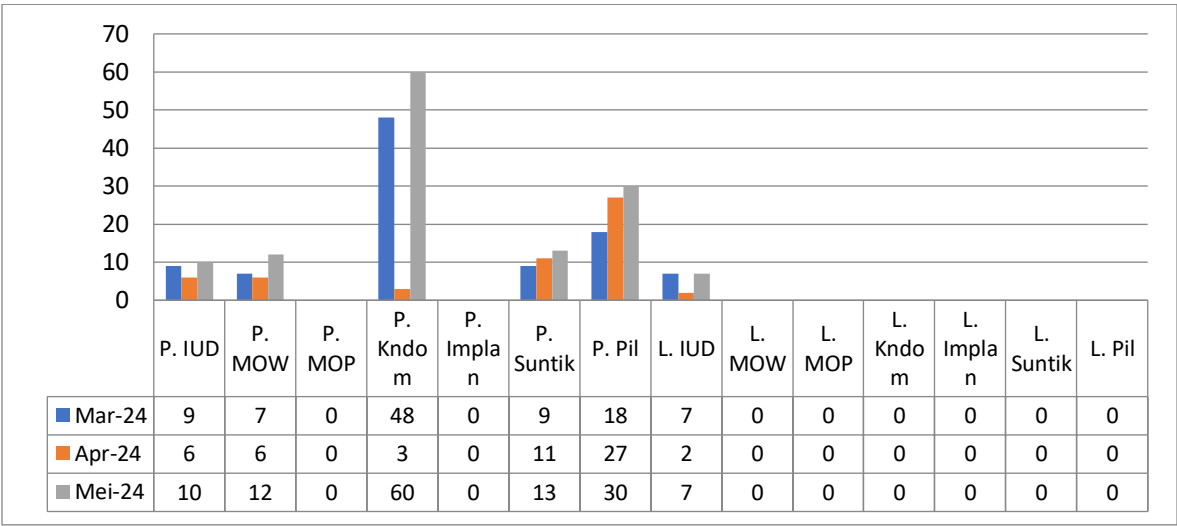
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1.Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2.Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Mei 2024

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024	BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	IUD	9	6	10	7	2	7
2	MOW	7	6	12	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	48	3	60	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	9	11	13	0	0	0
7	Pil	18	27	30	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 10 akseptor
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 12 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu hanya 60 pasien.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 30 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Mei 2024 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 13 penggunaan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 pengguna

Rencana dan Tindak Lanjut :

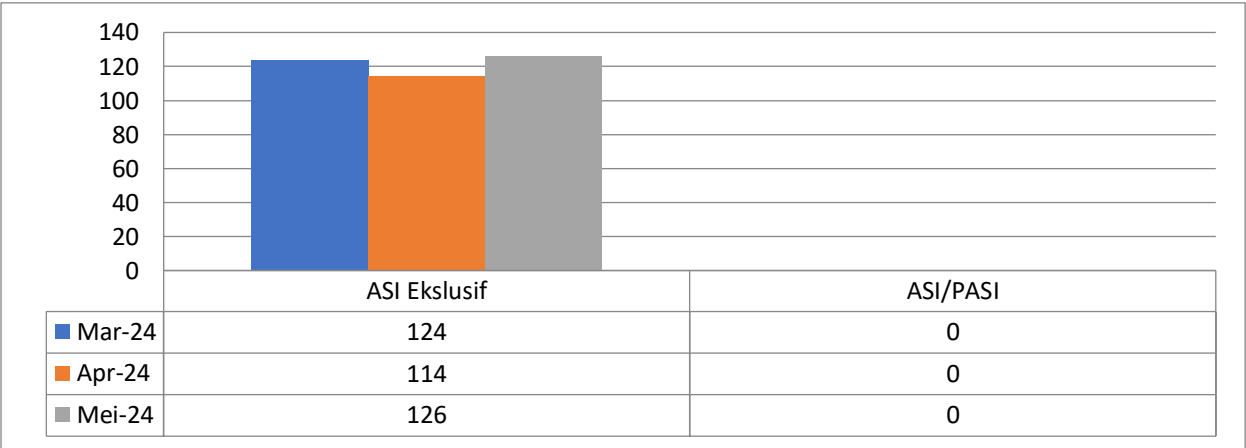
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Ponek Mei 2024

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Asi eksklusif	124	114	126
2	Asi /PASI	0	0	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



- Analisis :
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 126 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
 - 2. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

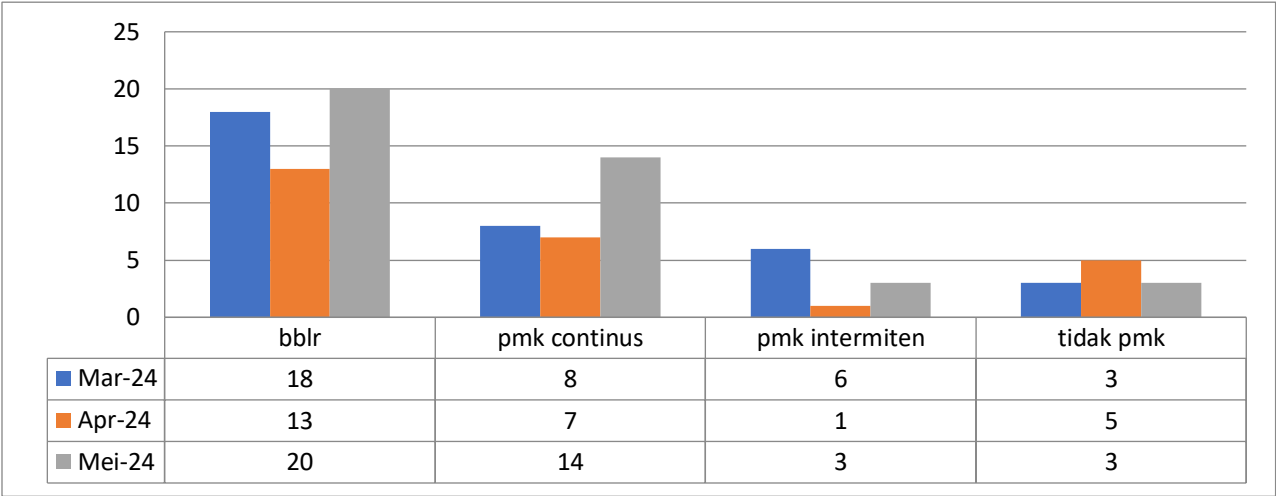
Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR

Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek RSPHM April 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	Bayi BBLR	18	13	20
2	PMK continuos	8	7	14
3	PMK Intermiten	6	1	3
4	Tidak PMK	3	5	3

Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menjadi 3 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 14 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Dan terdapat 3 bayi yang masih tidak dilakukan PMK pada bulan Mei 2024, dan menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK atau bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

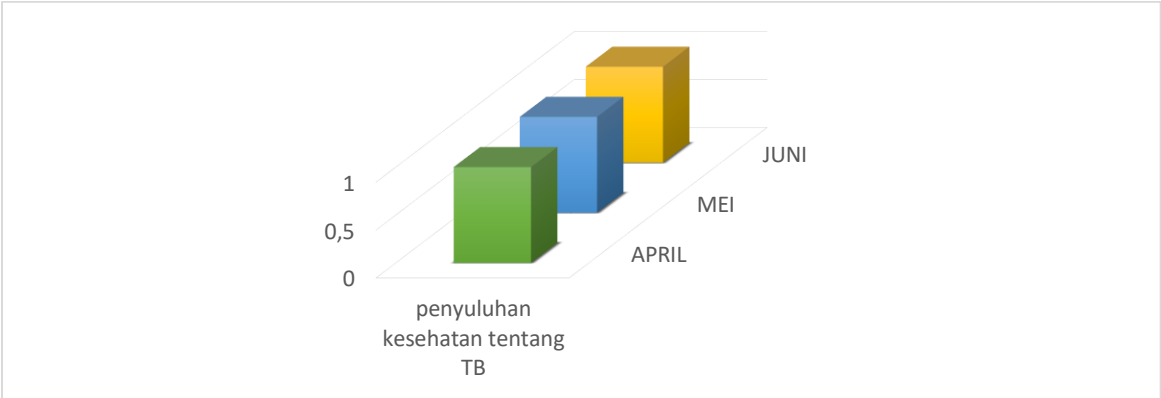
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

3.1.2.2. TB DOTS

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	-

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



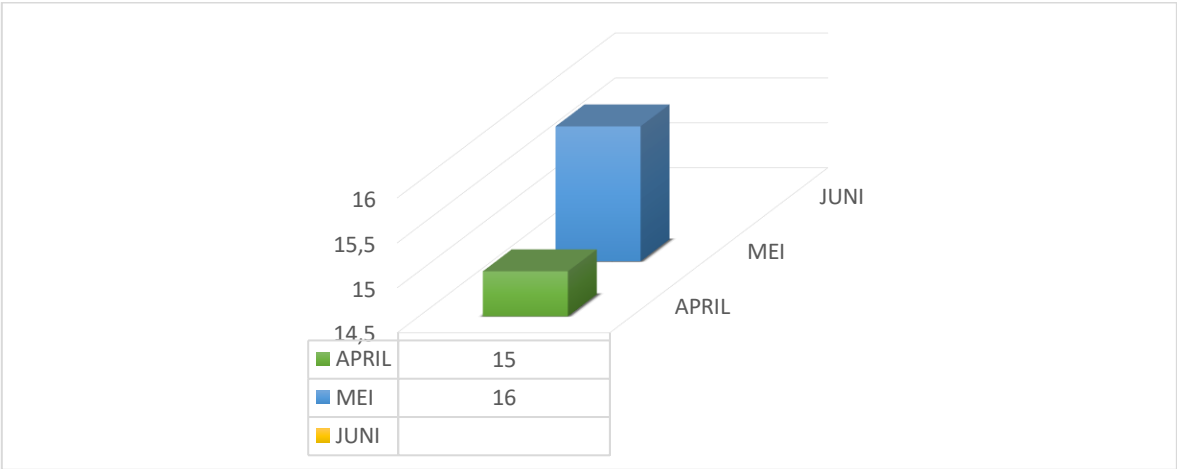
Analisis:
Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dll.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian Masker	15	16	-

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker Di RS Prima Husada



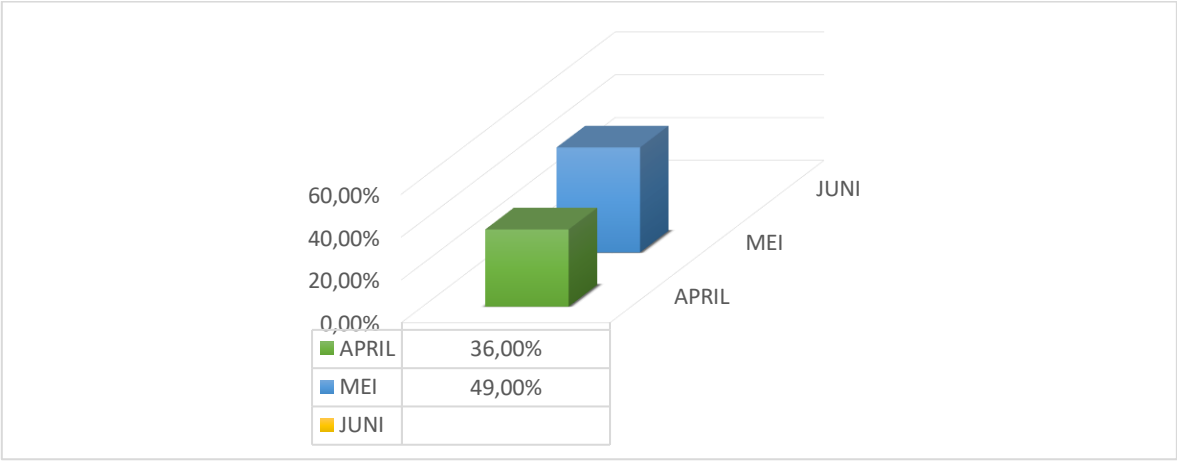
Analisis :
Pada bulan Mei 2024 terdapat 16pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
 - 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	36	49	-

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Di RS Prima Husada

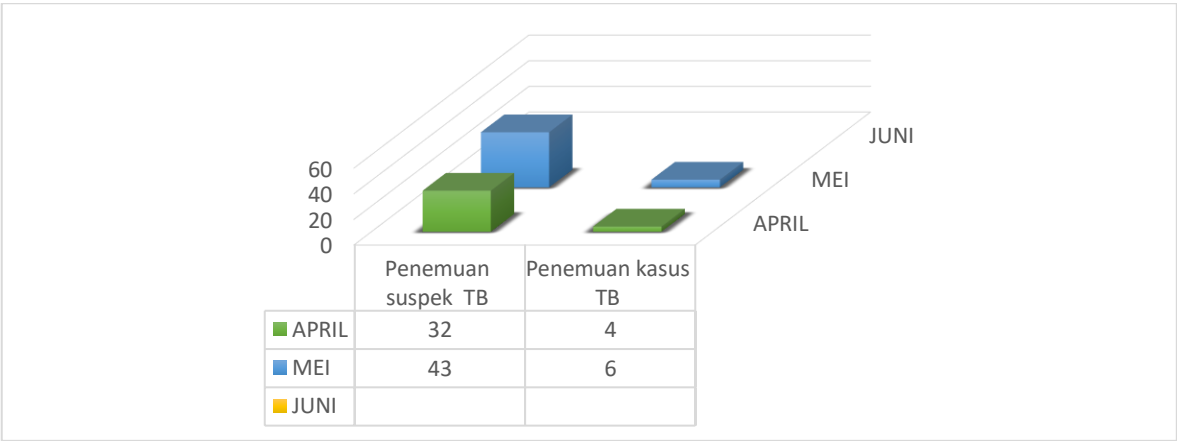


- Analisis :**
- 1. Pada bulan APRIL 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36
 - 2. Pada bulan MEI 2024 jumlah proporsi Pasien terduga TB 49
- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penemuan suspek TB	32	43	-
2	Penemuan kasus TB	4	6	-

Grafik Penemuan Kasus TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



- Analisis :**
- 1. Pada bulan April 2024 terdapat 32 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 4 pasien
 - 2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 43 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 6 pasien

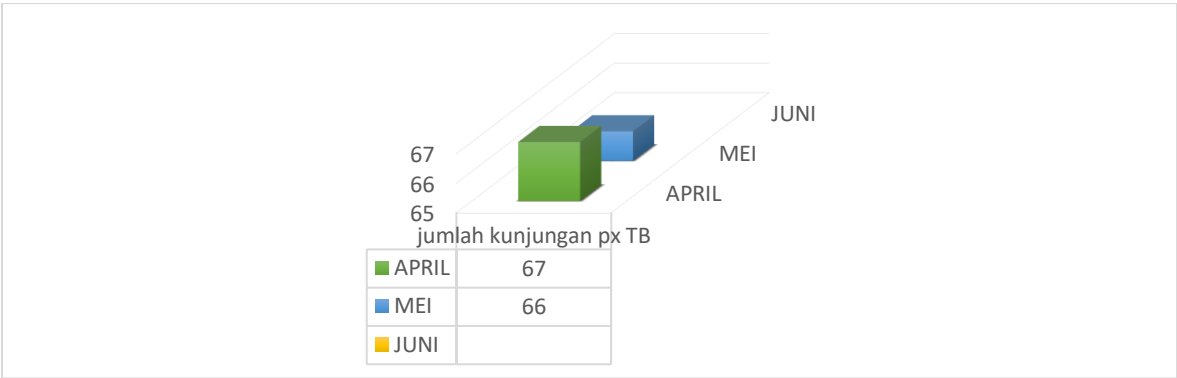
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	67	66	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru Di Rumah Sakit Prima Husada



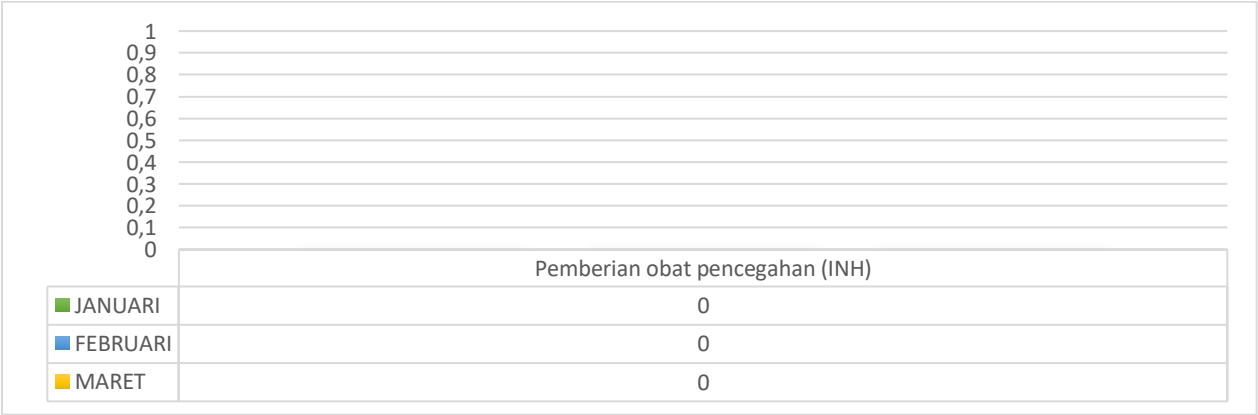
- Analisis:**
- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan APRIL 2024 di poli pasien TBC mencapai 67 pasien.
 - 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan MEI 2024 di poli pasien TBC mencapai 66 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	-

Grafik Pemberian Obat Pencegahan Di Rumah Sakit Prima



Analisis :
Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

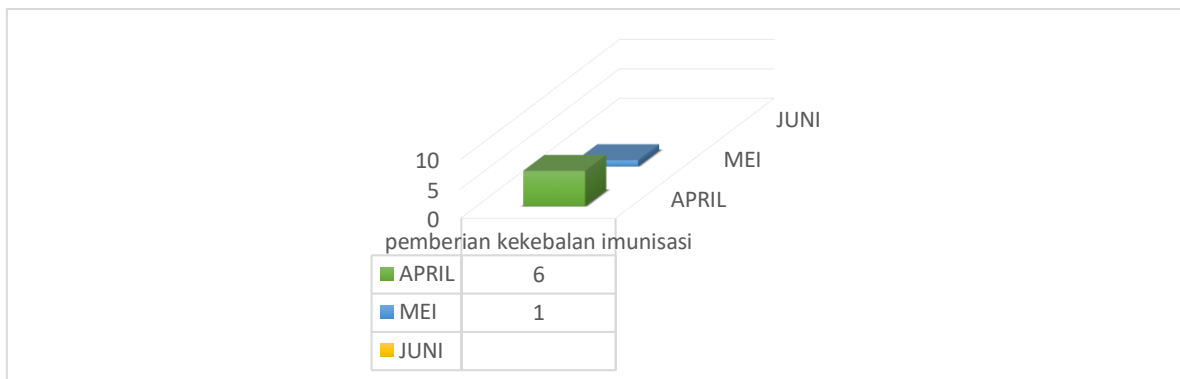
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	6	1	-

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



Analisis :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 6 pasien yang diimunisasi pada bulan April
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei

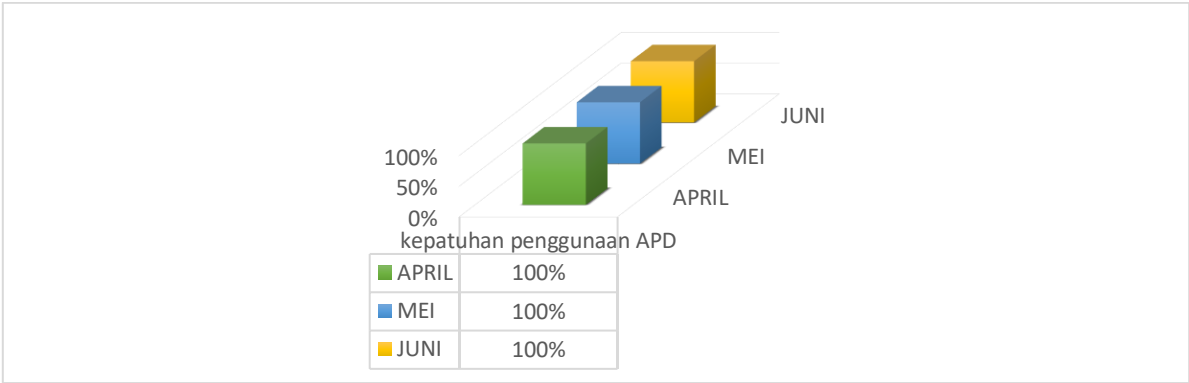
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	-

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



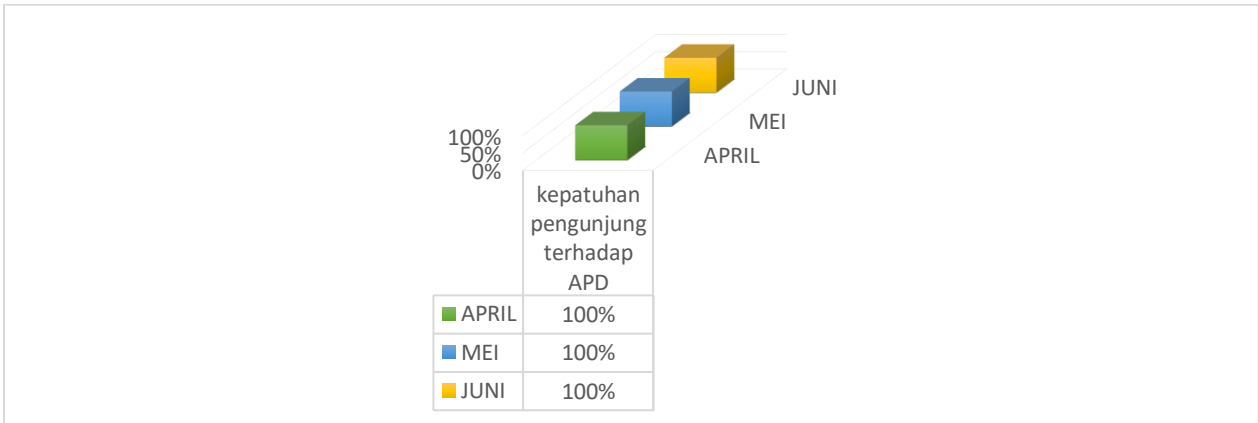
Analisis :
Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	-

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD Di RS Prima Husada



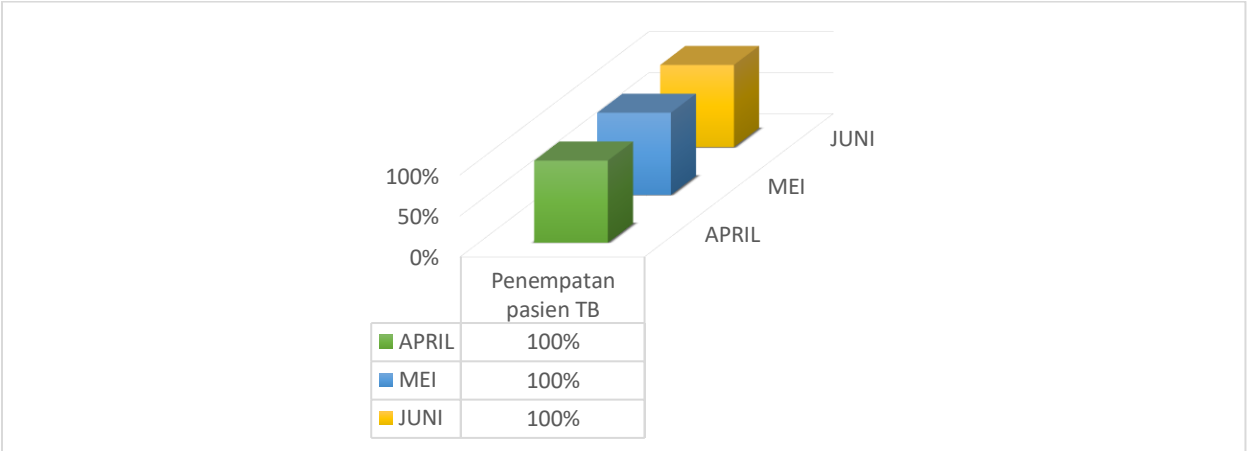
Analisis:
Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	-

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



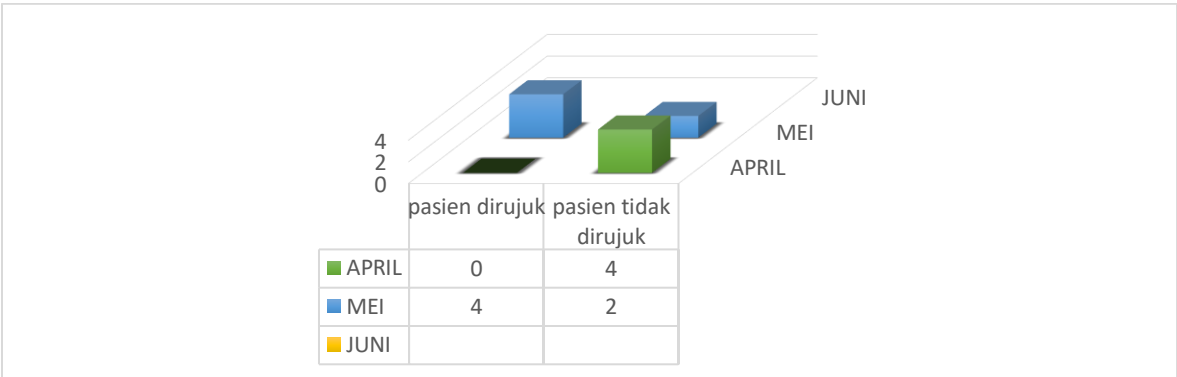
Analisis:
Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB yang dirujuk	0	4	-
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	4	2	-

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



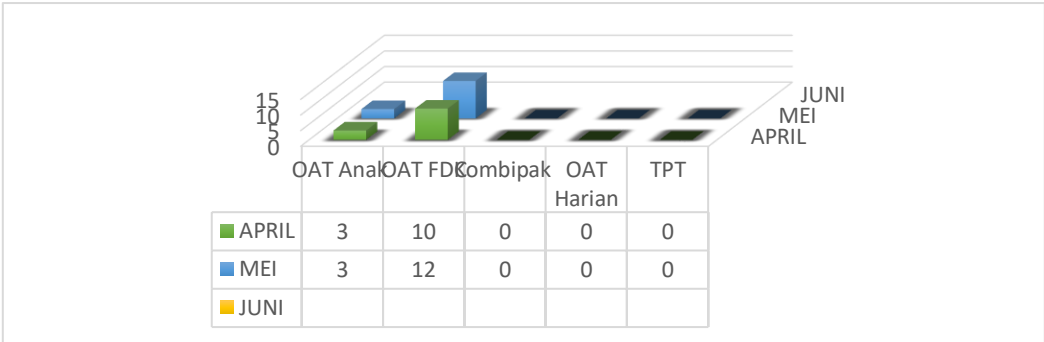
- Analisis :**
- 1. Pada bulan April 2024 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
 - 2. Pada bulan Mei 2024 terdapat 4 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	OAT Anak	3	3	-
2.	OAT Dewasa	10	12	-
3.	Kombipak	0	0	-
4.	OAT Harian	0	0	-
5.	TPT	0	0	-

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



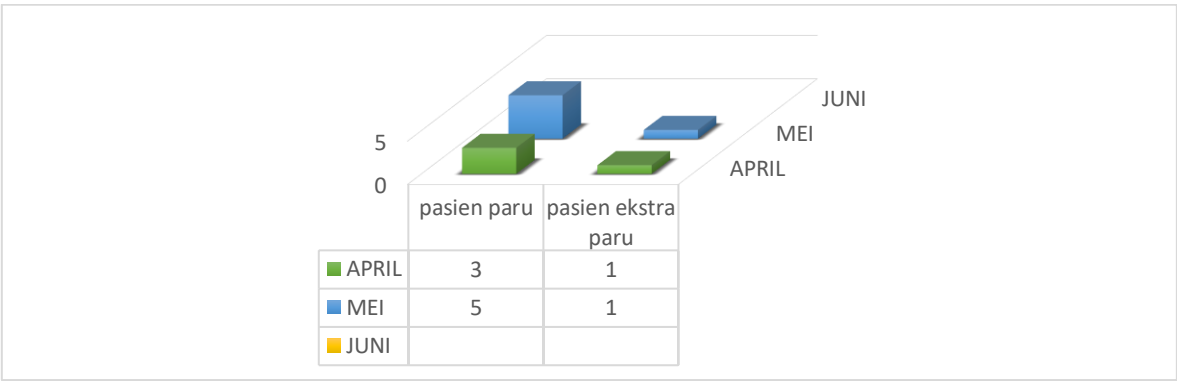
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien paru	3	5	-
2.	Pasien Ekstra paru	1	1	-

Grafik Pasien Paru dan Ekstra paru Di Rumah Sakit Prima Husada



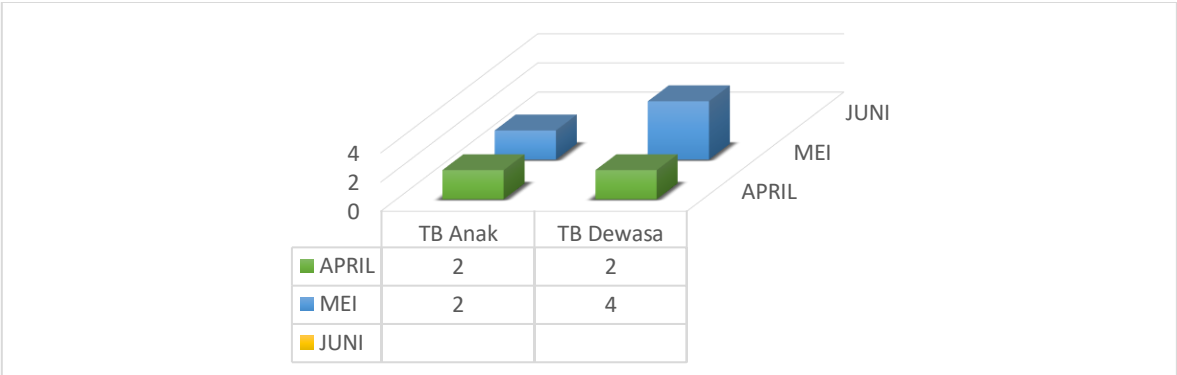
Evaluasi :
1. Pada bulan APRIL 2024 terdapat 1 pasien ekstra paru
2. Pada bulan MEI 2024 terdapat 0 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama.

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien Anak	2	2	-
2.	Pasien Dewasa	2	4	-

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



- Analisis :**
- 1. Pada bulan APRIL terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 2 pasien
 - 2. Pada bulan MEI terdapat 2 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 4 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATUH	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P	Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P	Ny. S	V		

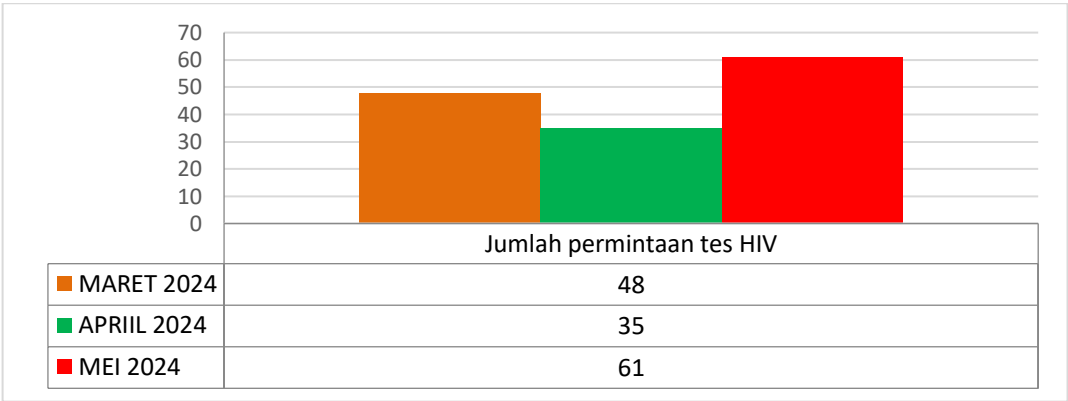
Analisis :
Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Permintaan Test HIV	48	35	61

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan Mei 2024 meningkat menjadi 61 pemeriksaan dibandingkan pada bulan maret 2024 sebanyak 48 sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 35 pasien. Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

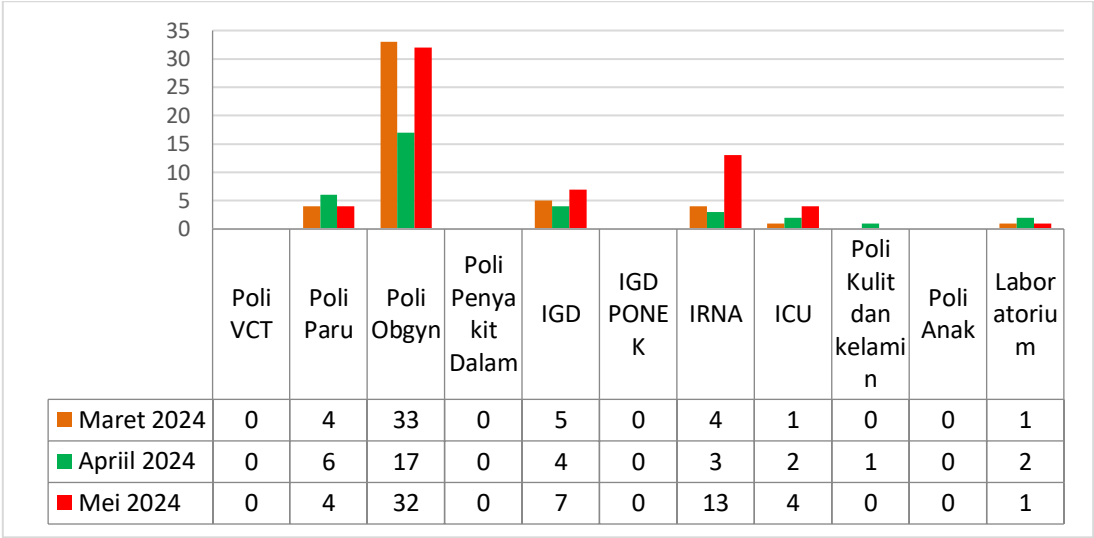
Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	4	6	4
3	Poli Obgyn	33	17	32
4	Poli Penyakit Dalam	0	0	0
5	IGD	5	4	7
6	IGD PONEK	0	0	0
7	IRNA	4	3	13

8	ICU	1	2	4
9	Poli Kulit dan kelamin	0	1	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	1	2	1

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain mulai bulan maret 2024 sebanyak 33 pasien, sedangkan pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien sedangkan pada bulan Mei sebanyak 32 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

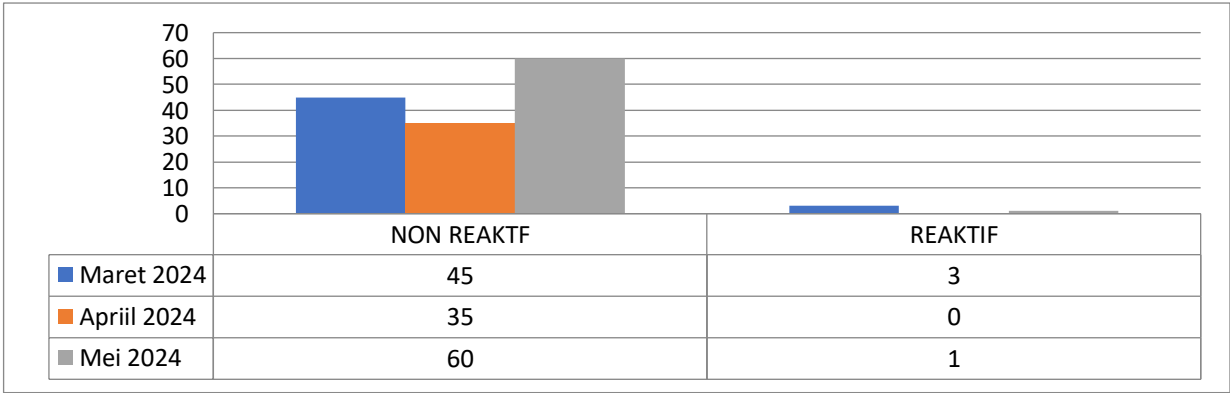
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Non Reaktif	45	35	60
2	Reaktif	3	0	1

Grafik Status HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan 1 data status HIV dengan status reaktif pada pada bulan Mei 2024. Jumlah status reaktif dibanding pada bulan sebelumnya meningkat dari 0 pasien menjadi 1.

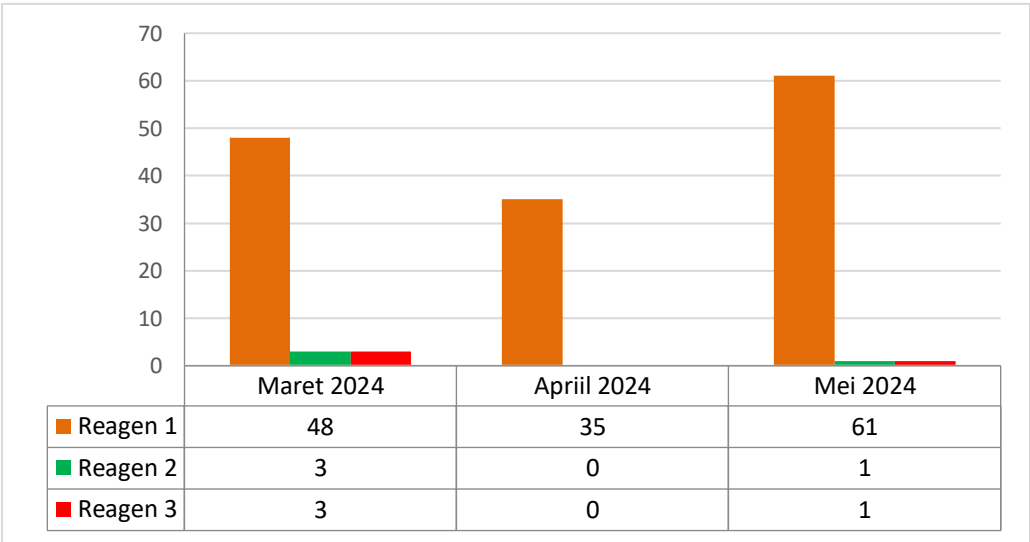
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah Sakt Prima Husada Malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Reagen 1	48	35	61
2	Reagen 2	3	0	1
3	Reagen 3	3	0	1

**Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024**



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen Pada bulan maret ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Pada bulan April 2024 pemakaian reagen sampai dengan reagen 1 saja. Sedangkan pada bulan Mei ditemukan memakai sampai dengan reagen 3. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei 2024 ditemukan pasien dengan hasil HIV Reaktif sebanyak 1 paisen.

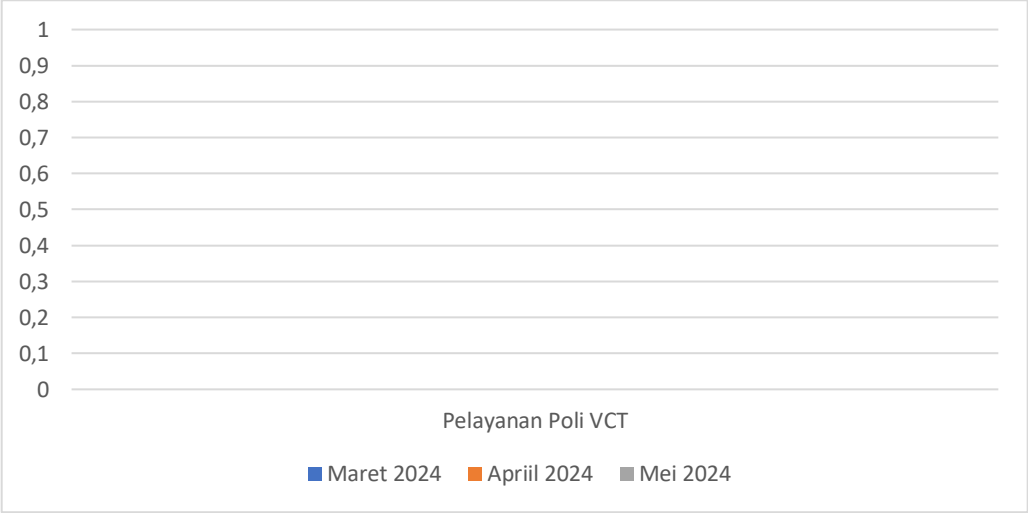
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

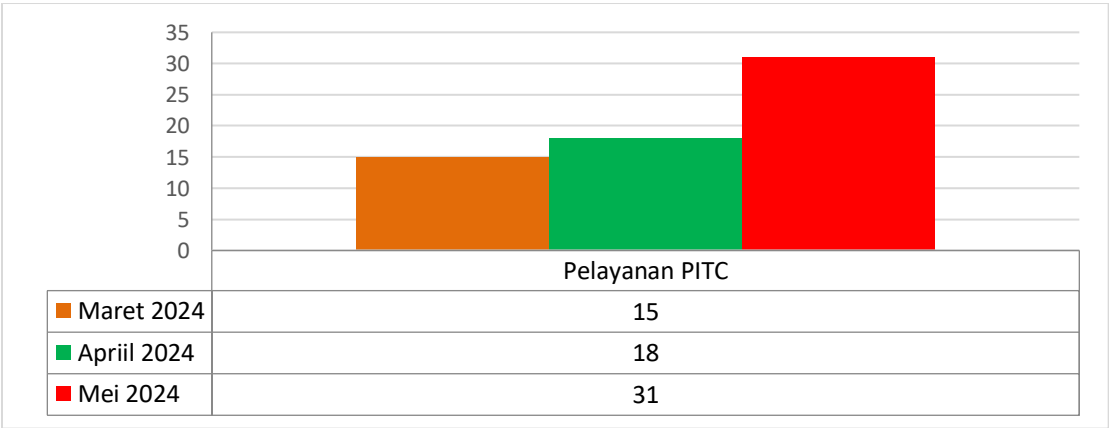
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husada belum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Pelayanan PITC	15	18	31

Grafik Pelayanan PITC Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024



Analisis :

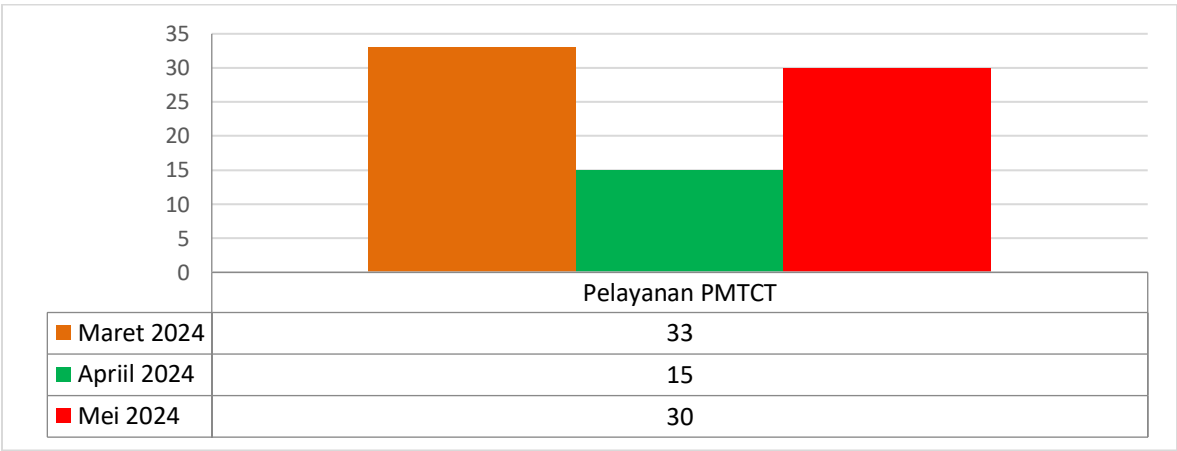
Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan maret 2024 sebanyak 15 pasien, pada bulan april 2024 sebanyak 18 pasien, Sedangkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 31 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjangkaran pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Pelayanan PMTCT	33	15	30

**Grafik Pelayanan PMTCT Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Mei 2024**



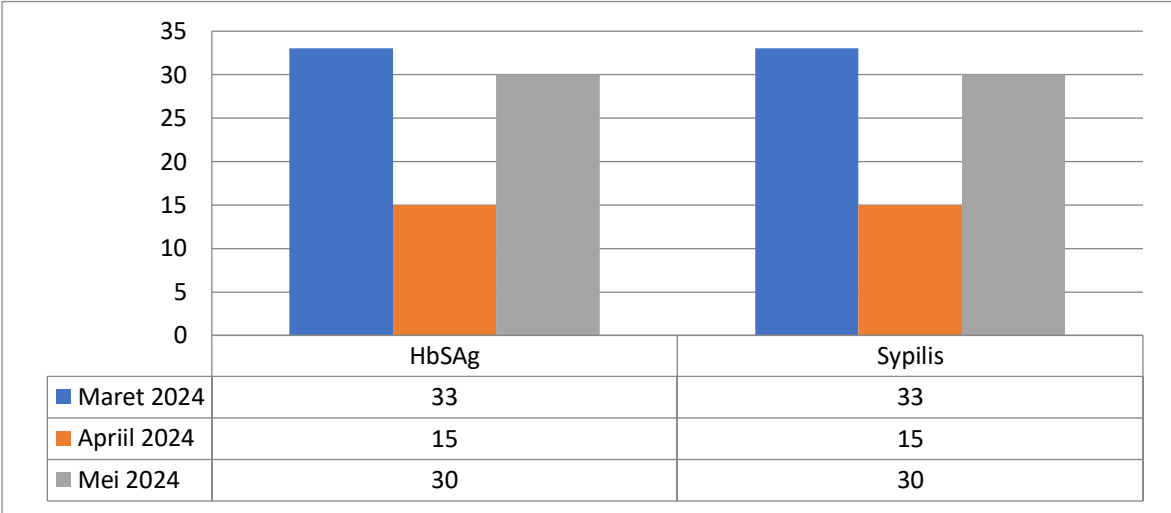
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan maret sebanyak 33 pasien, pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien, sedangkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	HbSAg	33	15	30
2	Sypilis	33	15	30

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



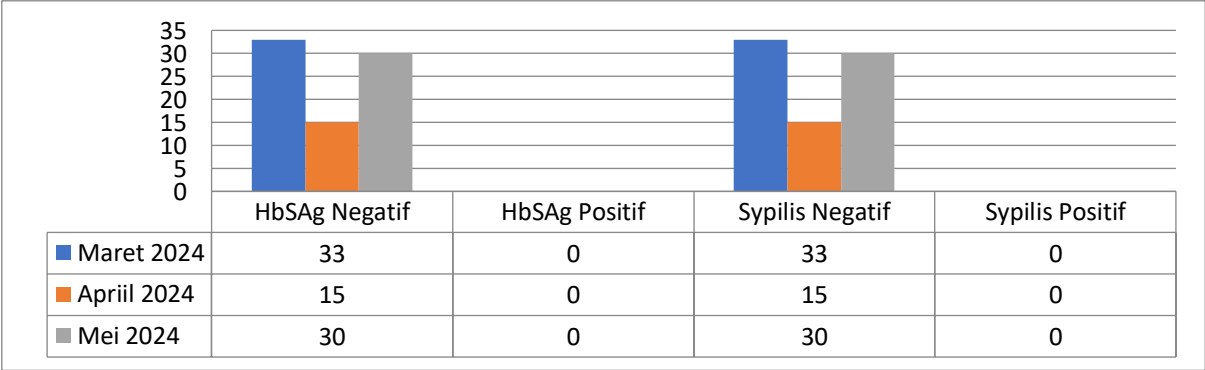
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan maret 2024 sebanyak 33 pasien, pada bulan april 2024 sebanyak 15 pasien, sedangkan pada bulan Mei 2024 sebanyak 30 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	HbSAg			
	Negatif	33	15	30
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	33	15	30
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa Pada bulan Maret 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif, Sedangkan pada bulan April 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif, begitu juga dengan bulan Mei 2024 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Syphilis dengan hasil positif.

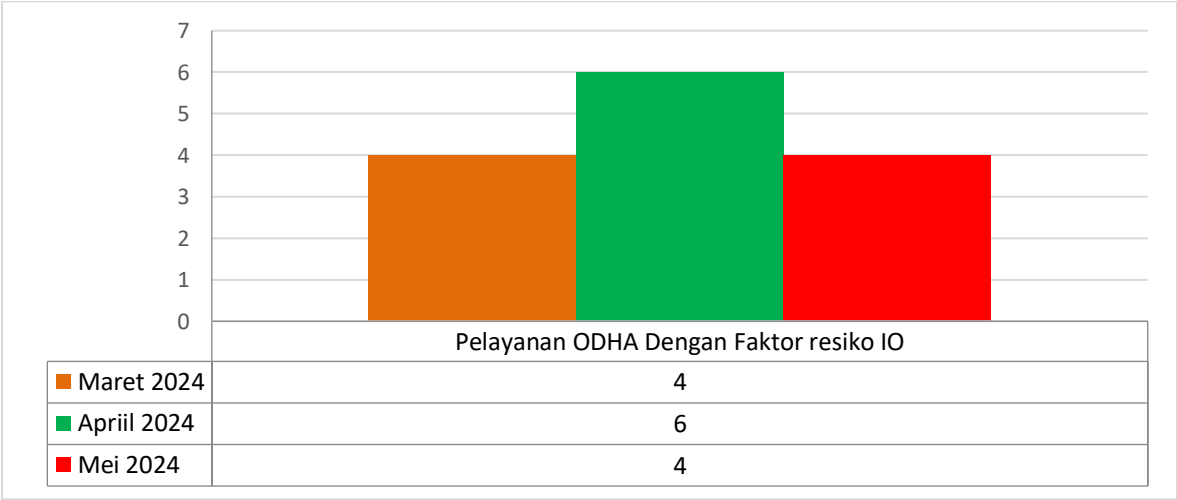
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- 2. Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	4	6	4

Grafik Pelayanan Odha Dg Faktor Resiko IO Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan Maret 2024 terjadi penurunan yaitu sebanyak 4 pasien, pada bulan april 2024 sebanyak 6 pasien sedangkan pada bulan Mei 2024 terjadi penurunan menjadi 4 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

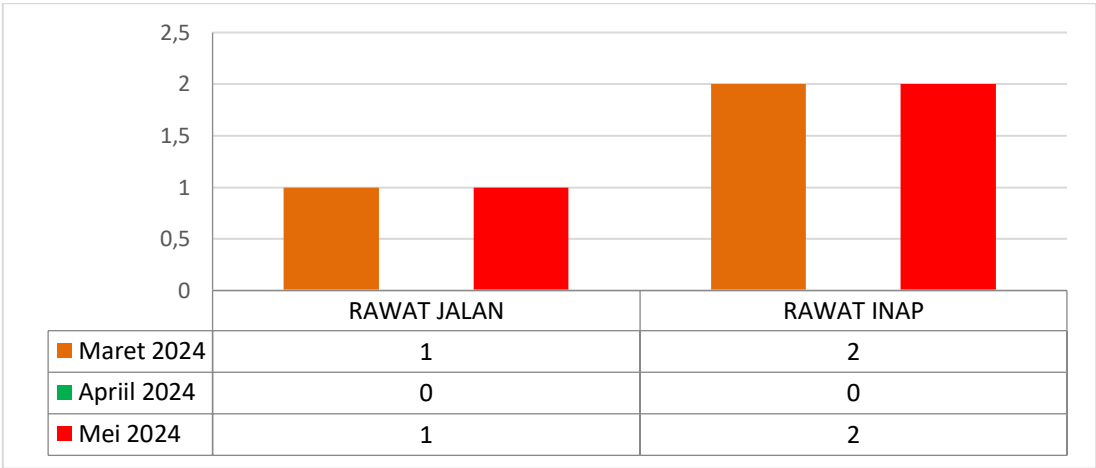
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di rRumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
1	Rawat Jalan	1	0	1
2	Rawat Inap	2	0	2

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan Hiv/Aids Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pada bulan maret 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk eksternal, yaitu 1 dari rawat jalan dan 2 dari rawat inap. pada bulan april 2024 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk. Sedangkan pada bulan Mei 2024 terdapat 3 pasien yang dilakukan rujuk yaitu dari rawat jalan 1 pasien, dari rawat inap sebanyak 2 pasien. Hal ini dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Mei 2024

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husda Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan

		2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Pada Bulan Februari tidak terdapat Kerjasama dengan komunitas eksternal
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	MAR 2024	APR 2024	MEI 2024
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1

	2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat					
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	0	0
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	-	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	0	0
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pada bulan Mei karena terdapat 1 balita stunting dan wasting yang berasal dari puskesmas Ardimulyo. Sehingga Ahli Gizi Puskesmas Ardimulyo melakukan koordinasi dengan Ahli gizi RSPHM untuk pemberian PKMK, Bubuk Taburia, dan mineral mix terhadap pasien tersebut.

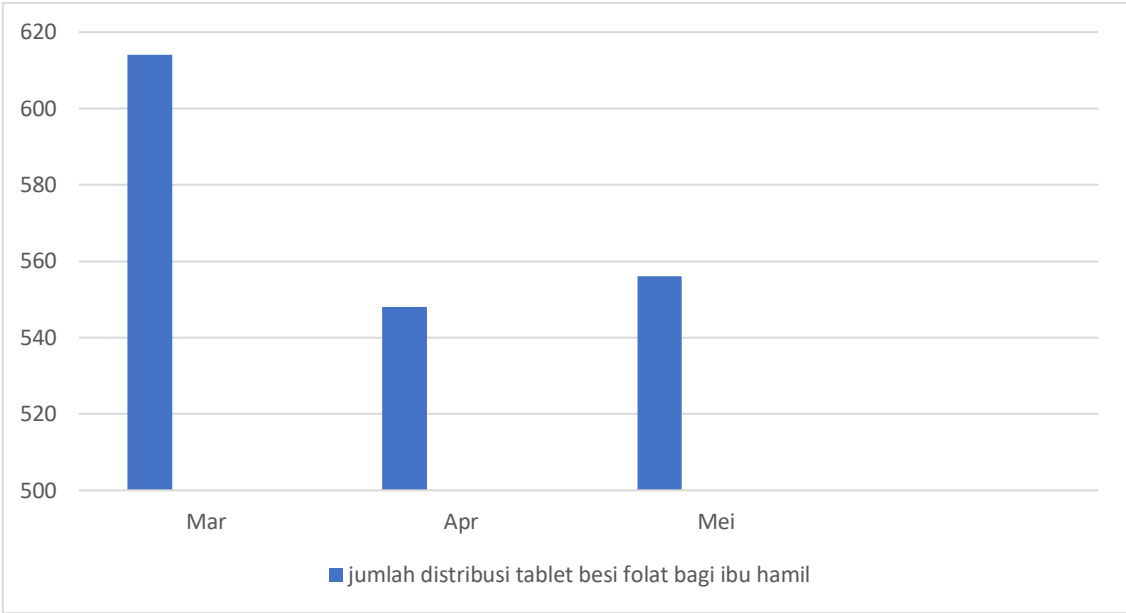
Rencana Tindak Lanjut :
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil

Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	MAR 2024	APR 2024	MEI 2024
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	614	548	556

Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat pada bulan Mei yaitu 556 ibu hamil.

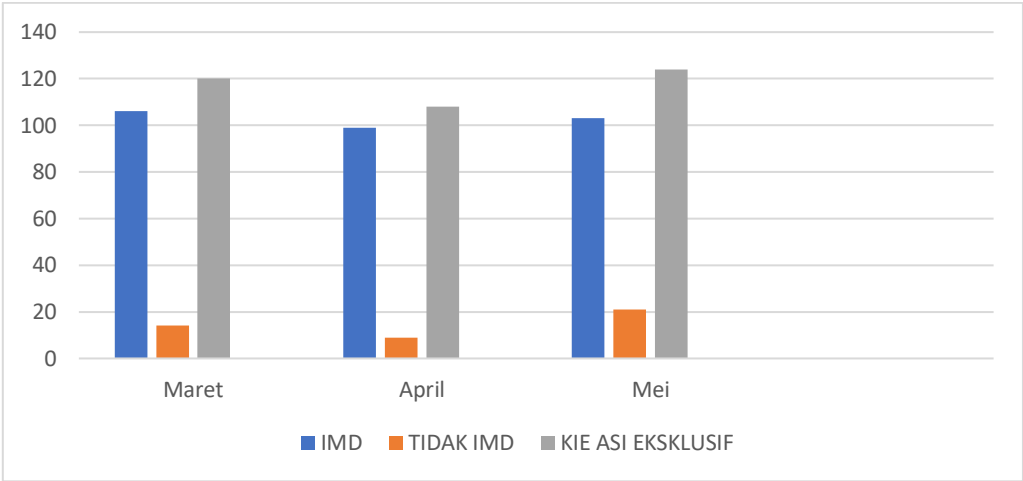
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	IMD	106	99	103
2	Tidak IMD	14	9	21
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	120	108	124

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu 103 bayi.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 21 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Januari 2024 dikarenakan terdapat dokter spesialis kandungan baru sehingga juga meningkatkan kunjungan jumlah pasien ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

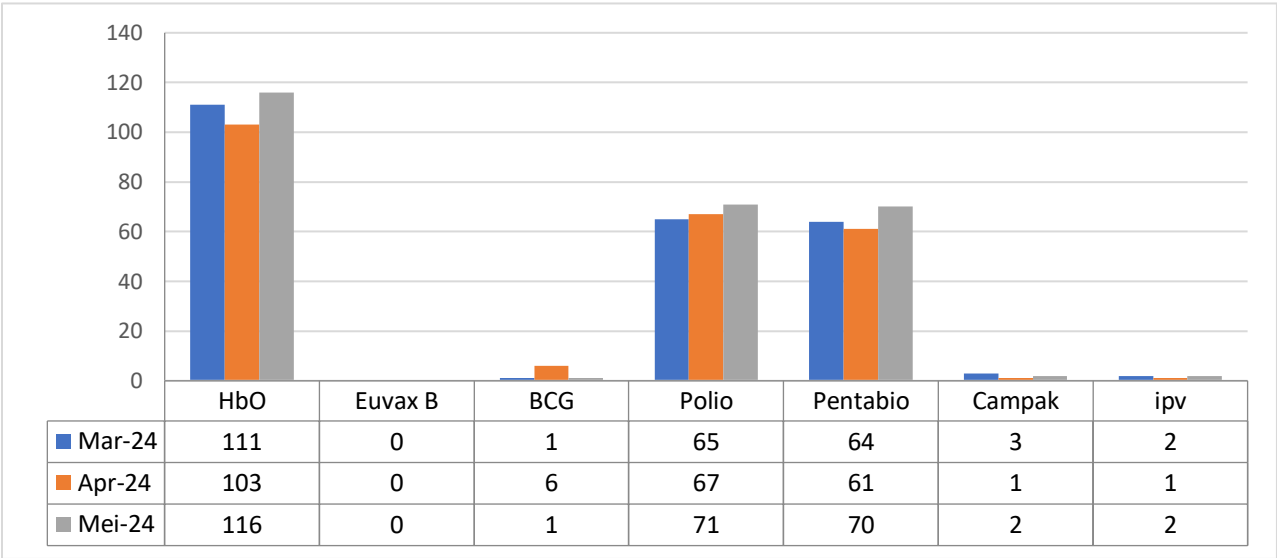
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		Bulan Maret 2024	Bulan April 2024	Bulan Mei 2024
1	HbO	111	103	116
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	1	6	1
3	Polio	65	67	71
4	Pentabio	64	61	70
5	Campak	3	1	2
6	IPV	2	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis:

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Mei 2024 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga memakai imunisasi HB.O unijek.
- 2. Imunisasi Hbo pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 116 bayi. Dan ini seiring dengan jumlah bayi baru lahir yang ada di RS
- 3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Mei sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Mei 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien.
- 5. Pada periode Mei 2024 terdapat 2 bayi yang melakukan Imunisasi Campak
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 71 bayi
- 7. Jumlah pasien yg imunisasi Pentabio pada bulan Mei 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 70 pasien

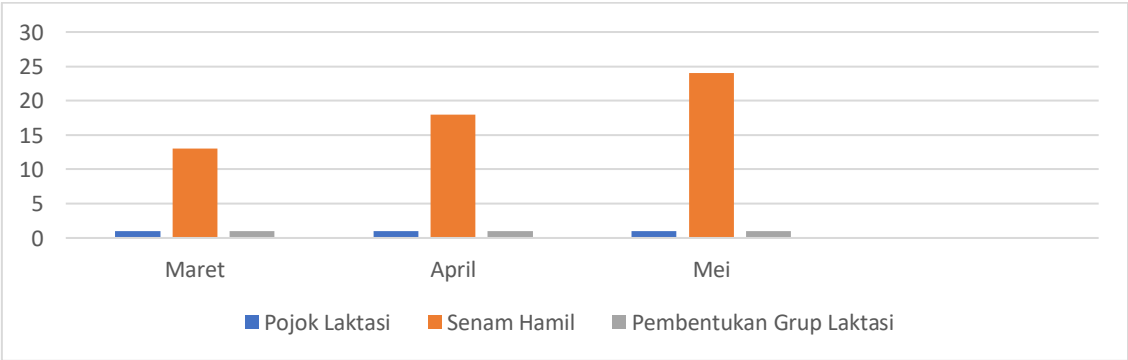
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
Ruang Pojok Laktasi	1	1	1
Senam Hamil	13	18	24
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2024



Analisis :

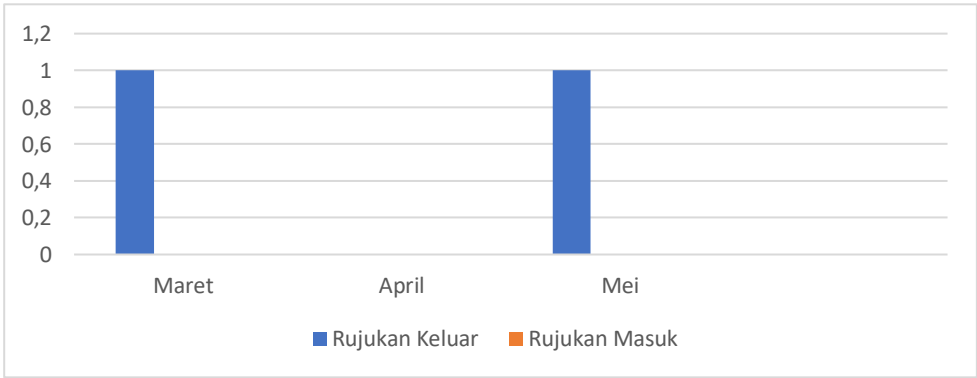
- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Peserta Senam Hamil pada bulan Mei mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 24 peserta dikarenakan terdapat penambahan jumlah matras sebagai media senam hamil sehingga lebih banyak ibu hamil yang mendaftar untuk mengikuti senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

RUJUKAN MASUK				
BULAN	NAMA PX	USIA	DIAGNOSA	ASAL RUJUKAN
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
BULAN	NAMA PX	USIA	DIAGNOSA	ASAL RUJUKAN
Maret	Hanif Ardani	2 Tahun	Stunting , Autism	RS Saiful Anwar
April	-	-	-	-
Mei	Zahirul Ihsan	7 Bulan	Pneumonia, Gizi Buruk, Down Syndrome, PJB	RSUD Sidoarjo



Analisis :

Terdapat 1 pasien dengan kondisi stunting yang dirujuk keluar yaitu ke RS Saiful Anwar dengan diagnose Stunting + Autism pada bulan Maret dan pada bulan Mei dirujuk ke RSUD Sidoarjo dengan diagnosa Pneumonia, Gizi Buruk, Down syndrome, dan PJB Chronic.

Rencana Tindak Lanjut:

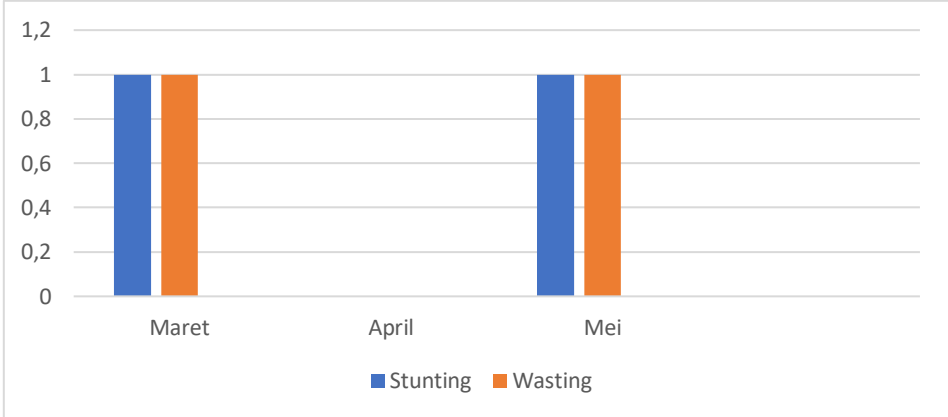
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8
Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	MARET 2024	APRIL 2024	MEI 2024
Jumlah Pasien Stunting	1	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :

Terdapat 1 pasien wasting pada bulan Maret dan Mei. Hal tersebut berkaitan dengan pola makan pasien yang terbilang kurang yaitu 2x sehari dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Pada bulan Maret terdapat 1 pasien stunting yang merupakan pasien yang sudah dalam pantauan puskesmas. Sehingga ahli gizi berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi puskesmas dalam pemberian terapi balita stunting dan wasting.

Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

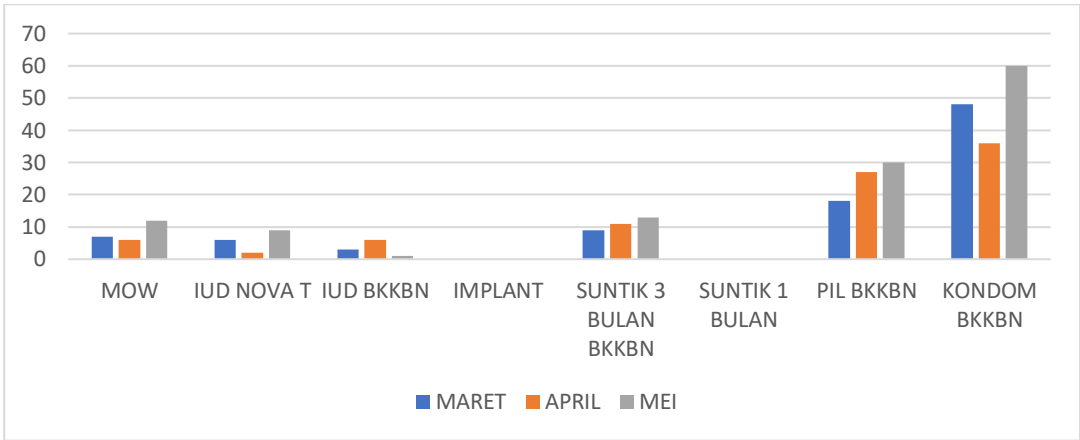
3.1.2.5
KBRS

3.1.2.6
Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	MOW	11	6	12
2	IUD Nova T	6	2	9
3	IUD BKKBN	5	6	1
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN BKKBN	11	11	13

6	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
7	PIL BKKBN	22	27	30
8	KONDOM BKKBN	48	36	60

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi

1. Peserta MOW pada bulan Maret (7) April (6) Mei (12)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Maret (6) menurun April (2)Mei meningkat(9)
3. Peserta IUD BKKBN, pada bulan Maret (3) meningkat April (6) Mei menurun (1)
4. Peserta KB suntik 3 bulan, pada bulan maret (9) meningkat April (11) Mei meningkat(13)
5. Peserta KB pil pada Maret (18)meningkat April (27) Mei meningkat (30)
6. Peserta KB Kondom pada bulan Maret (48) April (36) Mei meningkat (60)

Analisis

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

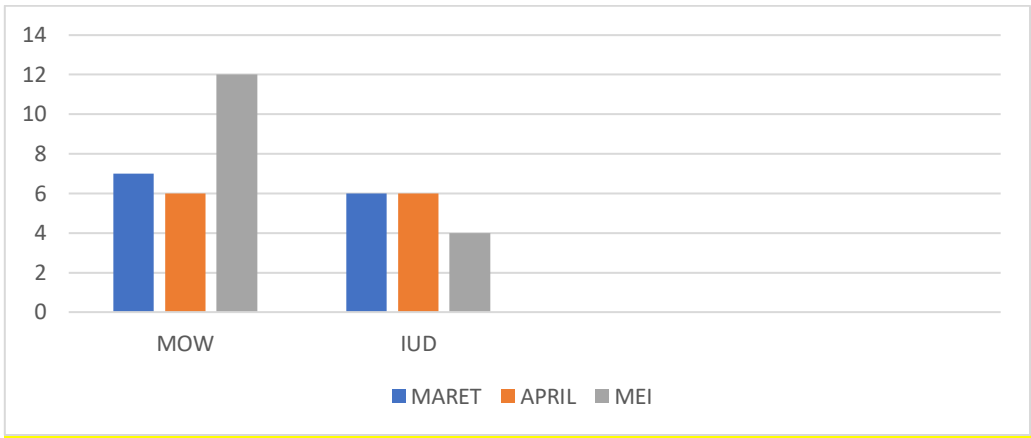
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

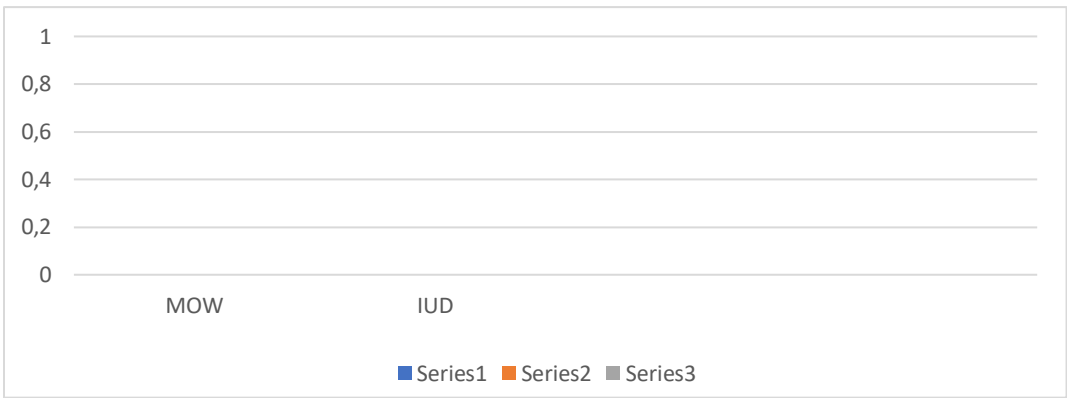
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	MOW	7	6	12
2	IUD	7	6	4

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2024	BULAN APRIL 2024	BULAN MEI 2024
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Maret-April-Mei meningkat
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Maret-April-Mei menetap

Analisis

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan II Tahun 2024

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Sukartiningsih	P/79	dr. Heri, Sp.PD	211502	Vomiting, GERD	27/03/2024	03/04/2024	8	Ceftiaxone	2	2x1	14	2	7
									Asam Pipemidat		2x0,4	1,6	0,8	2,5
2	Sukanan	L/66	dr. Anton, Sp. B	211534	Gangren	28/03/2024	01/04/2024	5	Ceftriaxone	1	3x1	12	2	6
3	Fitriani	P/28	dr. Heri, Sp. B	211607	Febris	30/03/2024	03/04/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	9	2	4,5
4	M Riza abdi	L/21	dr. Heri, Sp. B	211653	Volume Depletion	02/04/2024	06/04/2024	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
5	Eris Kurniawan	L/42	dr. Heri, Sp.Pd	211718	GERD, Hiponatremi	02/04/2024	06/04/2024	5	Ceftiaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Azitromycin po		1x0,5	2,5	0,3	8,3
6	Sucipto H	L/63	dr. Pradana, Sp. U	097743	Mums Orchitis	03/04/2024	06/04/2024	4	Gentamycin	2	2x0,04	0,24	0,24	1
7	Maulana B	L/35	dr. Zaki, Sp.B	211843	Appenciditis acute	04/05/2024	06/05/2024	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0.5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
8	Djumain	L/79	dr. Anton, Sp.B	211849	Necrotizing fasciitis	04/05/2024	06/05/2024	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	7	2	3.5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
9	Murtiningsih	P/65	dr. Heri, Sp.Pd	212014	Febris	07/04/2024	13/04/2024	7	Ceftriaxone	3	2x1	1	2	0.5
									Levofloxacin po		1x0,75	3	0,5	6
									Metronidazole po		3x0,5	5,5	2	2,75
10	Ariel Harijaman	L/53	dr. Yoga, Sp.JP	201144	ADHF	07/04/2024	13/04/2024	7	Ceftriaxone	2	2x1	12	2	6
									Levofloxacin po		1x0.5	1,5	0,5	3
11	Saropah	P/47	dr. Heri, Sp. Pd	209882	DM Hipoglikemi	09/04/2024	13/04/2024	5	Ceftriaxone	2	2x1	9	2	4,5
									Asam Pepimidat		2x0,4	3,2	0,8	4

12	Nita Firda M	P/40	dr. Heri, Sp. Pd	112517	Vomiting	09/04/2024	13/04/2024	5	Ceftriaxone Asam Pepimidat	2	2x1	9	2	4,5
											2x0,4	2,8	0,8	3,5
13	Sumarmi	P/51	dr. Anton, Sp.B	211764	Tumor mammae (S)	12/04/2024	14/04/2024	3	Ceftizoxime Ceftriaxone Cefadroxile	3	1x1	1	4	0,25
											1x1	1	2	0,5
											2x0,5	2	2	1
14	Ani Farida	P/46		212181	DM Hiperglikemi	13/04/2024	17/04/2024	5	Cefriaxone	1	2x1	9	2	4,5
15	Gisam	L/72	dr. Yunita, Sp.P	127242	Dyspnea	15/04/2024	19/04/2024	5	Levofloxacin inf	1	1x0,75	3	0,5	6
16	Lailatul K	P/21	dr. Humaira, Sp. OG	212404	Single Spontaneous Injury of unspecified body region	17/04/2024	19/04/2024	3	Cefazoline Cefadroxile	2	1x2	2	3	0,67
											2x0,5	2	2	1
17	Ika Elfiya	P/27	dr. Oka, Sp. OT	212462		18/04/2024	19/04/2024	2	Cefoperazone	1	2x1	4	4	1
18	Sunayah	P/68	dr. Zaki, Sp.B	099848	AF RVR, CAD	19/04/2024	23/04/2024	5	Ceftriaxone Metronidazole inj	2	2x1	8	2	4
											2x1	6	1,5	4
19	Darmini	P/56	dr.Heri, Sp.Pd	212623	Other Anemias	21/04/2024	24/04/2024	4	Ceftriaxone Asam Pipemidat	2	2x1	8	2	4
											2x0,4	1,2	0,8	1,5
20	Alfian Nur H	L/32	dr. Edi, Sp.U	209854	Scrotal Varices	28/04/2024	30/04/2024	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	RUSWANDI	L/59	DR. FARID, SP.S	212319	CVA INFARK	29/04/2024	06/05/2024	8	CEFTIAXONE	2	2X1	7	2	3.5
									LEVOFLOXACIN PO		1X0,5	1,5	0,5	3
2	SULAKSONO	L/48	DR. EDI, SP. U	212963	NEFROLITIASIS BILATERAL	02/05/2024	06/05/2024	5	CEFTIZOXIME	1	1X2	2	4	0,5
3	LASIAMAH	P/74	DR. IRA, SP.JP	097978	ATRIAL FIBRILLATION AND FLUTTER	03/05/2024	07/05/2024	5	CEFTIAXONE	2	2X1	4	2	2
									AZITROMYCIN		1X0,5	1	0,3	3,3
4	CHOTAMIN	L/56	DR. YUNITA, SP.P	207671	COPD	04/05/2024	07/05/2024	4	LEVOFLOXACIN INF	1	1X0,75	3	0,5	6
5	SUPAAT	L/68	DR. YUNITA, SP.P	213556	PNEUMONI SUSP TB	08/05/2024	11/05/2024	4	CEFTRIAZONE	3	2X1	8	2	4
									AZITROMYCIN PO		1X0,5	1,5	0,3	5
									LEVOFLOXACIN INF		1X0,5	1	0,5	2
6	SUKRI	L/93	DR. MIRYANTI, SP. JP	213625	DYSPNEA	09/05/2024	14/05/2024	6	LEVOFLOXACIN INF	2	1X0,5	1,5	0,5	2
									LEVOFLOXACIN PO		1X0.5	1,5	0,5	2
7	MUNYATUN	P/54	DR. ANDY, SP.P	140274	PNEUMONI, HT	12/05/2024	15/05/2024	4	CEFTRIAZONE	1	2X1	8	2	4
8	ESTER NINGMAWATI	P/58	DR. ANTON , SP.B	194608	NECROTIZING FACITIS DEXTRA, DM HIPERGLIMKEMI	13/05/2024	15/05/2024	3	CEFTRIAZONE	3	1X1	1	2	0.5
									CEFTRIAZONE		2X1	5	2	2.5
									METRONIDAZOLE PO					
9	RUSLANI	L/67	TUMOR SHOULDER	064773	TUMOR SHOULDER (S)	15/05/2024	17/05/2024	3	CEFOPERAZONE	2	1X2	2	4	0,5
									CEFTRIAZONE		2X1	5	2	2,5
10	RACHMAD RIYADI	L/47	DR. ANTON, SP.B	213876	GANGRENE AND NECROSIS OF LUNG	15/05/2024	17/05/2024	3	CEFTRIAZONE	2	3X1	8	2	4
									METRONIDAZOLE PO		3X0,25	1,75	2	0,875

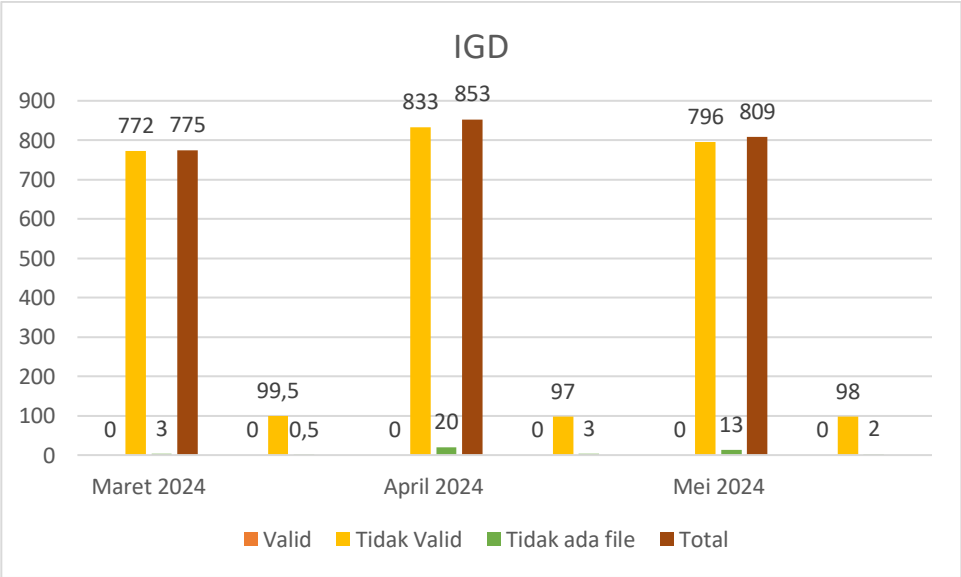
11	ACHMAD SOBIM	L/49	DR. OKA, SP.OT	213924	CRUSH INJURY	16/05/2024	17/05/2024	2	CEFOPERAZONE	1	2X1	4	4	1
12	ERNI KUSUMAWATI	P/50	DR. ANTON, SP.B	146928	GANGLION	19/01/2024	23/01/2024	5	CEFTIZOXIME	2	1X1	1	4	0,25
									CEFTRIAZONE		1X1	1	2	0,5
									CEFADROXILE		2X0,5	1,5	2	0,75
13	DIAN PUTRI AMALIA	P/27	DR. ZORA, SP. PD	177321	VOLUME DEPLETION	16/05/2024	18/05/2024	3	DOXYCYLINE	1	2X0,1	0,6	0,1	6
14	MISERI	L/60	DR. ANTON, SP.B	214064	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE OF TRUNK	19/05/2024	22/05/2024	4	CEFTRIAZONE	2	1X1	1	2	0.5
									CEFTRIAZONE		2X1	6	2	3
15	KARTIKA	P/29	DR. ARDHI, SP.PD	214161	GEA	20/05/2024	23/05/2024	4	CEFTRIAZONE	2	2X1	8	2	4
									CIPROFLOXACIN		2X0,5	2	1	2
16	WIDARSONO	L/48	DR. HERI , SP.PD	214179	ACUTE NASOPHARYNGITIS	20/05/2024	23/05/2024	3	CEFTRIAZONE	3	2X1	4	2	0.5
									CEFADROXILE		3X0,5	2,5	2	1.25
									LEVOFLOXACIN PO		1X0,75	1,5	0,5	3
17	MUJIONO	L/68	DR. MIRYANTI, SP.JP	190448	JAUNDICE	20/05/2024	23/05/2024	4	CEFTRIAZONE	2	2X1	6	2	3
									ASAM PIPEMIDAT		2X0,4	1,6	0,8	2
18	KASIYANTO	L/64	DR. PRADANA, SP.U	113927	BPH	21/05/2024	23/05/2024	3	CEFTIZOXIME	1	1X2	2	4	0,5
20	SENJA AYU	P/26	DR. HUMAIRA, SP. OG	182583	PRM	22/05/2024	24/05/2024	3	CEFAZOLINE	2	1X2	2	3	0,67
									CEFADROXILE		2X0,5	2	2	1
19	ALIFAH	P/40	DR.HERI, SP.PD	200272	DM TYPE 2	22/05/2024	27/05/2024	6	CEFTRIAZONE	2	2X1	7	2	3.5
									CEFIXIME		2X0,1	0,5	0,4	1,25

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

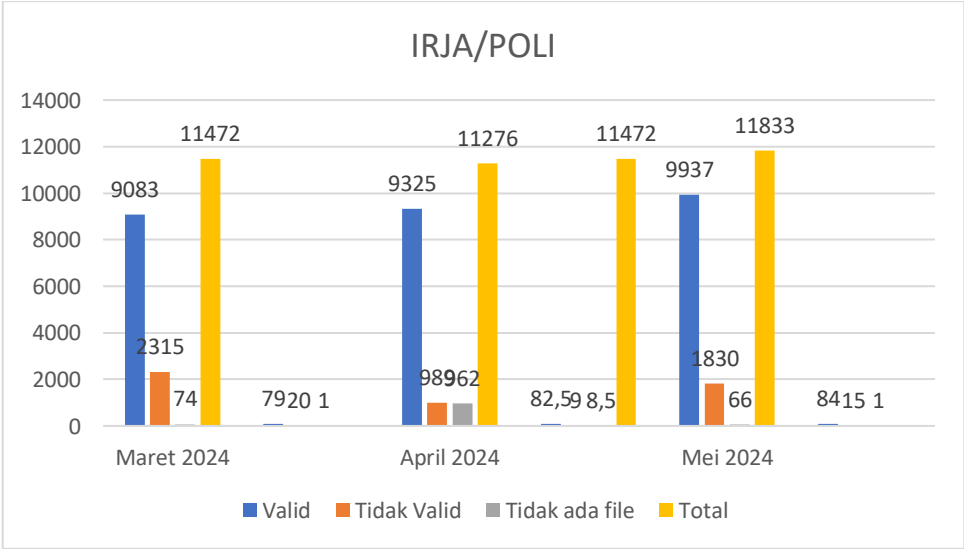
3.6.6.1 Tabel Validasi Data E-RM Bulan Maret - Mei 2024

NO	UNIT	KUALIFIKASI	BULAN					
			MARET 2024		APRIL 2024		MEI 2024	
			JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
1	IGD	Valid	0	0	0	0	0	0
		Tidak Valid	772	99,5	833	97	796	98
		Tidak ada file	3	0,5	20	3	13	2
Total			775		853		809	
2	IRJA/POLI	Valid	9083	79	9325	82,5	9937	84
		Tidak Valid	2315	20	989	9	1830	15
		Tidak ada file	74	1	962	8,5	66	1
Total			11472		11276	11472	11833	

3.6.6.2 Validasi data E-RM di IGD Bulan Maret - Mei 2024



3.6.6.3 Validasi data E-RM di IRJA/Poli Bulan Maret - Mei 2024



Analisis :

- 1. Masih ditemukan pengisian form erm yang tidak lengkap.
- 2. Masih ditemukan form rawat jalan dan rekam medis yang belum sinkron.
- 3. Keterangan TF (tidak ada file), dikarenakan :
 - a. Terdapat masalah pada system programmer.
- 4. Yang tidak masuk ERM :
 - a. Pasien UMUM (MCU)
 - b. Fisioterapi
 - c. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), salah satunya tindakan tindik pada bayi baru lahir.

Masalah :

- 1. Riwayat alergi kosong
- 2. Riwayat penyakit kosong
- 3. Keperawatan kosong
- 4. Tolak ukur kosong
- 5. Keadaan umum kosong
- 6. Skrining nyeri kosong
- 7. Pengkajian nyeri kosong
- 8. Resiko dekubitus jika dia tidak ada resiko harusnya “tidak” tetapi kosong

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendata temuan masalah penggunaan ERM dan disampaikan ke Programmer untuk dilakukan tindaklanjut.
Berikut link permasalahan
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JcmJm9ucywizoiEdYqeEaCRxvhVWeLLC7eKe8NQ_D_k/edit#gid=1732600455

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

3.7.6 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	1 Staf IKO yang sakit dalam bulan mei 2024	P	Mengkondisikan jadwal yang jika ada staf yang sakit
		D	Melakukan monitoring jika ada staf yang sakit
		S	Pengkondisian jadwal sudah dibuatkan secara maksimal
		A	Sosialisasi kembali ke staf jika ada yang sakit harus memberitahukan ke bagian karu dan SDM
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Kurangnya komunikasi antara staf IKO dan TTK dalam peeresepan manual	P	Memastikan resep manual selalu di tulis dan diberikan ke ttk
		D	Mengingatkan karu dan konfirmasi ke staf perawat pelaksana untuk penulisan resep manual
		S	TTK harus selalu komunikasi dengan kepala ruangan IKO untuk resep resep manual
		A	Melakukan diskusi dengan TTK untuk alur resep manual

3.7.7 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Pengambilan BMHP ke farmasi masih belum tepat waktu	P	Membuat jadwal pengambilan BMHP ke farmasi sesuai jam
		D	Mengingatkan pj barang untuk selalu mengambil barang di farmasi
		S	Staf perawat/ pj barang selalu lupa mengambil barang di farmasi
		A	Meningkatkan komunikasi dengan pj BMHP dan selalu di follo up
2	Dokter IGD kewalahan karena jumlah pasien sering kali membludak	P	Melakukan Analisa beban kerja dokter IGD
		D	Melakukan open recruitment dokter umum, saat ini menunggu proses SIP selesai
		S	Dokter IGD akan tetap kewalahan jika hanya bertugas sendiri dalam 1 shift
		A	Membuat shift middle untuk dokter IGD sehingga dokter tersebut dapat membantu dalam jam crowded
B. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Dokter IGD beberapa kali melakukan IKP	P	Melakukan telusur alasan dokter IGD terlibat IKP
		D	Kordinasi dengan komite mutu untuk melakukan rapat IKP
		S	Beberapa alasan terjadinya IKP oleh dokter umum adalah karena dokter umum tidak teliti akibat tingginya jumlah pasien, selain itu karena kurangnya refreshing ilmu
		A	Melakukan diklat internal tentang kegawat daruratan untuk dokter IGD

3.7.8 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Rekam medis tidak lengkap	P	Meningkatkan kelengkapan rekam medis
		D	Melakukan supervisi
		S	Perawat tidak paham mengenai poin poin yang wajib dilengkapi, DPJP kurang patuh dalam mengisi rekam medis
		A	Membuat pelatihan pengisian dan kelengkapan rekam medis
2	Sistem input tarif di SIMRS sering bermasalah karena ada inputan tarif yang otomatis tetapi tidak sesuai sehingga mempengaruhi kontrol biaya dan membuat DPJP komplain	P	Meningkatkan kendali mutu kendali biaya
		D	Menyampaikan sisa plafon dari kontrol biaya di SIMRS pada DPJP
		S	Terdapat inputan yang tidak sesuai dan muncul secara otomatis sehingga membuat kontrol biaya menjadi rancu
		A	Memperbaiki system penginputan di SIMRS agar tidak ada kekeliruan dengan cara koordinasi dengan programmer
3	Perawat rawat inap lupa menginput jenis tindakan penunjang dan labu darah	P	Meningkatkan ketelitian perawat jaga untuk penginputan tindakan
		D	Selalu komunikasi dengan shif selanjutnya untuk pengecekan secara berkala mulai shif pagi-malam
		S	Terdapat inputan yang tidak di input ada tindakan usg dan labu darah
		A	Memperbaiki pengecekan penginputan setiap saat

3.7.9 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ruangan audiometri tidak kedap suara sehingga pemeriksaan audiometri tidak maksimal	P	Merencanakan / pengecekan ruangan audiometri yang kurang kedap
		D	Tim IPSRS segera menindaklanjuti ruangan audiometri
		S	Mengevaluasi ruangan yang ada di poli kekurangannya
		A	Kepala ruangan harus segera koordinasi dengan tim iprs untuk segera memperbaiki ruangan audiometri
2	Pengajuan alat dan pelayanan BPJS spesialis KGA belum selesai	P	Menyegerakan selesainya proses pengajuan pelayanan KGA
		D	Koordinasi dengan unit terkait
		S	Alat belum datang
		A	Follow up berkala, sementara memakan alat dari poli gigi 1
3	Kendala ERM rawat jalan bagian rehab medik dan poli poli lainnya	P	Merencanakan / pengecekan ERM rawat jalan rehab medik dengan riview rekam medis
		D	Melakukan kolaborasi dengan tim programer untuk perbaikan ERM
		S	Banyaknya kasus yang tidak sesuai dengan review rekam medis
		A	Kepala ruangan harus berkoordinasi dengan programer dan rekam medis

3.7.10 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Selisih stok pada FS IKO	P	Memperbaiki system keluar masuknya barang FS di IKO
		D	Koordinasi dengan Programmer terkait sistem IKO untuk meminimalisir terjadinya selisih dan membuat kesepakatan alur dengan petugas IKO
		S	1. Menempatkan TTK yang standby di IKO. 2. Membuat SPO Alur Pelayanan Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan di IKO. 3. Monitoring, evaluasi dan supervise dari Karu IKO dan Ka IFRS untuk pengadaan obat dan BMHP di IKO
		A	Melakukan pemantauan dan pencatatan keluar masuknya barang di IKO. Melakukan penyesuaian FS setiap hari.
2	Selisih stok di Depo Farmasi	P	Mencari akar masalah penyebab selisih di Depo Farmasi
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk cek mutase barang dan perbaikan system.
		S	1. Melakukan cek riwayat mutase barang dengan selisih terbanyak.barang dengan selisih terbanyak. 2. Menghapus master barang yang inaktif setelah jumlah stok 0.
		A	1. Melakukan monitoring stok setiap harinya. 2. Menjalankan kartu stok. 3. Melaporkan jika ditemukan master barang inaktif

			yang jumlah stok fisik masih ada untuk disesuaikan dan dibuatkan BA.
3	Penataan rak obat tidak sesuai dengan standar PERMENKES	P	Menerapkan penataan obat di Gudang Farmasi sesuai standar permenkes
		D	Koordinasi dengan Ka IFRS dan Kepala Gudang serta Koordinator CS untuk merapikan sesuai standar
		S	Monitoring, evaluasi dan supervise dari Ka IFRS dan Kabid
		A	1. Melakukan supervise setiap saat. 2. Melakukan penyimpanan obat dengan system FEFO dan FIFO. 3. Melakukan pencatatan di kartu stok yang tertera di masing-masing obat. 4. Memperbaiki penataan buffer dan rak obat.
4	Terjadi kekosongan konsinyasi implan sehingga pelayanan tidak maksimal	P	Perbaiki alur pelayanan konsinyasi implan.
		D	Koordinasi dengan IKO, Gudang Farmasi dan Pengadaan PT untuk memperbaiki alur.
		S	Mengevaluasi kekosongan konsinyasi implan setelah alur diperbaiki.
		A	1. Pengumpulan LPO dilakukan setiap hari dari perawat IKO ke Gudang farmasi. 2. Pengecekan kesesuaian implan yang tertulis di LPO dengan inputan tagihan dilakukan setiap hari oleh petugas Gudang farmasi. 3. Pemesanan implan ke distributor dilakukan setiap hari. 4. Koordinasi dengan pengadaan untuk menambah jumlah konsinyasi.
5	Master barang yang nonaktif muncul di peresepan dokter namun tidak muncul di nota penjualan farmasi	P	Menyesuaikan master barang terupdate.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk penghapusan master non aktif.
		S	Pada saat klik tampilan resep ada obat Amlodipin tab 5 mg – tempo, candesartan tab 16 mg – ogb dexta, simvastatin tab 10 mg - hexpharm, kemudian pada saat proses penjualan yang muncul hanya candesartan tab 16 mg – ogb dexta. Jadi farmasi konfirmasi dokter dulu, trus ternyata memang peresepan sesuai resep. Jadi farmasi input Amlodipin tab 5 mg secara manual dari farmasi. Setelah di telusur master F00069 Amlodipin tab 5 mg – tempo dan F01222 simvastatin tab 10 mg - hexpharm sudah nonaktif namun masih tetap diinput oleh dokter.
		A	Programmer memperbaiki sistem untuk master yang non aktif tidak muncul saat dokter meresepkan
6	Retur penjualan obat yang tidak diambil pasien, di retur ke Gudang farmasi di fitur penerimaan hibah lainnya namun resep kronis tidak dihapus di apotek online, dan tidak dihapus di penjualan farmasi	P	Membuat kebijakan retur penjualan obat kronis yang tidak diambil pasien.
		D	Koordinasi dengan Kabid, Keuangan, Verifikator dan manajemen PT DPM kesepakatan alur retur penjualan obat yang tidak diambil pasien.
		S	- Selama ini di input penerimaan farmasi lain namun hanya menambah stok Gudang retur tapi tidak menghapus data penjualan. Sehingga ketika retur diganti obat selesai maka data tidak akan muncul di tim verif (Berkas obat kronis).

			- Tidak ada laporan tarikan data pasien khusus BPJS kesehatan karena berkaitan dengan data pasien yang akan di hapus datanya di apotek online.
		A	Obat belum direturn ke apotek online beserta racikannya. Hasil keputusan PT racikan di anggap kerugian maka racikan tetap di retur tapi dihapus dari penjualan.

3.2.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Terjadi keterlambatan hasil pemeriksaan PA	P	Memperbaiki alur penerimaan hasil PA rujukan
		D	Koordinasi dengan Sp.PA dan analis untuk kesepakatan pengiriman hasil pemeriksaan
		S	Analisis mempunyai tanggungjawab terkait hasil pemeriksaan laboratorium rujukan karena berkaitan dengan klaim
		A	1. Menghubungi dr Berlian, Sp.PA untuk kesepakatan hasil pemeriksaan maksimal 4x24 jam sesuai SPO 2. Analisis melakukan pencatatan dan follow up hasil sebelum batas waktu maksimal
2	Kurangpahaminya petugas melakukan analisa serah terima hasil pemeriksaan laboratorium	P	Memperbaiki SPO serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien
		D	Koordinasi dengan Karu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan/keterlambatan pemberian hasil pemeriksaan dan membuat kesepakatan alur serah terima hasil pemeriksaan laboratorium dengan pasien
		S	1. Memperbaiki alur setelah analisis melakukan sampling, surat pengantar diberikan petugas input dan diberi keterangan “pasien rawat jalan, hasil ditunggu”.
		A	1. Petugas input wajib segera menyerahkan hasil kepada pasien setelah selesai input. 2. Mendokumentasikan jika petugas sudah memanggil nama pasien tetapi tidak segera diambil.
3	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikan dikarenakan belum bridging dengan SIMRS
		A	Follow up berkala ke Programmer.

3.2.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaksesuaian pemahaman pengisian DRM antar perekam medis dengan perawat	P	Melakukan diskusi dengan Kepala MRMIK dan Kabid Keperawatan untuk menyelaraskan pemahaman pengisian DRM antar perekam medis dengan perawat
		D	Koordinasi dengan Karu RM untuk membuat TOR “Diklat analisis kelengkapan pengisian DRM”

		S	Mengumpulkan data ketidaksesuaian pengisian DRM dan disampaikan saat diskusi dengan perawat, dihadiri oleh Kepala MRMIK dan Kabid Keperawatan.
		A	Melakukan “Diklat analisis kelengkapan pengisian DRM”.
2	Ketidaksesuaian antara fitur e-rm poli dengan rekam medis	P	Memperbaiki fitur e-rm poli dan rekam medis.
		D	Koordinasi dengan Programmer untuk meminimalisir data yang tidak valid akibat ketidaksesuaian fitur.
		S	Mencatat temuan permasalahan e-rm dan dilaporkan kepada Programmer.
		A	Melakukan koordinasi dengan Programmer setiap ditemuka masalah e-rm.

3.2.8 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Alur MCU tidak disetujui oleh DPJP	P	Memperbaiki Alur Pelayanan MCU di Radiologi
		D	Koordinasi dengan DPJP untuk meminimalisir terjadinya tidak dilakukan pemeriksaan yang membutuhkan Spesialis Radiologi.
		S	Berdiskusi dengan Humas Marketing dan Karu Radiologi untuk membuat kesepakatan alur MCU.
		A	Humas Marketing menginformasikan kepada Karu Radiologi H-1 jika akan ada MCU, kesepakatan dengan DPJP : 1. Jika peserta sedikit maka sesuai jadwal DPJP. 2. Jika peserta banyak dan bisa datang dalam 1 waktu maka dijadwalkan diluar jadwal dinas.
2.	Terjadi pembacaan ulang hasil pemeriksaan radiologi oleh DPJP	P	Memperbaiki alur pelayanan pemeriksaan radiologi dan meminimalisir kejadian pembacaan ulang hasil pemeriksaan.
		D	Mencari penyebab dilakukan pembacaan ulang hasil pemeriksaan radiologi. Menentukan alur yang tepat dan disosialisasikan kepada tenaga medis.
		S	Dari kejadian tersebut, hal ini disebabkan karena beberapa hal : 1. Surat permintaan pemeriksaan yang tidak lengkap 2. Dokter Radiologi kurang teliti dalam membaca hasil.
		A	Dilakukan review hasil pembacaan dengan menyertakan diagnosa secara lengkap.
3	Terjadi permintaan pemeriksaan penunjang ke RS luar tidak terinput di SIMRS.	P	Memperbaiki alur pelayanan pemeriksaa penunjang ke RS luar.
		D	Koordinasi dengan Kepala Keuangan, Kabid Keperawatan dan Penunjang untuk membuat alur yang komprehensif.
		S	RS mengalami kerugian karena tidak ikut ditagihan pasien, kerugian dibebankan ke petugas.
		A	Menjalankan sesuai SOP. Mencetak pengantar dari petugas radiologi untuk dibawa perawat ke RS rujukan.

4.9 Profil SDM

3.9.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	0	1	0
2	Kabid Pelayanan medik	Dokter Umum	1	1	0	1	0
3	Kabid Penunjang Medik	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi	1	1	0	1	0
5	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
6	Dokter IGD	Dokter Umum	7	7	0	7	0
7	Dokter Ruangan	Dokter Umum	1	1	0	1	0
8	Farmasi	SMK	41	5	0	5	0
		D3 Farmasi		19	4	15	1
		S1 Apoteker		12	0	12	0
		S1 Farmasi		3	0	3	0
		S1 Analisis Farmasi dan Makanan		1	0	1	0
		S1 Ekonomi		1	0	1	0
9	Asuransi Center	SMA	11	1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		D3 Kesehatan		3	0	3	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 RMIK		5	0	5	0
10	CSSD	SMK	4	2	1	1	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Farmasi		1	0	1	0
11	Fisioterapi	D3 Fisioterapi	4	2	2	0	0
		D3 Kesehatan		1	0	1	0
		S1 Terapi Wicara		1	0	1	0
12	Gizi	SMP	16	2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		2	0	2	0
		D3 Gizi		2	2	0	0
		D4 Gizi		2	0	2	0
		S1 Gizi		2	1	1	0
13	Humas & Marketing	S1 Kesehatan Masyarakat	2	1	0	1	0
		Profesi Ners		1	0	0	0
14	ICU dan HCU	D3 Keperawatan	12	5	1	4	0
		Profesi Ners		6	4	2	0
		D3 Kebidanan		1	0	1	0
15	IGD	D3 Kebidanan	28	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		5	0	5	0
		D3 Keperawatan		10	0	10	0
		D4 Keperawatan		5	0	5	0
		Profesi Ners		7	1	6	0
16	IKO	D3 Kebidanan	12	1	1	0	0

		D3 Keperawatan		3	1	2	0
		Profesi Ners		8	3	5	0
17	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
18	IPSRS	D3 TEM	7	1	0	1	0
		SKM		1	0	1	0
		D3 Teknik		1	0	1	0
		S1 Teknik		1	0	1	0
		SMA		3	1	2	0
19	IRJA	D3 Kebidanan	27	5	3	2	0
		D3 Keperawatan		13	6	7	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Ners		8	4	4	0
20	IRNA 2C	D3 Keperawatan	7	2	0	2	0
		Profesi Ners		5	1	4	0
21	IRNA 6A & 7A & 8A	D3 Keperawatan	24	12	0	12	0
		D4 Keperawatan		4	0	4	0
		Profesi Ners		8	0	8	0
22	IRNA 3C Anak	D3 Keperawatan	14	8	0	8	0
		D4 Keperawatan		1	0	1	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
23	IRNA 3A & 4A	D3 Keperawatan	19	14	0	14	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
24	IRNA 5C	D3 Keperawatan	10	5	0	5	0
		Profesi Ners		5	0	5	0
25	Maternitas	D3 Kebidanan	11	7	7	1	1
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		Profesi Bidan		2	0	2	0
26	Neonatologi	D3 Keperawatan	9	5	0	5	0
		Profesi Ners		4	3	1	0
27	Keuangan dan Akuntansi	SMA	10	4	1	3	0
		S1		5	3	2	0
		D3 Keuangan		1	0	1	
28	Laboratorium	D3 Kesehatan	10	4	0	4	0
		D3 Analisis Kesehatan		4	1	3	0
		D4 Analisis Kesehatan		2	0	2	0
29	Laundry	SMA	5	5	3	2	0
30	Rekam Medis	D3 RMIK	10	9	3	6	0
		D4 RMIK		1	0	1	0
32	Pendaftaran	SMA	15	6	1	5	0
		D3 RMIK		4	2	2	0
		D3 Kesehatan		2	0	2	0
		S1 Sosial		1	0	1	0
		D4 Manajemen		2	0	2	0
33	PIPP	Ners	5	1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	0	1	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	0	7	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	2	0	2	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	0	1	0

38	SIMRS & IT	S1 Komunikasi	3	3	0	3	0
39	Umum Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMP	44	3	1	2	0
		SMA		41	5	36	0
41	Security	SMA	12	12	6	6	0
42	Driver	SMA	5	5	1	4	0
43	Gudang Umum	SMA	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Syaraf		4	4	0	4	0
45	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah		3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Paru		3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		3	3	0	3	1
48	Dokter Spesialis Anestesi		2	2	0	2	0
49	Dokter Spesialis Bedah		4	4	0	4	0
50	Dokter Spesialis Bedah Plastik		1	1	0	1	0
51	Dokter Spesialis Orthopedi		3	3		3	0
52	Dokter Spesialis Patologi Anatomi		1	1	0	1	0
53	Dokter Spesialis Patologi Klinis		1	1	0	1	0
54	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi		1	1	0	1	0
55	Dokter Spesialis Mata		3	3	0	3	0
56	Dokter Spesialis Urologi		2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa		2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Obstetry Ginekology		4	4	0	4	0
59	Dokter Gigi Spesialis Orthodontist		1	1	0	1	0
60	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin		2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis THT		2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Gigi Periodonti		1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Radiologi		2	2	0	2	0
TOTAL			451				

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikarenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalam pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Mei 2024 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada bulan Mei 2024, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 09 Juni 2024
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	INSTANSI	NAMA PKS	NOMOR RS	NOMOR INSTANSI	MASA BERLAKU		KETERANGAN
1	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Pelayanan Kesehatan & pelayanan obat	028.2/DPM/E-PKS/DIR/II/2023	0.32/AJII/KOP-SBY/PKS/0123	30/01/2023	31/01/2023	BERLAKU
2	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017	12 Desember 2017	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
3	PT. Global Asistensi Manajemen Indonesia (GAMI)	Perjanjian Layanan Kesehatan Rawat Jalan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019	26 AGUST 2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
4	PT. Fullerton Health Indonesia	Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019	26 Agustus 2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
5	PT PRUDENTIAL LIFE INSURANCE	Surat Kesepakatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		3143/PMN-PA/IV/2020	13/04/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
6	PT. Java Smartindo	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C	21/08/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
7	PT PLN Insurance	Asuransi Pelayanan Kesehatan	612/RSPHS/E-PKS/DIR/X/2019	300/PKS/TKI/X/2019	30/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
8	Avrist Assurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	951/PKS/PROV/IPOP/AVR-1494/VII/2023		24/08/2023	24/08/2025	BERLAKU
9	BPM Inung Indah sari	Rujukan Asuhan	004.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2022	-	10/1/2022	1/10/2025	BERLAKU

		Pasien					
10	KLINIK TIRTO HUSADA	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			3/3/2018	3/2/2024	BERLAKU
11	Klinik Dokter 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang			16/3/2020	3/16/2024	BERLAKU
12	Klinik Rawat Inap Muslimat Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023	15/04/2023	15/04/2026	BERLAKU
13	Klinik Rawat Inap Wijaya Husafa	Rujukan Asuhan Pasien	001/PKS/15/4/2023	113.2/DPM/E-PKS/DIR/V/2023	15/04/2023	15/04/2026	BERLAKU
14	Klinik Endisa Husada	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	148.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH	21/07/2023	21/07/2026	BERLAKU
15	PT. JAYA OBAYASHI	Pelayanan Kesehatan	360/DPM/I-PKS/VIII/2020		1/7/2020	1/7/2025	BERLAKU
16	PT. PANCAMAS ELITE	Pelayanan Kesehatan	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020		1/7/2020	7/1/2025	BERLAKU
17	PT. TIRTA INVESTAMA	Pelayanan Kesehatan Karyawan & Keluarga			31/08/2020	31/08/2025	BERLAKU
18	PT HM Sampoerna Tbk	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	-	55/Perj/HMS/IX/2014	1 Juni 2014	perpanjang otomatis	BERLAKU
19	PT Adonai Manajemen Kesehatan	Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Medisak Chek Up		055/PKS-PF/AMK/VIII/2019	26/08/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
20	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Perjanjian Pelayanan Kesehatan			30/03/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU

21	PT. Nestle Indonesia Kejayan Factory	Pelayanan Kesehatan			1/4/2013	perpanjang otomatis	BERLAKU
22	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	Kerjasama dalam proses akreditasi rumah sakit			22/04/2022	22/04/2026	BERLAKU
23	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang	Rujukan Asuhan Pasien	1562.1/e-pks/dir/xi/2022	116/302/2019	1/11/2022	1/11/2024	BERLAKU
24	RS SITI MIRIAM LAWANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	151.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	810/HMS/RSSM/X/2022	4/10/2022	3/7/2024	BERLAKU
25	RS Prima Husada Sukorejo	Rujukan Asuhan Pasien	213/E-PKS/DIR/III/2019	126/RSPHS/E-PKS/III 2019	21/02/2022	2/21/2025	BERLAKU
26	RS PANTI NIRMALA	Kerjasama Pelayanan Rujukan	152.44/DPM/E-PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022	7/10/2022	6/10/2025	BERLAKU
27	RS Dr. SYAIFUL ANWAR (RSSA)	Rujukan Pekayanan Penunjang	1562.2/E-PKS/DIR/XI/2022	116//102.7/2022	1/11/2022	1/11/2024	BERLAKU
28	RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan	220.1/DPM/E-PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023	30/10/2021	30/10/2026	BERLAKU
29	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi peserta BPJS	1571/E-PKS/DIR/XII/2022	PER/60/102022	1/1/2023	31/12/2024	BERLAKU

		Ketenagakerjaan					
30	PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk (Asuransi MAG)	Fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2	28/01/2020	27/01/2024	BERLAKU
31	PT. Lippo General Insurance	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	267/RSPHS/E- PKS/DOR/VI/2019	1502/LI-HOSPT/VI/2019	18/09/2019	18/09/2024	BERLAKU
32	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan	912.1/E- PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022	4/7/2022	4/7/2027	BERLAKU
33	PT AIA FINANCIAL	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	639/AIA-DPM/XI/2020	4/11/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
34	PT. Medlinx Asia Teknologi (Medlinx)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	150/ PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016		28/11/2016	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
35	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan	PKS.031/GHASKES/157- 1/2020	053/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2020	28/08/2020	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
36	PT. Asuransi AA Internasional	Pelayanan Kesehatan	-	AAII/RS/E-384/PKS/Feb/2015	19/09/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
37	PT. SUPRIMA MITRA ADIHUSADA	Perjanjian Kerja sama Pelayanan Kesehatan		640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019	26/08/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
38	PT. EQUITY LIFE IND-	Perjanjian Pelayanan		091/ELI/LGL/X/19	14/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU

	CORPORATE	Kesehatan					
39	PT. Axa Services Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	067/AGR-Leg/ASI/VII/2013	15 Agustus 2013	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
40	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Msig	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	-	063/PKS - AJSMSIG-Rs / IX/ 2012	10/9/2012	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
41	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019	4/9/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
42	PT. Hanwha Life Insurance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Layanan Kesehatan	-	0088/HLI-GH/ PKS-RS/03-2015	16 Maret 2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
43	PT. EQUITY LIFE IND-CASSLES	Perjanjian Pelayanan Kesehatan		090/ELI/LGL/X/19	14/10/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
44	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	490/RSPH/I- IKS/DIR/XI/2016	930.01/UM/ARI-RS/XI2016	7/9/2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
45	PT. Asuransi Adira Dinamika	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	PH/E-IKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013	24 Oktober 2013	perpanjang otomatis	BERLAKU
46	PT. Prima Sarana Jasa	Pelayanan Kesehatan	735/E-PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018	17 September 2018	perpanjang otomatis	BERLAKU
47	PT. BNI Life Insurance	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716	25/07/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
48	Administrasi Medika (Admedika)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	025/RSPH/E- PKS/DIR/IV/2015	141/PKS/ADMEDIKA/IV/2015	28-Apr-15	perpanjang otomatis	BERLAKU
49	Asuransi Jiwa Generali	Perjanjian Pelayanan	070/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	109/GI/OPS/Prov-SK/IX/2019	10/10/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU

		Kesehatan					
50	PT. Aplikanusa Lintasarta (Owlexa Healthcare)	Nota Kesepakatan Layanan Pemeriksaan Kesehatan	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MoU/00300/2015	25/02/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
51	PT. Asuransi Takaful Keluarga	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/II/2017	02 Januari 2017	perpanjang otomatis	BERLAKU
52	PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	Perjanjian Pelayanan Kesehatan Peserta Individu	017/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	045-02/EB-CONT/2020	2 MARET 2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
53	PT. AJ CENTRAL ASIA RAYA (CAR)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	795/E-ADD/DIR/XI/2019	DIR/PKS-ADD/RS/154/XI/2019	29/11/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
54	PT. Pan Pacific Insurance	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020	31/08/2020	perpanjang otomatis	BERLAKU
55	PT. Jasindo Health Care	Pelayanan Perawatan dan Pengobatan	-	-	1/4/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
56	PT. International Services Pacific Cross	Asuransi Pelayanan Kesehatan	150/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022	3/10/2022	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
57	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan	103.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	358/KBM-DPM/PKS/VI/2023	26/06/2023	25/06/2026	BERLAKU
58	PT. Jasa Raharja (Perseroan Perwakilan Malang) (ADENDUM)	Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang			7/2/2023	04/072027	BERLAKU

		Angkitan Umum dan Lalu Lintas Jalan					
59	BPM Silvian Wulandari	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	031/DPM/E- PKS/DIR/III/2022		3/10/2021	3/10/2024	BERLAKU
60	BPM Suma'iyah	Rujukan Pelayanan Kesehatan	686.1/E-PKS/DIR/VI/2023		2/5/2023	2/5/2026	BERLAKU
61	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KB IUD, Umplant, MOW dan MOP	630/E-PKS/DOR/IV/2023	440/146/35.07.120/2023	17/01/2023	17/01/2024	BERLAKU
62	BKKBN	pelayanan keluarga berencana iud dan implant	630/E-PKS/DOR/IV/2023	440/146/35.07.120/2023	17/01/2023	17/01/2024	BERLAKU
63	Klinik Mutiara Sehat	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	200.11/DPM/I- PKS/DIR/I/2022		5/1/2022	5/1/2025	BERLAKU
64	Klinik BLKI Singosari	Rujukan Asuhan Pasien	108.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	150/0187B00/IV/23	24/04/2023	27/04/2026	BERLAKU
65	Klinik Husada Asih YPAC	Kerja sama Penunjang			11-Sep-12	Tanpa Batas Waktu	BERLAKU
66	Klinik Brawijaya Lawang	Rujukan Asuhan Pasien	144.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/115/VII/2023	3/7/2023	3/7/2026	BERLAKU
67	Klinik Garuda	Pelayanan Kesehatan	131.2/DPM/E- PKS/DIR/V/2023	B/25/VI/2023	31/05/2023	31/05/2023	BERLAKU
68	Klinik Idamamuk	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	005/VI/2021	16/06/2021	16/06/2024	BERLAKU

69	Klinik 24 Jam	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2022	138/MOU/VIII/CSH.2022	2/8/2022	2/8/2025	BERLAKU
70	Laboratorium Panglima Sudirman	Pelayanan Rujukan Laboratorium	135.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	Q.0150/LKPS.VI/25.2023	5/6/2023	5/6/2026	BERLAKU
71	PT. MALANG INTERMEDIA PERS	Pelayanan Publikasi dan penerbitan artikel	166/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	423/MOU/PMSRN/JPRM/VIII/2023	1/9/2023	1/2/2024	BERLAKU
72	PT. Bangun Sarana Wreksa	Pelayanan Kesehatan					BERLAKU
73	PT. Kasoem Hearing	Pelayanan Pemasangan Alat Bantu Mendengar (ABM)	339.6/E- PKS/DIR/III/2022	002/KHC/KSO-SMAD/III/2022	1/3/2022	1/3/2024	BERLAKU
74	PT. MALANG INTERMEDIA PERS	Pelayanan Kesehatan	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020	1/7/2020	1/7/2025	BERLAKU
75	PT. TASPEN	Perawatan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E-PKS/DIR/2023	JAN-01/DIR/2023	1/1/2023	31/12/2025	BERLAKU
76	PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Bagi Karyawan Dan Keluarga	004/DPM/E-PKS/III/2020	452/YMPI/HI/PKS/III/2020	1/6/2020	1/6/2025	BERLAKU
77	PT. TSSA dan PT. Tenang Sejahtera	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah	060.1/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	176/TSA-MOU/MD/II/2023	21/02/2023	21/02/2024	BERLAKU

		Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
78	PT. KSI	Pelayanan Kesehatan					BERLAKU
79	PT. Samator	Operasional Pasokan Produk		DISTRIBUTIONAGREEMENT_LGL_1850	1/9/2022	1/9/2027	BERLAKU
80	Harris Hotel & Conventions Malang	Rujuka Pelayanan Kesehatan	308/E-PKS/PMS/V/2018	001/IKS/HR/V/2018	14/10/2019	Perpanjang Otomatis	BERLAKU
81	PT. Ajinomoto Sales Indonesia	Pelayanan Pengobatan dan Perawatan Kesehatan	008/PERS/RSPH-I/2012	LEG/ASI/120510-85	1/5/2012	perpanjang otomatis	BERLAKU
82	PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	Pelayanan Kesehatan	573/I-PKS/PMS/IV/2019	004/Perjanjian/HRSEJ/IX/2019	1/9/2019	perpanjang otomatis	BERLAKU
83	PT. DUHA MULYA ABADI	Penyediaan paket BHP Operasi Katarac			1/11/2019		BERLAKU
84	PT. Indolakto Pandaan	Jasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja (PPK)			10/1/2014	perpanjang otomatis	BERLAKU
85	PT. KTG (KENCANA TIARA GEMILANG)	Pelayanan Kesehatan	174.1/DPM/E-PKS/DIR/XII/2021	017/KTG/HRGA.06/XII/2021	12/12/2021	12/12/2024	BERLAKU
86	PT. Sumber Alfaria	Pelayanan Kesehatan	142.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	0002/SDM-MLG/VI/2023	22/06/2023	22/06/2026	BERLAKU
87	PT. ETERCON PHARMA	Sponsorship Maternity Kit Free untuk pasien	132.1/DPM/E-PKS/DIR/VI/2023	039/ETC-CBX/PKS/VII/2023	1/6/2023	1/6/2024	BERLAKU

		Maternitas					
88	PT. RENTOKIL	Pengendalian Hama dengan Program General Pest (GP)- Non Station	173.1/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	003/PT.RI/MLG- 37/52400326/IX/2023	11/9/2023	11/9/2024	BERLAKU
89	PT. UNIPLASTINDO INTERBUANA	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	302/DPM/I- PKS/DIR/VI/2021	001/PKS-IU-HRD/VI/2021	8/6/2021	8/6/2024	BERLAKU
90	PT. TSSA (Teman Sejati Sejahtera Abadi)	Pengelolaan Limbah B3	0175/LGL-PK/DPM- TSSA-AMP/II/2023		6/2/2023	6/2/2024	BERLAKU
91	PT. NAYAKA ERA HUSADA	Pelayanan Kesehatan	143.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	PKS/106/072023	30/05/2023	30/05/2025	BERLAKU
92	PT. DELAPAN BERUANG MADU (BEETU)	Layanan Antar Obat Pasien	138.2/DPM/E- PKS/DIR/VI/2023	003/PKS/V/PT.DISAPRIMAMEDIKA/ MLG/23-24	15/06/2023	15/06/2024	BERLAKU
93	PT. Global Trans Jaya Mulia	Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	060.2/DPM/E- PKS/DIR/II/2023	037/SPH-T/DPM-GTJM/BSJ/IV/2023	1/4/2023	31/03/2024	BERLAKU
94	PMI Kabupaten Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	768/E-PKS/DIR/V/2023	0	1/6/2023	1/6/2024	BERLAKU
95	RS LAVALETTE	Rujukan Asuhan	155.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	RSL-KONTR-PKS/VII/23.124	10/8/2023	10/8/2025	BERLAKU

		Pasien & Penunjang					
96	RS. TK.II dr. SOEPRAOEN (RST)	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang	152.40/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	PKS/173/IX/2022	16/09/2022	15/09/2024	BERLAKU
97	RS SAHABAT	Rujukan Asuhan Pasien & Penunjang	1097.1/E.PKS/DIR/VIII/2 021		2 Desember 2016	perpanjang otomatis	BERLAKU
98	RSU MUHAMMADIYAH (RSUMM)	Pelayanan Rujukan Kesehatan, Laboratorium dan Radiologi	159.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	100/SK_PKS/RSU-UMM/VII/2023	21/08/2023	21/08/2024	BERLAKU
99	RS Persada	Pelayanan Kesehatan, Rujukan, Laboratorium dan Radiolog	152.42/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.Hs/MOU/X/PH.2022	10/10/2022	10/10/2027	BERLAKU
100	PT. ASURANSI DAYIN MITRA TBK		003/MKT/HLT/PKS/I/201 5	PH/IKS/269/XII/2014	5/1/2015	perpanjang otomatis	BERLAKU
101	PT. PILLAR UTAMA CORTINDO	Vendor Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Elevator	-	KS/PUCCSBY-1216/VII/2023	1/7/2023	30/06/2024	BERLAKU
102	Klinik Siaga Medika	Rujukan Pelayanan Kesehatan	188/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	14.30/KSM/VII/2023	3/10/2023	3/10/2026	BERLAKU
103	Solaris Hotel	Rujukan Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	108/HRD/SHM/X/2023	1/11/2023	1/11/2026	BERLAKU
104	PT. ASURANSI JIWA BCA	Asuransi Pemberian Pelayanan	149/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	286/PKS/BCAL-PHMS/2023	10/10/2023	10/10/2028	BERLAKU

		Kesehatan					
105	PT. ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	Pelayanan Rujukan kesehatan	138.3/DPM/E- PKS/DIR/VII/2023	-	15/06/2023	15/06/2026	BERLAKU
106	BPJS KESEHATAN	Pelayanan Penjamin Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program JKN	1769/E- PKS/DIR/XII/2022	454/KTR/VII-05/1222	1/1/2022	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI BPJS
107	PMI Kota Malang	Pelayanan Darah Transfusi Bagi Pasien Peserta BPJS & Asuransi lainnya	1164/02.06.28/UDD/PKS /X/2021		01 Januari 2022	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI PMI
108	RS ISLAM UNISMA MALANG	Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah	1097.1/E- PKS/DIR/VIII/2021	57/PKS/RSI-4/X1/2021	2/8/2021	31/12/2023	PROSES DISPOSISI DI UNISMA
109	DINKES Kabupaten Malang	Pelaksanaan Kegiatan Skrining Tuberkulosis Pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Radiologis	1183/E- PKS/DIR/VII/2023	415.4/61/35.07.103/2023		31/12/2023	PROSES PERMOHONAN
110	Meditap (PT	Asuransi					PROSES

	TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA)	Pelayanan Keshatan					PERPANJANGAN/PEMBA HARUAN PKS
111	PT. Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	Perjanjian Pelayanan Kesehatan					PROSES TTD DILUAR
112	BPM Yuniarti	Rujukan Asuhan Pasien					PROSES TTD DILUAR
113	Asuransi Jiwa Generali	PKS Asuransi Kesehatan					PROSES DISPOSISI SIM
114	ASABRI	PELAYANA N PENGOBAT AN DAN PERAWATA N PROGRAM JAMINAN KECELAKA AN KERJA BAGI PESERTA ASABRI AKTIF					PROSES DISPOSISI SIM
115	Klinik Simpang Sulfat	Rujukan Asuhan Pasien					PROSES DISPOSISI SIM
116	CV. Galaxy Mulia Cahaya	PKS Alat Protesa Ortesa					PROSES DISPOSISI SIM